UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

CARMEM CAMPOS PEREIRA

DETERMINANTES DE ESTRUTURA DE CAPITAL NO SETOR DE SAÚDE DO BRASIL

SÃO PAULO

2024

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DA UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Carmem Campos Pereira

DETERMINANTES DE ESTRUTURA DE CAPITAL NO SETOR DE SAÚDE DO BRASIL

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie como requisito parcial à obtenção do título de Doutora em Administração de Empresas.

Orientador: Prof. Dr. Wilson Toshiro Nakamura

SÃO PAULO

2024

P436d Pereira, Carmem Campos.
Determinantes de estrutura de capital no setor de saúde do Brasil. [recurso eletrônico] / Carmem Campos Pereira.
1 KB ; il.

Tese (Doutorado em Administração de Empresas) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2025.
Orientador: Prof. Dr. Wilson Toshiro Nakamura.
Bibliografia: p. 125-136

1. Estrutura de capital ótima. 2. Operadoras de planos de saúde. 3. Agência Nacional de Saúde Suplementar. I. Nakamura, Wilson Toshiro, *orientador*. II. Título.

Bibliotecária Responsável: Aline Amarante Pereira - CRB 8/9549

Folha de Identificação da Agência de Financiamento

Autor: Carmem Campos Pereira

Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Administração de Empresas

Título do Trabalho: DETERMINANTES DE ESTRUTURA DE CAPITAL NO SETOR DE SAÚDE DO BRASIL

O presente trabalho foi realizado com o apoio de [1]:

☐ CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

☐ CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

☐ FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

☐ Instituto Presbiteriano Mackenzie/Isenção integral de Mensalidades e Taxas

☐ MACKPESQUISA - Fundo Mackenzie de Pesquisa

☐ Empresa/Indústria:

☐ Outro:

[1] **Observação**: caso tenha usufruído mais de um apoio ou benefício, selecione-os.

Carmem Campos Pereira

Determinantes da Estrutura de Capital no Setor de Saúde do Brasil

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie como requisito parcial à obtenção do título de Doutora em Administração de Empresas.

Aprovado em 06 de fevereiro de 2025

BANCA EXAMINADORA

Documento assinado digitalmente
gov.br
WILSON TOSHIRO NAKAMURA
Data: 01/03/2025 12:38:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prof. Dr. Wilson Toshiro Nakamura
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Documento assinado digitalmente
gov.br
DENIS FORTE
Data: 01/03/2025 16:26:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prof. Dr. Denis Forte
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Documento assinado digitalmente
gov.br
DOUGLAS DIAS BASTOS
Data: 03/03/2025 23:52:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prof. Dr. Douglas Dias Bastos
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Documento assinado digitalmente
gov.br
EDSON DE OLIVEIRA PAMPLONA
Data: 04/03/2025 10:53:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prof. Dr. Edson de Oliveira Pamplona
UNIFEI -Universidade Federal de Itajubá

Prof. Dr. Roberto Frota Decourt
Unisinos - Universidade do Vale do Rio dos Sinos

Documento assinado digitalmente
gov.br
ROBERTO FROTA DECOURT
Data: 05/03/2025 16:47:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Este trabalho representa a conclusão de uma jornada de aprendizado e persistência. Acredito que não se tratou apenas de alcançar um objetivo, mas de caminhar com constância mesmo quando o caminho parecia incerto. A busca pelo conhecimento foi, muitas vezes, um ato de superação. Esta foi minha forma de reconhecer como acertada a decisão de continuar sempre, de enfrentar cada página em branco e cada questionamento com a determinação de evoluir do ponto de vista acadêmico. Foi, acima de tudo, um compromisso comigo mesma, um processo de transmutação, tornar-me quem me tornei, respeitando um passo de cada vez.

AGRADECIMENTOS

Acima de tudo, agradeço a Deus pela oportunidade, que a mim foi concedida, em percorrer os caminhos da sabedoria, do conhecimento e do contínuo aprendizado.
Quero agradecer ao meu orientador, professor Dr. Wilson Nakamura que com sua extraordinária experiencia e competência me guiou firmemente nesta jornada.
Agradeço ao meu grande pai Sr. José Alves Pereira, que me ensinou desde muito pequena que somente os estudos me levariam ao verdadeiro crescimento e liberdade.
Agradeço à minha mãe querida, Dona Anaide, pelo amor, dedicação, companheirismo e pela maravilhosa família que ela conduz.
Agradeço ao meu amado filho Joao Victor, e ao meu Joaozinho por compreenderem a minha ausência.
Agradeço a minha querida irmã Katia, minha Sobrinha Carolina, meu cunhado Gilberto, minha nora Daiane e meu primo Regis pela colaboração, incentivo e admiração de vocês.
Agradeço aos professores do Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em especial ao meu orientador professor Wilson, ao coordenador Professor Bido, Professores Denis, Eli, Leonardo, Michele, Malu, que com seus ensinamentos, aulas inspiradoras e convivência, me elevaram a outro patamar cultural e acadêmico.
Agradeço a todos os outros professores e colaboradores do Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, por todo o apoio neste projeto.
Agradeço aos meus companheiros de ensino, pesquisa, sala de aula, seminários, coautores de artigos, modelos econométricos, em especial ao Professor Dr. Johnny Mendes, Claudia Lebre, Paulo Knupp, e a querida Ana Gabriela Lima, vocês foram fantásticos.

RESUMO

Esta pesquisa investiga os determinantes da estrutura de capital das Operadoras de Planos de Saúde (OPS) no Brasil, explorando como variáveis setoriais específicas e condições financeiras que moldam suas decisões de alavancagem. Utilizando dados de 2018 a 2023, analisados à luz das teorias de *trade-off*, *pecking order* e Teoria da Agência, a tese propõe um modelo que considera variáveis dependentes de alavancagem, variáveis independentes de interesse específicas do setor e variáveis de controle. Os resultados buscam identificar indicadores que satisfaçam tanto as demandas regulatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) quanto as expectativas de investidores e acionistas. As análises mostram que a sinistralidade influencia positivamente o endividamento em alguns cenários, enquanto a tangibilidade dos ativos reforça a capacidade de acesso a crédito de longo prazo. Por outro lado, o Retorno sobre Ativos (ROA) está negativamente associado à alavancagem, em conformidade com a teoria de *pecking order*. Adicionalmente, a pesquisa explora diferenças entre modelos de negócios, evidenciando que operadoras odontológicas apresentam maior alavancagem em função de margens operacionais mais robustas e menor risco assistencial. Os achados contribuem para o entendimento das dinâmicas financeiras no setor de saúde suplementar, fornecendo subsídios para gestores e reguladores na formulação de estratégias e políticas econômicas que promovam a sustentabilidade das OPS. Além disso, reforçam a importância de abordagens teóricas integradas e de análises empíricas que considerem as especificidades do setor regulado da saúde no Brasil.

Palavras-chave: Estrutura de Capital Ótima; Operadoras de Planos de Saúde; Agência Nacional de Saúde Suplementar.

ABSTRACT

This research investigates the determinants of the capital structure of Brazilian Health Plan Operators (OPS), exploring how specific sector variables and financial conditions shape their leverage decisions. Using data from 2018 to 2023, analyzed through the lenses of the *trade-off*, *pecking order*, and Agency theories, the thesis proposes a model incorporating leverage-dependent variables, sector-specific indicators, and control variables. The findings aim to identify metrics that meet both the regulatory demands of the Brazilian National Regulatory Agency for Private Health Insurance and Plans (ANS) and the expectations of investors and stakeholders. The analyses reveal that claims ratio positively influences leverage in some scenarios, while asset tangibility strengthens the capacity to access long-term credit. Conversely, the Return on Assets (ROA) is negatively associated with leverage, consistent with the *pecking order* theory. Additionally, the study explores differences between business models, showing that dental plan operators have higher leverage due to stronger operational margins and lower claims risk. The findings contribute to understanding the financial dynamics within the supplementary health sector, providing insights for managers and regulators to formulate strategies and economic policies that foster OPS sustainability. Moreover, they underscore the importance of integrated theoretical approaches and empirical analyses that consider the specificities of Brazil's regulated health sector.

Keywords: Optimal Capital Structure; Health Plan Operators; Brazilian National Regulatory Agency for Private Health Insurance and Plans.

LISTA DE FIGURAS

Figura 01. A Proposição II de Modigliani e Miller

Figura 02. Quadro de regulamentações complementares, período de 1999 a 2000

Figura 03. OPS na modalidade Medicina de Grupo acima de 500 mil beneficiários, apurados em setembro de 2024

Figura 04. OPS na modalidade Cooperativa Médica acima de 500 mil beneficiários, apurados em setembro de 2024

Figura 05. OPS na modalidade Seguradora Especializada em Saúde acima de 500 mil beneficiários, apurados em setembro de 2024

Figura 06. OPS na modalidade Autogestão em Saúde acima de 500 mil beneficiários, apurados em setembro de 2024

Figura 07. Segmentação do Mercado de Saúde Suplementar

Figura 08. Taxas de cobertura de assistência médica por Unidades da Federação em 2009

Figura 09. Taxas de cobertura de assistência médica por Unidades da Federação em 2024

Figura 10. Mapa de HHI dos mercados relevantes geográficos

Figura 11. Os atributos mais importantes dos planos de saúde, de acordo com levantamento feito pela ANAB em 2021 junto a beneficiários de planos de saúde

LISTA DE TABELAS

Tabela 01. Síntese de variáveis independentes utilizadas no estudo do ciclo de vida das empresas face às teorias de *trade off* e *pecking order*

Tabela 02. Hipótese / Referência / Descrição de Hipótese - *trade-off* x *pecking order*

Tabela 03. Levantamento de Bragança (2017) - Trabalhos realizados entre 2003 e 2012

Tabela 04. Levantamento de Bragança (2017) - Trabalhos realizados entre 2013 e 2016

Tabela 05. Levantamento de Bragança (2017) - Trabalhos realizados entre 1998 e 2016

Tabela 06. Levantamento bibliográfico acerca das OPS e indicadores financeiros relevantes - 2006/2009

Tabela 07. Levantamento bibliográfico acerca das OPS e indicadores financeiros relevantes - 2010/2020

Tabela 08. Levantamento bibliográfico Operadoras de Saúde - parte 1

Tabela 09. Levantamento bibliográfico Operadoras de Saúde - parte 2

Tabela 10. Levantamento bibliográfico Operadoras de Saúde - Marcos Históricos

Tabela 11. Levantamento bibliográfico Operadoras de Saúde - Posição das OPS no Setor Regulado da Saúde no Brasil

Tabela 12. Levantamento bibliográfico Operadoras de Saúde - Gestores

Tabela 13. Levantamento bibliográfico Operadoras de Saúde - Desempenho Financeiro das OPS

Tabela 14. Levantamento bibliográfico Operadoras de Saúde - Estrutura de Capital das OPS e Impacto da ANS

Tabela 15. Categorias de análise recorrentes nos estudos sobre Estrutura de Capital

Tabela 16. Abordagens teóricas encontradas nos trabalhos levantados

Tabela 17. Métodos de análise encontrados nos trabalhos levantados

Tabela 18. Variáveis analisadas nos trabalhos levantados

Tabela 19. Indicadores analisados nos trabalhos levantados

Tabela 20. Classificação WebQualis dos periódicos em que se encontram os artigos levantados e total de artigos por periódico

Tabela 21. Levantamento bibliográfico: impacto da pandemia no desempenho financeiro das OPS

Tabela 22. Linha do Tempo de Políticas e Planos de Saúde no Século XX

Tabela 23. Comparativo de subsistemas de saúde

Tabela 24. Beneficiários de planos privados de saúde, por cobertura assistencial (Brasil, 2014-2024)

Tabela 25. Gasto público em saúde como porcentagem do gasto total em saúde dentre os países com sistemas de saúde similares

Tabela 26. Taxa de crescimento (%) do número de beneficiários em relação a dezembro do ano anterior (Brasil, 2014-2024)

Tabela 27. Operadoras com beneficiários no período entre 2014-2024

Tabela 28. Receita de contraprestações das OPS (em R$) entre 2014-2024

Tabela 29. Beneficiários de planos privados de saúde, por cobertura assistencial, no período 2012-2022

Tabela 30. Beneficiários de planos privados de saúde, por época de contratação do plano, segundo cobertura assistencial e tipo de contratação do plano (Brasil, junho/2022)

Tabela 31. Taxa de crescimento (%) do número de beneficiários em relação a dezembro do ano anterior, período de 2012-2022

Tabela 32. Estratégias financeiras

Tabela 32. Novos papéis atribuídos às operadoras necessários para a criação de valor

Tabela 34. Fórmula dos Indicadores de Estrutura de Capital

Tabela 35. Recorte da amostra da pesquisa

Tabela 36. Variáveis Dependentes: Alavancagem (Lev)

Tabela 37. Variáveis Independentes de Interesse e Controle

Tabela 38. Estatística Descritiva

Tabela 39. Matriz de correlação de Pearson

Tabela 40. Modelo Econométrico com dados em Painel

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 01. Gastos com saúde, percentual do Produto Interno Bruto (PIB) e proporção de despesas públicas e privadas no Brasil (2000-2017)

Gráfico 02. Principais despesas da União em 2022 (em $bilhões)

Gráfico 03. Despesas não obrigatórias por setor

Gráfico 04. Resultado Líquido (acumulado no ano de 2024)

Gráfico 05. Sinistralidade (acumulado no ano de 2024)

Gráfico 06. Recebimentos de pagamento dos beneficiários (contraprestações), valores pagos a fornecedores e prestadores assistenciais e sinistralidade de caixa, com dados trimestrais

Gráfico 07. Inadimplência de planos com preço preestabelecido (apurada no mês de cobertura)

Gráfico 08. Inadimplência de planos com preço preestabelecido por tipo de contratação (apurada no mês de cobertura)

Gráfico 09. Operadoras de planos privados de saúde em atividade (Brasil, 2001-2013)

Gráfico 10. Operadoras de planos de saúde por porte

Gráfico 11. Receitas e Despesas das OPS por porte em 2013

Gráfico 12. Distribuição dos beneficiários de planos privados de assistência médica coletivos entre as operadoras (Brasil, junho/2014)

Gráfico 13. Beneficiários de Planos de Saúde (milhões) e Penetração (%) - período de 2014 a 2017
Gráfico 14. Tipos de Planos de Saúde (Brasil, 2017)
Gráfico 15. Beneficiários de planos privados de saúde, por cobertura assistencial (Brasil, 2008-2018)
Gráfico 16. Beneficiários de planos privados de saúde, por cobertura assistencial (Brasil, 2008-2018)
Gráfico 17. Empresas de saúde na bolsa entre as mais valiosas
Gráfico 18. Crescimento orgânico
Gráfico 19. Estrutura Ótima de Capital de acordo com a Teoria da Agência

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ANAB - Associação Nacional das Administradoras de Benefícios;
ANS - Agência Nacional de Saúde;
ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária;
CADE - Conselho Administrativo de Defesa Econômica;
CADOP - Sistema de Cadastro de Operadoras;
CAPM - Modelo de Precificação de Ativos de Capital;
CBR - Capital Baseado em Riscos;
CEIS - Complexo Econômico Industrial da Saúde;
CONSU - Conselho de Saúde Suplementar;
CR - Capital Regulatório;
CVM - Comissão de Valores Mobiliários;
DIOPS - Documento de Informações Econômico-Financeiras das Operadoras;
DIOPS - Documento de Informações Periódicas das Operadoras;
HHI - Herfindal-Hirschman;
IAPs - Institutos de Aposentadorias e Pensões;
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística;
IDDS - Índice de Desempenho da Saúde Suplementar;
IDSS - Índice de Desempenho da Saúde Suplementar;
IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada;
MS - Ministério da Saúde;
OMS - Organização Mundial de Saúde;
OPS - Operadoras de Plano de Saúde;
PPCNG - Provisão para Prêmios ou Contraprestações Não Ganhas;
PQO - Programa de Qualificação Operacional;
RDC - Resolução da Diretoria Colegiada;
ROA - Retorno sobre Ativos;
ROE - Return on Equity;
SIB - Sistema de Informações de Beneficiários;
VOPS - Variáveis das Empresas Operadoras de Saúde.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 15

1.1. AMBIENTE ACADÊMICO DA PESQUISA 16

1.1.1. O TEOREMA DE MODIGLIANI E MILLER 17

1.1.2. TRADE-OFF THEORY 18

1.1.3. PECKING ORDER THEORY 19

1.1.4. TRADE-OFF X PECKING ORDER 19

1.2. PROBLEMA E QUESTÕES DE PESQUISA 21

1.3. JUSTIFICATIVA 22

1.4. OBJETIVO 22

1.5. PARADIGMA DA PESQUISA 23

1.6. ESTRUTURA DO TRABALHO 25

1.7. HIPÓTESES E TESE 27

2. REVISÃO DA LITERATURA 28

2.1. PANORAMA DOS TRABALHOS ACADÊMICOS SOBRE OPERADORAS DE SAÚDE 29

2.1.1. CATEGORIAS DE ANÁLISE RELACIONADAS À TEMÁTICA DA TESE 35

2.2. PESQUISA ACADÊMICA SOBRE ESTRUTURA DE CAPITAL 43

2.3. EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 SOBRE O SETOR BRASILEIRO DE PLANOS DE SAÚDE (SBPS) 45

2.3.1. CONTEXTO DA INSTALAÇÃO DA PANDEMIA 45

2.3.2. CONTEXTO NACIONAL 46

2.3.3. DESEMPENHO ECONÔMICO DAS OPERADORAS DE SAÚDE BRASILEIRAS FRENTE À PANDEMIA: SÍNTESE 47

3. MODELOS TEÓRICOS 48

3.1 Marcos do surgimento das Empresas de Planos de Saúde no Brasil 48

3.1.1. Santas Casas de Misericórdia, Beneficências e Institutos de Aposentadoria e Pensões 48

3.1.2. Planos de Saúde Privados no Brasil dos anos 1940 a 1988 49

3.1.3. Planos de Saúde Privados no Brasil entre 1988 e 2000 49

3.1.4. A Transição para a regulação: da Lei N. 9656/1998 ao Início do Funcionamento da ANS em 2001 50

3.1.5. Marcos temporais no Processo de Regulação do Setor de Saúde Brasileiro 52

3.1.6. Conceitos fundamentais na estruturação das Empresas brasileiras do Setor de Saúde a partir da criação da ANS 53

3.1.7. Crescimento da saúde suplementar no Brasil - gastos públicos x gastos privados 61

3.1.7.1 Caracterização dos riscos do mercado de saúde suplementar 64

3.1.7.2 Aspectos econômicos do mercado de saúde suplementar 65

3.1.7.3. Concentração do mercado de planos de saúde 70

3.1.7.4. Evolução da movimentação econômica do setor brasileiro de planos de saúde 74

3.1.7.5. Distribuição geográfica do SBPS - Mercados Relevantes 79

3.2. Caracterização dos atores 81

3.2.1. ANS - Função de Regulação e sua Atuação no Setor Brasileiro de Planos de Saúde 82

3.2.1.1 O ambiente regulatório do setor de saúde 82

3.2.1.2 A Agência Nacional de Saúde 82

3.2.1.3 Objetivos da Agência Nacional de Saúde 85

3.2.1.4 Impacto da regulação na gestão financeira e estrutura de capital das OPS 85

3.2.2. Os investidores e acionistas, representando os interesses privados 86

3.2.3. Aspectos das tomadas de decisão dos gestores sobre as dimensões econômico-financeiras 90

3.3. Modelos Teóricos adjacentes 93

3.3.1. Teoria da Agência 93

3.3.1.1. Observações sobre a adoção, pela ANS, do Capital de Risco 96

3.4. Estrutura de Capital das Empresas Brasileiras do Setor de Planos de Saúde 97

3.4.1. Estrutura de Capital no Contexto da Estrutura Financeira da Empresa 97
3.4.2. Estrutura de Capital da Empresa: indicadores 98
3.4.3. Estrutura de Capital das empresas do Setor Brasileiro de Planos de Saúde 99

4. METODOLOGIA 104

4.1. Amostra, Período e Coleta de Dados 105
4.2. Seleção das Variáveis da amostra da pesquisa 107
4.3. Modelos Econométricos 111

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 114

5.1 Estatística Descritiva 114
5.2 Análise da Matriz de Correlação 116
5.3. Análise dos Modelos Econométricos 117

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 119

6.1. Síntese dos Principais Achados 119
6.2. Discussão Crítica dos Resultados 121
6.3. Contribuições da Pesquisa 122
6.4. Limitações do Estudo 123
6.5. Perspectivas para Pesquisas Futuras 124
6.6. Conclusão 126

7. REFERÊNCIAS 127

1. INTRODUÇÃO

As finanças corporativas são uma área importante a ser estudada nas organizações, pois os recursos devem ser direcionados para investimentos rentáveis que contribuam para a riqueza das mesmas. Tendo em vista que o custo de capital é um grande desafio nas finanças das corporações, o campo da pesquisa acadêmica em finanças concentra-se em estratégias financeiras e custos de capital, abordando diferentes setores do campo empírico em que as organizações atuam. Nesta pesquisa, a atenção é voltada para a questão do custo de capital no contexto do Setor Brasileiro de Planos de Saúde (SBPS), ou, mais especificamente, nos aspectos significativos da Estrutura de Capital destas organizações. O SBPS é indispensável para a garantia de acesso a serviços de saúde ao povo brasileiro, e as organizações que o compõem atuam sob a regulação da Agência Nacional de Saúde (ANS).

A gestão financeira das empresas do SBPS deve atender aos requisitos impostos pela ANS e atender às expectativas de retorno por parte de seus investidores e acionistas. A estrutura de capital ótima no SBPS deve atender às diferentes demandas do poder público, investidores e gestores. Existem diversas teorias de estrutura de capital concorrentes, e a presente pesquisa buscará interpretar os resultados de levantamentos e testes empíricos de dados de empresas do SBPS à luz das teorias de *trade-off*, *pecking order* e teoria da agência. É relevante colocar que, as empresas do SBPS podem ser definidas como organizações que oferecem serviços de saúde a seus beneficiários em troca de pagamentos mensais fixos.

No Brasil, existem oito modalidades de Operadoras de Saúde, que são regulamentadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), cada uma com as suas próprias características e regulamentações específicas, são elas:

- Autogestão: empresas criadas por grupos de funcionários de uma mesma empresa ou instituição para oferecer planos de saúde exclusivos para seus membros;
- Cooperativas médicas: cooperativas formadas por médicos que oferecem serviços de saúde para seus associados;
- Filantropia: instituições sem fins lucrativos que oferecem serviços de saúde para a população carente;
- Medicina de grupo: são empresas que oferecem planos de saúde com uma rede de prestadores de serviços própria;
- Operadoras de planos de saúde: são empresas que comercializam planos de saúde para pessoas físicas e jurídicas;

- Odontologia de grupo: são empresas que oferecem planos odontológicos com uma rede própria de prestadores de serviços;
- Seguradoras especializadas em saúde: são seguradoras que oferecem planos de saúde para pessoas físicas e jurídicas;
- Seguradoras com planos de saúde: são seguradoras que oferecem planos de saúde como um produto adicional aos seus clientes.

Atualmente, o mercado da saúde suplementar é formado por mais de 1.200 empresas, oferecendo planos e seguros privados de assistência médica, hospitalar e odontológica.

A base de dados utilizada para a composição de variáveis de análise desta pesquisa compreende dados anuais de empresas Operadoras de Planos de Saúde (OPS) extraídas da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS - compreendidas nos períodos de 2018 até 2023.

O total de empresas que estão na base ANS são 1.292, deste total fizemos o recorte eliminando empresas com ativos abaixo de um milhão de reais e empresas com o Patrimônio Líquido negativos, chegando a uma amostra final de cerca de 200 empresas.

Todas as variáveis da amostra tanto dependentes quanto independentes foram coletadas com base nos autores seminais na teoria de estrutura de capital, por exemplo, Rajan e Zingales (1995), Welch (2011), Keefe e Yaghoubi (2016), Frank e Goyal (2009; 2022) e Frank e Goyal (2020). Além disso, foram utilizados variáveis de interesse do setor das OPS com o intuito de inovar as pesquisas sobre estrutura de capital, conforme Frank e Goyal (2022) essa busca tem sido um quebra-cabeças desafiador, mas fundamental para as finanças, visto que as imperfeições informacionais desempenham um papel nas decisões de estrutura de capital, assim como, as peculiaridades do setor da empresas OPS, por isso, conclui o autor nenhuma teoria unificada explica adequadamente todos os fatores explícitos e implícitos.

1.1. Ambiente Acadêmico da Pesquisa

Alguns tópicos importantes das ciências financeiras receberam atenção particular, incluindo o teorema da irrelevância da estrutura de capital de Modigliani-Miller (HINDRIKS, U7 2008, apud BRUIN et al., 2020). A hipótese do mercado eficiente (COLLIER, 2011, apud BRUIN et al., 2020); O modelo de precificação de opções Black-Scholes (WEATHERALL, 2017, apud BRUIN et al., 2020); Teoria de portfólio (WALSH, 2015); Modelos de equilíbrio financeiro (FARMER; GEANAKPLOS, 2009, apud BRUIN et al., 2020); Finanças comportamentais (BRAV; HEATONE; ROSENBER, 2004, apud BRUIN et al., 2020). No entanto, muitos

tópicos ainda precisam de atenção dos filósofos, como o conceito de Valor em Risco (VaR), Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM), cópula gaussiana, passeios aleatórios, derivativos financeiros, estudos de eventos, previsão (e big data), volatilidade, custo de capital, os vários índices financeiros, o conceito de insolvência (BRUIN et al., 2020).

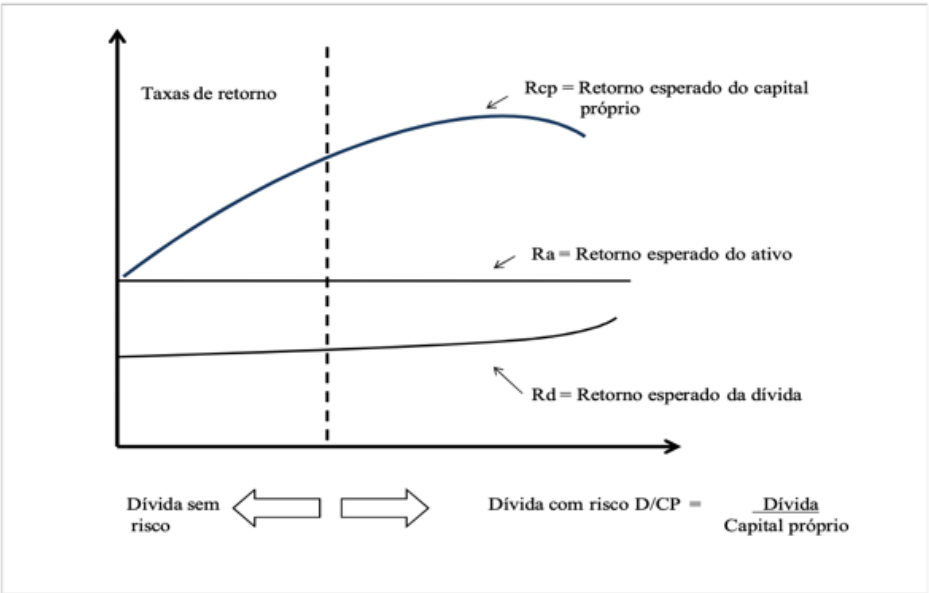
A economia financeira dominante está comprometida com a ideia de que o comportamento do mercado deve ser entendido como o resultado final das interações dos agentes que maximizam sua utilidade esperada. A teoria da estrutura de capital é um eixo conceitual importante, com várias teorias concorrentes explorando a relação entre financiamento de dívida, financiamento de capital e o valor de mercado da empresa de forma ligeiramente diferente. A abordagem da receita líquida e a abordagem do lucro líquido são duas dessas teorias. É importante lembrar que, a estrutura de capital ideal pressupõe uma proporção ótima de dívida e patrimônio, onde o custo de capital está no mínimo e o valor da empresa no máximo (BRUIN et al., 2020; HINDRIKS, 2008; COLLIER, 2011; WEATHERALL, 2017; WALSH, 2015; FARMER; GEANAKOPLOS, 2009; MÄKI, 1997; BRAV et al., 2004; ROSS, 2021).

1.1.1. O Teorema de Modigliani e Miller

A existência de uma estrutura de capital ótima, que maximiza o valor do negócio, é defendida por Durand (1952, apud MACHADO et al. 2015, p. 385), mas é considerada irrelevante por Modigliani e Miller (MILLER, 1958, 1963 apud MACHADO et al., 2015, p. 384). No entanto, estudos posteriores levaram em conta novas variáveis, fortalecendo a ideia de que deve haver uma estrutura ótima de capital a ser perseguida por meio de políticas de longo prazo (MARTIN; NAKAMURA; FORTES, 2005 apud CORREA; BASSO; NAKAMURA, 2013, p. 108). A teoria da estrutura de capital de Modigliani e Miller abriu caminho para vários estudos na área de finanças corporativas, destacando-se as teorias *Trade-off Theory*, de Myers (1984) e *Pecking Order Theory* de Myers e Majluf (1984) (DAVID; NAKAMURA; BASTOS, 2009).

As teorias de estrutura de capital são empregadas em estudos sobre o financiamento das atividades de operadoras de saúde, explorando a relação entre financiamento de dívida, financiamento de capital e o valor de mercado da empresa. A teoria de Modigliani e Miller sugere que a taxa entre dívida e patrimônio é irrelevante no custo do capital, mas estudos posteriores estabeleceram quais fatores determinam a estrutura de capital das companhias (CORREA; BASSO; NAKAMURA, 2013).

Figura 01. A Proposição II de Modigliani e Miller



Fonte: Campos, 2008, p. 26

As teorias que mais se destacam neste contexto foram as de *Trade-off* e *Pecking Order*, como será comentado abaixo.

1.1.2. Trade-off Theory

A estrutura ótima de capital pode ser alcançada por meio de uma combinação de capital próprio e capital de terceiros, com o objetivo de maximizar o valor da empresa. A teoria de *trade-off* leva em conta o estabelecimento de uma estrutura meta de capital, para a qual a empresa se direcionaria. Damodaran (2004) defende a existência de uma estrutura de capital ótima derivada do *trade-off* entre benefícios da dívida - por exemplo, benefícios fiscais - e custos da dívida - por exemplo, custos de falência. Myers (2001) afirma que as companhias poderiam incorrer em débito até o ponto em que o valor presente dos custos derivados do endividamento fosse igual ao valor presente dos benefícios gerados pelo débito. Este *break-even point* determinaria a estrutura ótima de capital.

A teoria de *trade-off* baseia-se na ideia de que uma companhia busca a estrutura de capital ótima, em primeiro lugar, ao considerar a razão custo-benefício de cada unidade financeira adicional, e então traçando uma estratégia para equalizar custos e benefícios marginais (CAMPOS, 2008). O principal benefício da dívida em relação ao patrimônio líquido para a empresa é o impacto tributário, ou seja, as despesas com juros são dedutíveis dos impostos. Já os pagamentos de dividendos não são. A teoria de *trade-off* considera que, ainda que fosse

possível determinar a estrutura de capital ótima a partir deste ponto de equilíbrio, diversos exemplos práticos desafiam esta teoria (MYERS, 2001; DAMODARAN, 2004). Em um estudo realizado por Deangelo e Masulis (1980), as empresas que aumentaram seu endividamento apresentaram um retorno médio positivo de 7,6% nos dois primeiros dias seguidos ao anúncio da mudança, ao passo que as empresas que reduziram o endividamento tiveram um retorno negativo de 5,4% no mesmo período.

1.1.3. Pecking Order theory

A teoria de *pecking order* estabelece que as companhias adotam uma hierarquia de recursos, alocando em primeiro lugar os recursos gerados internamente, seguidos pela emissão de novas dívidas. Nesta perspectiva, deve haver uma relação positiva entre o nível de crescimento e o nível de endividamento das companhias (CORREA; BASSO; NAKAMURA, 2013, p. 110). A emissão de novas ações viria por último nesta estrutura hierárquica. O conceito de simetria entre gestores e investidores e acionistas é fundamental nessa teoria, já que o anúncio da emissão de novas ações pode levar os investidores e acionistas a assumir que os gestores estão tomando esta decisão por considerarem que o preço destas ações está supervalorizado. De acordo com Myers (2001), os gestores preferem emitir dívidas por que, considerando que possuem preferência de pagamento no evento de uma falência, as expectativas dos acionistas, no que se refere ao retorno esperado, são mais baixas do que no caso das ações. Portanto, de acordo com a teoria de *pecking order*, os gestores observam a seguinte hierarquia de recursos de financiamento: a. geração de caixa; b. dívida; c. ações. Esta dinâmica sugere uma relação negativa entre a lucratividade de uma companhia e seu endividamento (CORREA; BASSO; NAKAMURA, 2013; MITSUSHIMA; NAKAMURA; ARAÚJO, 2010; CATRIB; BRITTO; SERRANO, 2016).

1.1.4. Trade-Off x Pecking Order

Um fator importante a ser considerado na comparação entre as teorias de *Trade-Off* e *Pecking Order* é o nível de endividamento, ou alavancagem de uma empresa. A literatura apresenta quatro possibilidades para abordar o nível de endividamento: total da dívida a valor de mercado (TDM), total da dívida contábil (TDC), dívida de longo-prazo a valor de mercado (LDM) e dívida de longo-prazo contábil (LDM) (FRANK; GOYAL, 2009). Para Rajan e Zingales (1995), a forma mais apropriada de medir o nível de endividamento é baseada nas dívidas

onerosas de curto e longo prazos em relação ao patrimônio líquido. Berk e DeMarzo (2017) sugerem o cálculo do grau de endividamento considerando a razão entre o total da dívida e o total do patrimônio líquido (Dívida/Patrimônio), o *debt-equity ratio*.

Tabela 01. Síntese de variáveis independentes utilizadas no estudo do ciclo de vida das empresas face às teorias de *trade-off* e *pecking order*

Variável	*Trade off*	*Pecking order*
Tamanho	As empresas maiores possuem endividamento maior, pois são mais diversificas e, por consequência, menor probabilidade de inadimplência[1]	Empresas maiores são mais conhecidas e com maior oportunidade de reter ganhos. O endividamento é menor[2]
Valor colateral dos Ativos	Os ativos tangíveis facilitam a precificação destes e diminuem os custos de dificuldades financeiras, portanto, estabelece uma relação positiva entre ativos tangíveis e endividamento[1]	As empresas com poucos ativos tangíveis estão mais sujeitas à assimetria de informação e, por consequencia, são mais subavaliadas do que as empresas com mais ativos tangíveis, portanto, emitem mais ações o que acarreta numa relação negativa entre alavancagem e ativos tangíveis[4]
Crescimento	Relação negativa por meio da redução do endividamento em função do coinvestimento de *stakeholders*[1]	Empresas com mais investimentos devem acumular endividamento maior[2]
Lucratividade	Empresas com alta rentabilidade utilizam de maior endividamento em função dos impostos e custos de falência[1]	Nas empresas mais rentáveis o endividamento é menor em função da disponibilidade dos recursos internos[2]
Benefícios Fiscais não relacionados a dívidas	Se a empresa possui, em sua estrutura de custos e despesas, gastos que propiciam economia fiscal, o uso de dívidas com este propósito torna-se menos interessante, o que leva a se esperar uma relação negativa entre os níveis de endividamento e as variáveis representativas do atributo[5]	Não evidenciado na teoria
Volatilidade	As empresas que apresentam menor volatilidade em seus resultados deveriam ter um incentivo maior ao endividamento, por enfrentarem menores custos de falência e obterem menores taxas nas operações de crédito	Não evidenciado na teoria
Singularidade	As empresas ao serem liquidadas, geram alto custo para a sociedade (empresas com alto grau de singularidade) e deveriam ser mais conservadoras, evitando o risco de falência e, consequentemente, o endividamento[6]	Não evidenciado na teoria
Risco	O risco é prejudicial para o coinvestimento dos *stakeholders*. Quanto maior o risco, menor a possibilidade de endividamento[1]	Não evidenciado na teoria

Fonte: Reis; Neto, 2014, p. 44-45

Tabela 02. Hipótese / Referência / Descrição de Hipótese - *trade-off* x *pecking order*

Hipótese	Referência	Descrição Hipótese
H1: O nível de endividamento diminui à medida em que há baixa geração de resultados.	Teoria *Trade-off* Myers (1984)	Se há pouca geração de lucro a empresa não se beneficia do impacto dos juros do endividamento nos impostos. Além disto, a disponibilidade de financiamento externo é diminuída e os juros mais elevados.

H2: O nível de endividamento aumenta à medida em que há baixa geração de resultados	Teoria *Pecking order* Myers e Mjluf (1984)	Se a empresa tem pouca geração de lucro precisa se endividar com terceiros para financiar seus investimentos.

Fonte: Pereira; Lebre, 2020

1.2. Problema e Questões de Pesquisa

O problema investigado nesta pesquisa refere-se aos determinantes da **estrutura de capital** das Operadoras de Planos de Saúde (OPS) no Brasil, com foco nos custos associados ao capital próprio e ao capital de terceiros, bem como nos riscos financeiros que influenciam a composição do financiamento dessas empresas. No setor brasileiro de saúde suplementar (SBPS), esses elementos são monitorados de forma rigorosa pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que busca assegurar o equilíbrio econômico-financeiro dos agentes regulados.

Para formular a questão central desta pesquisa, recorre-se ao questionamento proposto por Correa, Basso e Nakamura (2013, p. 108): "Se existe uma estrutura ótima de capital, como vem sendo reafirmado em estudos acadêmicos, quais seriam os principais fatores a determinar como as empresas escolhem seu mix de financiamento?". Esse questionamento é ampliado pela perspectiva de Braga (2017, p. 17), ao explorar como fatores estratégicos, associados à regulação da ANS, interferem na composição da estrutura de capital das empresas do setor de saúde suplementar.

Diante dessas reflexões, e considerando os resultados desta pesquisa, que analisam como variáveis específicas do setor de saúde suplementar – como sinistralidade, reserva técnica, tangibilidade de ativos e retorno operacional (ROA) – impactam a alavancagem das OPS, a pergunta central é refinada para abarcar os seguintes aspectos:

Como as variáveis específicas do setor de saúde suplementar no Brasil, aliadas às premissas regulatórias da ANS e às expectativas de investidores e acionistas, influenciam a determinação de uma Estrutura de Capital Ótima para as Operadoras de Planos de Saúde, garantindo sua sustentabilidade financeira e viabilidade econômica?

Este questionamento reflete a necessidade de compreender como fatores setoriais e regulatórios moldam as decisões financeiras das OPS, equilibrando os custos e benefícios do

endividamento, os riscos operacionais e as expectativas de *stakeholders* em um mercado altamente regulado e essencial para o sistema de saúde no Brasil.

1.3. Justificativa

O substancial corpo de pesquisas produzido sobre o tema "estrutura de capital" ainda não produziu um volume de resultados suficiente para determinar com precisão os procedimentos de escolha, bem como a forma como se dará o financiamento de seus investimentos (capital próprio ou dívida). Pretende-se avaliar as influências da volatilidade da geração de caixa, e da sinistralidade, na estrutura de maturidade das dívidas das empresas de saúde brasileiras. Propõe-se a ampliar as evidências empíricas com novas descobertas que possam trazer mais esclarecimentos sobre as verdadeiras relações entre volatilidade da geração de caixa e estrutura de capital e os efeitos nas empresas do SBPS.

Outra análise relevante tratará de como mensurar o equilíbrio entre investimento e financiamento, algo necessário para ajustar os resultados da empresa. Com efeito, uma dificuldade na administração financeira é ajustar o volume de investimento necessário e compatível em termos de prazos, juros e forma de amortização (PINHEIRO; PELEIAS; SILVA, 2015).

A singularidade das empresas de saúde, a sua relevância para a sociedade, os seus aspectos específicos e a necessidade de garantias, de modo a evitar o risco de falência e consequentes custo altos para a sociedade, considerando o crescimento da indústria no mercado de capitais, justificam aprofundados estudos empíricos sobre os níveis ótimo de endividamento e estrutura de capital. Neste sentido, a contribuição desta tese seria estabelecer a influência das variáveis específicas do setor na relação de alavancagem da indústria de saúde.

1.4. Objetivo

Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar os determinantes da Estrutura de Capital Ótima para empresas do SBPS, confrontando as teorias de *pecking order* e *trade-off* (CORREA; BASSO; NAKAMURA, 2013). Será utilizado o método estatístico *panel data*, a partir de uma amostra de OPS definida a partir dos dados disponíveis no site da ANS, Capital IQ e CVM (15% reduzido).

O objetivo específico desta pesquisa consiste em verificar empiricamente os fatores

determinantes da estrutura de capital das OPS, considerando fatores específicos do setor, como a sinistralidade brasileiras de capital aberto, e os efeitos nas empresas listadas, com ações negociadas na B3 - Bolsa de Valores de São Paulo, no período de 2009-2019 (a década imediatamente anterior à pandemia de Covid-19).

Pretende-se avaliar as influências da volatilidade da geração de caixa, e da sinistralidade, na estrutura de maturidade das dívidas das empresas de saúde brasileiras, como forma de ampliar as evidências empíricas com descobertas que poderão trazer mais esclarecimentos sobre as verdadeiras relações entre a volatilidade da geração de caixa e a estrutura de capital e os efeitos nas empresas do Setor Brasileiro de Planos de Saúde.

Os fatores considerados na análise serão extraídos das principais abordagens teóricas sobre estrutura de capital, como será descrito na seção *"2. Revisão da Literatura"*, quais sejam: rentabilidade, risco, tamanho, tangibilidade e oportunidades de crescimento (BRITTO; SERRANO; FRANCO, 2018, p. 365). Conforme será detalhado na seção *"4. Metodologia"*, para a análise será utilizado o método estatístico *panel data*, a partir de uma amostra de OPs definida a partir dos dados disponíveis no site da ANS, Capital IQ e Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

1.5. Paradigma da Pesquisa

Um paradigma é um pressuposto que sustenta um quadro de referência e as formas da teoria social de operar dentro dele (ARDALAN, 2008). Diferentes conjuntos de suposições "dadas como certas" caracterizam diferentes paradigmas, traçando fronteiras que distinguem diferentes visões da realidade (BURREL; MORGAN, 1979). Com base na perspectiva dos quatro paradigmas das ciências sociais propostos por Burrell e Morgan (2019), a pesquisa acadêmica em finanças tem sido abordada por diferentes iniciativas de pesquisa que chamam os teóricos organizacionais para refletir sobre como os pressupostos ontológicos, epistemológicos e metodológicos têm suas raízes nas teorias das ciências sociais (LAGOARDE-SELOT, 2015; ARDALAN, 2008). A relevância desse argumento posiciona-se em um cenário global contemporâneo mais amplo, em que o capitalismo financeiro está impactando, como nunca antes, a estrutura das sociedades, corporações e a vida dos indivíduos.

A importância da discussão sobre as práticas financeiras e os modos tradicionais de construção do conhecimento está relacionada ao impacto que esses fenômenos produzem nas estruturas sociais, nas corporações e na vida dos indivíduos (BEUNZA et al., 2019). Beunza et al. (2019),

destaca que os mercados financeiros estão ganhando importância, prejudicando as formas de constituição das corporações americanas e a estabilidade da estrutura social. Além disso, o setor de serviços financeiros ainda está se expandindo rapidamente, impactando os setores econômicos e a sociedade (BEUNZA et al., 2019). Beunza et al. (2019), ressalta que teorias e métodos que surgiram nas teorias organizacionais podem ser úteis na compreensão dos fenômenos financeiros. Por sua vez, Ardalan (2008) destaca a importância de reconhecer o papel dos paradigmas no campo das finanças e propõe uma articulação entre a filosofia das ciências sociais e o campo acadêmico das finanças. A construção do conhecimento em finanças implica a adoção de uma abordagem paradigmática na análise de seus fenômenos multifacetados (ARDALAN, 2008). É importante reconhecer que cada comunidade e subcampo de pesquisadores possui suas próprias "culturas epistêmicas", o que cria barreiras entre as diferentes áreas do conhecimento (BENDERSKY; McGINN, 2010).

As teorias em finanças acadêmicas são fundamentadas na filosofia da ciência e nas teorias da sociedade, embora seja comum encontrar trabalhos teóricos em finanças que não reconhecem quais são os pressupostos que fundamentam seu raciocínio (ARDALAN, 2008). Os quatro paradigmas propostos em 1979 por Burrell e Morgan fornecem um mapa para negociar a área temática e permitem que se reconheça como a pesquisa se circunscreve nos domínios desse paradigma, e fora dos outros (BURREL; MORGAN, 2019).

Ardalan (2008) identifica nove principais tendências de pesquisa em finanças, são elas: a teoria do mercado eficiente, teoria do portfólio, teoria de precificação de ativos de capital, teoria de precificação de opções, teoria da agência, teoria dos preços de arbitragem, política de orçamento de capital, política de estrutura de capital e política de dividendos.

Para Ardalan (2008), a abordagem funcionalista é o paradigma dominante nas finanças acadêmicas, enfatizando a visão da sociedade como um conjunto de estruturas articuladas e os indivíduos como atores que realizam suas tarefas de acordo com sua posição nas estruturas e as normas que regulam como as estruturas operam.

Para Bryman e Bell (2015), o paradigma de pesquisa comumente utilizado em pesquisas acadêmicas sobre a estrutura de capital das operadoras de saúde é o paradigma positivista. O positivismo é uma abordagem científica que enfatiza a observação empírica, a mensuração quantitativa e a análise estatística dos dados. Essa abordagem assume que o mundo é objetivo e que a ciência pode descobrir leis universais que governam o comportamento humano e social (BRYMAN; BELL, 2015).

Pesquisas que utilizam o paradigma positivista geralmente envolvem a coleta de dados quantitativos por meio de questionários, entrevistas estruturadas ou análise de documentos. Esses dados são então analisados estatisticamente para identificar relações entre variáveis e testar hipóteses. Um exemplo de pesquisa que utilizou o paradigma positivista para analisar a estrutura de capital das operadoras de saúde, é a de Oliveira e Ferreira (2019), que utilizou dados de 13 empresas listadas na Bolsa de Valores para analisar a relação entre a estrutura de capital e o desempenho financeiro das empresas.

No entanto, alguns pesquisadores argumentam que o paradigma positivista pode ser limitado em sua capacidade de entender o comportamento humano e social em profundidade, especialmente em pesquisas qualitativas. Por esse motivo, algumas pesquisas sobre a estrutura de capital das operadoras de saúde também podem utilizar uma abordagem interpretativa, que enfatiza a compreensão dos significados e das experiências dos indivíduos (DENZIN; LINCOLN, 2011).

Tal apontamento, indica uma limitação enfrentada por este trabalho, a ser desenvolvida em pesquisas posteriores. No caso desta, trata-se de uma pesquisa quantitativa, pois busca compreender a existência de associações entre variáveis, uma vez que utiliza técnicas estatísticas para compreender as relações de dados amostrais e classifica-se como uma pesquisa descritiva, tendo em vista que irá relacionar as variáveis do Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDDS) e da Estrutura de Capital (HAIR JR et al., 2005).

1.6. Estrutura do Trabalho

Tendo em vista a discussão acima apresentada, a proposta de estrutura da tese assume a seguinte configuração:

Capítulo 1: Introdução

Em que são apresentados o contexto em que a pesquisa se insere bem como o ambiente acadêmico ao qual pertence. Descrevem-se sinteticamente as teorias em que se baseiam as análises e interpretações realizadas acerca das OPS brasileiras. São enunciados os problemas e questões de pesquisa e apresentados a justificativa e objetivo do trabalho. Identifica-se ainda o paradigma de pesquisa dentro do qual a investigação é realizada, a estrutura do trabalho e, por fim, as hipóteses que se deseja comprovar e o enunciado da tese.

Capítulo 2: Revisão da Literatura

Na parte dedicada à revisão da literatura, apresenta-se uma discussão sobre o contexto atual da pesquisa acadêmica abordando, por um lado as Operadoras de Saúde e por outro, os estudos sobre Estrutura de Capital. Articulando ambas as dimensões, é analisado o estado atual do debate acerca da Estrutura Financeira e Estrutura de Capital das operadoras de saúde. Por fim, julgou-se imprescindível uma análise sobre a produção acadêmica abordando os efeitos da pandemia de Covid-19 sobre o setor de planos de saúde brasileiros, uma vez que o evento, de proporções mundiais, trouxe impacto importante sobre este setor regulado da atividade econômica no país.

Capítulo 3: Modelos Teóricos

Na terceira seção, referente aos modelos teóricos, são apresentadas discussões consideradas essenciais para a caracterização da atuação das Operadoras de Saúde, bem como de sua dinâmica econômica atual. Em primeiro lugar, realiza-se uma contextualização das operadoras de saúde no sistema de saúde brasileiro, e para tanto, são discutidos marcos temporais fundamentais do desenvolvimento do sistema de assistência à saúde no Brasil. Em seguida, são caracterizados os principais grupos de atores em torno dos quais as dinâmicas econômicas das OPS são estabelecidas e avaliadas, a saber: a ANS, os investidores e acionistas, os gestores. Esta subseção conclui-se com uma análise sobre e articulação das expectativas destes três grupos. Então apresentam-se os modelos teóricos utilizados acerca da Estrutura de Capital, contemplando seu papel no contexto da estrutura financeira da empresa, os indicadores de estrutura de capital e aspectos específicos da Estrutura de Capital das Operadoras de Saúde. Por fim, explana-se um modelo teórico adjacente considerado chave para o entendimento das articulações entre as expectativas dos grupos de atores envolvidos na análise: a teoria da agência.

Capítulo 4: Metodologia

Na seção correspondente à metodologia, descreve-se como as teorias adotadas pela pesquisa serão mobilizadas para efeito de análise dos dados financeiros das OPS selecionadas. Em seguida, são descritos os métodos de levantamento e constituição da base de dados para análise, bem como os materiais, métodos e estratégias de análise propriamente dita.

Capítulo 5: Resultados e Discussão

Nesta seção, são apresentadas as análises e interpretações dos resultados obtidos a partir da aplicação dos modelos econométricos aos dados das OPS, bem como a confrontação destes

resultados frente às teorias de base da pesquisa.

Capítulo 6: Considerações Finais

Nesta seção, são apresentadas a síntese dos resultados obtidos e seus significados face às teorias empregadas e ao paradigma dentro do qual a pesquisa foi desenvolvida. São trazidas também considerações sobre as perspectivas e possibilidades para as quais os resultados deste trabalho apontam.

Capítulo 7: Referências

Nesta parte, são apresentadas as referências bibliográficas e iconográficas utilizadas na pesquisa, sendo livros, periódicos, artigos e websites em português, inglês e espanhol.

1.7. Hipóteses e Tese

Esta pesquisa tem como objetivo principal investigar os determinantes da estrutura de capital das Operadoras de Planos de Saúde (OPS) no Brasil, com ênfase em como variáveis setoriais específicas e características financeiras impactam as escolhas de alavancagem dessas empresas. A fundamentação teórica se apoia nas teorias de *trade-off* e *pecking order*, que oferecem explicações complementares sobre o comportamento das empresas em relação ao financiamento.

A primeira hipótese central é que empresas com maior **sinistralidade**, ou seja, maior proporção de despesas assistenciais em relação às receitas operacionais, apresentam níveis mais elevados de endividamento. Sob a perspectiva da teoria de *trade-off*, espera-se que essas empresas recorram ao crédito como uma solução para financiar operações em cenários de alta pressão financeira. No entanto, também se considera que a sinistralidade pode ter uma relação inversa com o endividamento, conforme sugerido pela teoria de *pecking order*, uma vez que custos operacionais elevados podem limitar a capacidade de acesso ao crédito.

Outra hipótese central desta pesquisa é que empresas com maior **tangibilidade de ativos**, representada pela proporção de ativos fixos em relação ao ativo total, possuem maior capacidade de endividamento. A tangibilidade atua como garantia para credores, facilitando o acesso a financiamentos, especialmente de longo prazo. Esse comportamento estaria alinhado à teoria de *trade-off*, que sugeriria que empresas utilizam ativos tangíveis para equilibrar os benefícios fiscais da dívida com os custos de falência.

A terceira hipótese considera que empresas com maior **retorno operacional (ROA)**

apresentam níveis mais baixos de alavancagem. Segundo a teoria de *pecking order*, essas empresas priorizariam recursos internos, como o lucro operacional, antes de buscar financiamento externo, minimizando os custos associados a assimetrias informacionais.

Além dessas hipóteses centrais, o estudo explora hipóteses secundárias que buscam capturar as especificidades do setor de saúde suplementar. Por exemplo, investiga-se se operadoras com foco em planos odontológicos, devido às suas margens operacionais mais robustas e menor risco assistencial, apresentam maior propensão ao endividamento em comparação às operadoras de planos médicos. Outra hipótese secundária é que a relação entre as **reservas técnicas** e o endividamento varia dependendo do tipo de passivo considerado. Em cenários de altos passivos financeiros, as reservas técnicas podem incentivar o endividamento, mas, na presença de passivos operacionais elevados, essa relação pode se inverter.

Dessa forma, a tese central deste trabalho é que as decisões de estrutura de capital das OPS brasileiras são moldadas pela interação de fatores setoriais, financeiros e regulatórios, que refletem uma coexistência entre as teorias de *trade-off* e *pecking order*. Essa dinâmica é influenciada pelas características únicas do setor, como os altos custos assistenciais, as exigências regulatórias da ANS e as diferenças nos modelos de negócios. Ao testar essas hipóteses em um contexto empírico, a pesquisa busca não apenas confirmar os pressupostos teóricos, mas também oferecer uma visão abrangente das estratégias financeiras das OPS, contribuindo para o debate acadêmico e para a formulação de políticas mais eficazes no setor de saúde suplementar.

2. REVISÃO DA LITERATURA

Nesta seção, é apresentado o levantamento e a análise da literatura relacionada à tese. Inicialmente, discute-se brevemente os resultados de Camargo, Fonseca e Sousa (2024), por possuírem interessantes aproximações com a abordagem da presente tese.

Em seguida abordam-se trabalhos que discutem a solvência e os resultados econômicos das empresas do Setor Brasileiro de Planos de Saúde, bem como os efeitos da regulação da ANS, particularmente com base em Bragança (2017). Na sequência, apresentam-se as categorias de análise utilizadas na tese, como marcos históricos, posição no setor econômico, gestores, desempenho financeiro, Estrutura de Capital e o papel da ANS. Aborda-se a pesquisa acadêmica sobre a Estrutura de Capital. E por fim, contempla-se a literatura sobre os efeitos da

pandemia de Covid-19 no setor de saúde brasileiro.

2.1. Panorama dos trabalhos acadêmicos sobre Operadoras de Saúde

Em "O Endividamento das Operadoras de Planos de Saúde Suplementar por Modalidade e o Contexto Macroeconômico do Mercado Brasileiro" (2024), Camargo, Fonseca e Sousa analisam como variáveis econômicas e financeiras influenciam o endividamento das OPS no Brasil entre 2010 e 2022. Empregando um modelo econométrico com dados em painel, o estudo investiga a relação entre indicadores financeiros internos das OPS e fatores macroeconômicos como taxa de juros, desemprego e inflação, considerando as diferenças de desempenho entre modalidades (como autogestão, filantropia, cooperativa odontológica). Os resultados mostram que tanto variáveis de desempenho econômico quanto fatores macroeconômicos afetam o nível de endividamento, com destaque para as modalidades de administradora de benefícios e odontologia de grupo, que apresentam respectivamente desempenho superior e inferior.

Bragança (2017) realizou um levantamento acerca da pesquisa acadêmica que aborda a solvência e os resultados econômicos de Operadoras de Saúde, bem como o impacto da regulação pela ANS. O autor identifica trabalhos realizados dentro do período de 2003 a 2016, conforme as tabelas abaixo:

Tabela 03. Levantamento de Bragança (2017) - Trabalhos realizados entre 2003 e 2012

Estudos nacionais		
Autores	Título	Ano
Kornis e Rodrigues	A ANS em perspectiva histórica: a trajetória da regulação da saúde suplementar no Brasil - alguns apontamentos.	2003
Vilarinho	A formação do campo da saúde suplementar no Brasil.	
Vieira e Vilarinho	O campo da Saúde Suplementar no Brasil.	2004
Araújo	Regulação do mercado de saúde suplementar no Brasil- barreiras à entrada e à saída de operadoras de planos privados de assistência médica.	
Pinto e Soranz	Planos privados de assistência à saúde - cobertura populacional no Brasil.	
Cruz	Autorização e funcionamento - importância para o mercado de saúde suplementar.	
Sato	A teoria da agência no setor da saúde- o caso do relacionamento da Agência Nacional de Saúde Suplementar com as operadoras de planos de assistência supletiva no Brasil.	2005
Cardoso	Regulação econômica e escolhas de práticas contábeis- Evidências no mercado de saúde suplementar brasileiro.	
Soares	Análise de indicadores para avaliação de desempenho econômico-financeiro de operadoras de planos de saúde brasileiras- uma aplicação da análise fatorial.	2006
Alves	Insolvência financeira de operadoras de planos de saúde- uma investigação empírica.	
Vieira e Costa	O modelo organizacional dos Planos de Saúde Odontológicos no Brasil.	2007
Santos, Malta e Merhy	A regulação na saúde suplementar- uma análise dos principais resultados alcançados.	2008
Leal e Matos	Planos de saúde de assistência médica no Brasil- uma avaliação da regulação econômica dos produtos.	
Salvalaio e Souza	Custos na rede própria de operadora de planos de saúde.	2009
Leal e Matos	Planos de Saúde- uma análise dos custos assistenciais e seus componentes.	
Sampaio, Ignácio e Oliveira	Análise econômico-financeira das operadoras de saúde suplementar através da DEA – Não Arquimediano.	
Sampaio, Oliveira e Ignácio	Análise e classificação das operadoras da saúde suplementar.	
Guimarães e Alves	Prevendo a insolvência de operadoras de planos de saúde.	
Picchiai	Estratégia, estrutura e competências - Três empresas de serviços em saúde.	2010
Veloso e Malik	Análise do desempenho econômico-financeiro de empresas de saúde.	
Guimarães e Nossa	Capital de giro, lucratividade, liquidez e solvência em operadoras de planos de saúde.	
Almeida e Sant'Anna	Composição Probabilística na Avaliação do Risco de Operadoras de Planos de Assistência à Saúde.	
Milan, Preste e Munhoz	Análise do valor do cliente (*lifetime value*) - um estudo ambientado em uma operadora de planos de saúde.	
Bortoluzzi, Lyrio e Ensslin	Avaliação de desempenho econômico-financeiro - uma proposta de integração de indicadores contábeis tradicionais por meio da metodologia multicritério de apoio à decisão construtivista.	
Matos	As transformações da regulação em saúde suplementar no contexto das crises e mudanças do papel do Estado.	
Gerschman, Ugá, Portela e Lima	O papel necessário da Agência Nacional de saúde suplementar na regulação das relações entre operadoras de planos de saúde e prestadores de serviços.	
Lumertz	Avaliação de operadora de plano de saúde - cooperativa médica de assistência à saúde.	
Cardoso, Mendes, Mário, Martinez e Ferreira	Inconsistências de informação contábil e seus efeitos em modelos de previsões de insolvência.	2011
Viana, Vilela, Leão e Oliveira	Um estudo sobre a Insolvência das Operadoras de Planos de Saúde.	2012

Fonte: Bragança, 2017, p. 42-44

Tabela 04. Levantamento de Bragança (2017) - Trabalhos realizados entre 2013 e 2016

Estudos nacionais		
Autores	Título	Ano
Kudlawicz	Um estudo sobre o impacto no nível de rentabilidade das organizações operadoras de planos de saúde em função de seu perfil.	2013
Ferreira	Os determinantes da integração vertical na saúde suplementar segundo a teoria dos custos de transação.	
Amorin	Obrigações Contábeis das Cooperativas operadoras de plano de saúde com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) - uma pesquisa de campo realizada com operadoras do estado de São Paulo e do Mato Grosso do Sul.	
Sancovschi, Macedo e Silva	Análise das Intervenções da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) Através dos Índices de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS).	2014
Barros	Aplicação de Modelos de Previsão de Insolvência nas Operadoras de Planos de Saúde do Brasil.	
Leal	O mercado de saúde suplementar no Brasil- regulação e resultados econômicos dos planos privados de saúde.	
Silva, Famá, Santos, Carneiro e Santos	Gerenciamento de custos em operadoras de saúde de pequeno porte- reflexo nos requisitos de margem de solvência.	
Fernandes, Ferreira e Rodrigues	Análise de rentabilidade utilizando o Modelo Dupont- estudo de caso em uma operadora de planos de saúde.	
Ferrreira, Matos, Matos, Bugarin e Machado	Governança corporativa na saúde suplementar- estudo de caso em uma operadora de plano de saúde.	
Trettel e Leão	Teoria e prática da participação na agência nacional de saúde suplementar.	
Mendes, Cardoso, Mário, Martinez e Ferreira	Previsão de insolvência na presença de dados inconsistentes.	
Pinheiro, Peleias, Silva, Martins	Efeitos da regulação econômico-financeira nas estratégias de financiamento das operadoras de planos de saúde.	2015
Clemente	Práticas administrativas para sustentabilidade financeira de operadoras de planos de saúde médico-hospitalares- um estudo de múltiplos casos.	2016
Alves, Ugá e Portela	Promoção da saúde, prevenção de doenças e utilização de serviços- avaliação das ações de uma operadora de plano de saúde brasileira.	

Fonte: Bragança, 2017, p. 42-44

Tabela 05. Levantamento de Bragança (2017) - Trabalhos realizados entre 1998 e 2016

Estudos internacionais		
Autores	Título	Ano
Frick e Powe	A decisão de cobrir um procedimento em HMOs - Quem faz a chamada?	1998
Rayner	HMOs nos EUA e Grã-Bretanha- uma nova perspectiva para a saúde?	
Browne, Carson e Hoyt	Preditores de insolvências econômica e de mercado na indústria de seguros de vida-saúde.	1999
Baranoff, Sager e Witt	Segmentação da indústria e motivos preditores para análise de solvência da indústria de seguros de vida-saúde.	
Encinosa	A economia dos mandatos regulatórios no mercado de HMO.	2001
Engberg, Wholey, Feldman e Christianson	O efeito das fusões sobre os custos das empresas- evidências da indústria de HMO.	2003
Gross e Harrison	Respostas das HMOs israelenses à mudança ambiental seguindo a Lei Nacional de Seguro de Saúde - Abrindo a caixa preta.	2006
Trottmann, Zweifel e Beck	Compartilhamento de custos do lado da oferta e da demanda no seguro de saúde social desregulado - qual é mais eficaz?	2012
van de Vem, Beck, Buchner, Schokkaert, Schut, Shmueli e Wasem	Pré-requisitos para eficiência e acessibilidade em mercados competitivos de saúde- eles são cumpridos na Bélgica, Alemanha, Israel, Holanda e Suíça?	2013
Harman, Hall, Lemak e Duncan	As redes de serviços de provedor resultam em gastos mais baixos em comparação com HMOs ou gerenciamento de casos de cuidados primários no programa Medicaid da Flórida?	2014
Trish e Herring	Como a concentração do mercado de seguradoras de saúde e o poder de barganha com hospitais afetam os prêmios de seguro de saúde?	2015
Kowalski	Estimativa do compromisso entre proteção de risco e o risco moral com um modelo de orçamento não linear definido de seguro de saúde.	
Wang	Regulação do limite de preços em um mercado de dois lados - consequências previstas e não intencionais.	2016

Fonte: Bragança, 2017, p. 42-44

Dentre os estudos nacionais, destacam-se algumas categorias de abordagem. Em primeiro lugar, a regulação do mercado de saúde suplementar, sobre a qual Kornis e Rodrigues (2003 apud BRAGANÇA, 2017) buscaram contextualizar a criação da ANS como marco regulatório inserido na política de privatização do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, marcado pelas privatizações em diversos setores econômicos. Em segundo lugar, Bragança (2017) destaca a insolvência das OPS, categoria em que o trabalho de Alves (2006 apud BRAGANÇA, 2017) utiliza indicadores financeiros e modelos de análise de solvência ao discutir alternativas ao monitoramento da agência de regulação, os resultados obtidos por estes indicadores sugerem a comprovação de que a solvência das OPS está relacionada ao volume de capital e às reservas técnicas. Em terceiro lugar, estão os estudos sobre os indicadores financeiros relevantes para a compreensão das OPS. Nesse sentido, Kolassa (2021) realizou um levantamento abrangendo o período de 2006 a 2020, que resultou nas tabelas reproduzidas abaixo:

Tabela 06. Levantamento bibliográfico acerca das OPS e indicadores financeiros relevantes - 2006/2009

Autor/Ano	Objetivo
Soares (2006)	Verificou se os indicadores utilizados pela ANS são os mais relevantes para classificar e avaliar o desempenho econômico-financeiro das OPS.
Vieira e Costa (2008)	Utilizaram os indicadores financeiros para investigar a eficiência financeira das operadoras. Os autores dedicaram-se a estudar o modelo organizacional e analisar comparativamente as empresas de planos de saúde odontológicos das modalidades de cooperativas de profissionais e a odontologia de grupo.
Guimarães e Alves (2009)	Propuseram um modelo de previsão de insolvência através da análise do desempenho econômico-financeiro de operadoras de quatro modalidades.

Fonte: Elaborada pela autora a partir de Kolassa, 2021, p. 34-35

Tabela 07. Levantamento bibliográfico acerca das OPS e indicadores financeiros relevantes - 2010/2020

Autor/Ano	Objetivo
Malik e Veloso (2010)	Avaliaram o desempenho econômico-financeiro de empresas da área de Saúde, principalmente sua rentabilidade, comparando hospitais, operadoras de planos de saúde e empresas em geral.
Lima Neto (2011)	Analisou 137 demonstrações financeiras, entre os anos de 2003 e 2008, com o intuito de contribuir para a análise das práticas de administração financeira em hospitais brasileiros por meio do estudo de alguns indicadores econômico-financeiros.
Bonacin e Araújo (2011)	Procuraram descrever as consequências de mudanças operacionais nos indicadores econômico-financeiros de um hospital universitário público entre 1995 e 2004.
Baldassare (2014)	Analisou o desempenho econômico-financeiro de operadoras das modalidades autogestão, cooperativa médica, medicina de grupo e seguradora no período de 2001 a 2012.
Pinheiro *et al.* (2015)	Procuraram identificar o comportamento das estratégias de financiamento adotadas pelas cooperativas médicas e medicinas de grupo frente aos marcos regulatórios da saúde suplementar no Brasil. A pesquisa requereu a análise documental da regulação econômico-financeira, seguida da análise do comportamento dos índices econômico-financeiros a partir do início da regulação, entre 2001 e 2012.
Silva e Lobel (2016)	Propuseram analisar o desempenho econômico-financeiro de 513 operadoras de planos privados de saúde, no período de 2007 a 2014, para identificar o impacto dos fatores Operadora, Ano, Modalidade, Porte e Região na variabilidade do desempenho dessas operadoras.
Barros e Beiruth (2016)	Verificou-se a capacidade de alguns modelos de previsão de insolvência em prever a descontinuidade de OPS brasileiras que foram insolventes no período de 2009 a 2012. Um dos modelos testados foi o de Guimarães e Alves.
Xavier (2017)	Analisaram o desempenho econômico-financeiro das OPS, de diferentes características institucionais
Avelar *et al.* (2019)	Procuraram analisar determinantes de endividamento em operadoras de planos de saúde (OPS) da modalidade autogestão, sob a perspectiva da regulação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
Monteiro, Mariot e De Oliveira Ritta (2020)	Analisaram a situação econômico-financeira de operadora de plano de saúde localizada no sul do Brasil no período entre 2015 e 2018.

Fonte: Elaborada pela autora a partir de Kolassa, 2021, p. 34-35

Em período um pouco mais alargado que o levantamento de Bragança (2017) e Kolassa (2021), começado em 2002, quando foi identificado o primeiro trabalho acerca da temática, e estendendo-se até os dias de hoje, a tabela abaixo apresenta sobreposições em relação ao trabalho de Bragança (2017), representando a seleção dos trabalhos considerados relevantes para esta tese.

Tabela 08. Levantamento bibliográfico Operadoras de Saúde - parte 1

AUT	ANO	TÍTULO
ROCHA, SILVA, BRITTO	2022	Avaliação da condição econômico-financeira de operadoras brasileiras de planos de saúde: uma nota sobre finanças e regulação
ARANOVICH, LEANDRO	2021	Covid-19 e a Nova Concentração do Mercado de Planos de Saúde
ARAUJO, FRANÇA, SILVA, GRECCO	2021	Impacto da Covid-19 na Sustentabilidade Financeira das Operadoras de Planos de Saúde no Brasil
AVELAR, FERREIRA, SILVA, FERREIRA	2021	Efeitos da Pandemia de Covid-19 sobre a sustentabilidade econômico-financeira de empresas brasileiras
CENTRO INTERNACIONAL CELSO FURTADO	2021	Desenvolvimento, saúde e mudança estrutural: o complexo econômico-industrial da saúde 4.0 no contexto da Covid-19
SALVADOR	2021	Empresas de Planos de Saúde no Brasil: crise sanitária e estratégias de expansão
GADELHA, VARGAS, MALDONADO, BARBOSA	2021	O complexo econômico-industrial da saúde no Brasil: dinâmica de inovação e implicações para o Sistema Nacional de Inovação em Saúd
HU, MACIEL	2021	Teto de Reajustes de Preços no Setor de Saúde Suplementar Brasileiro e seus Efeitos sobre a Quantidade Negociada de Planos de Saúde
KOLASSA	2021	Pandemia chegou, e agora? Os impactos nos Indicadores econômico-financeiros nas operadoras de planos de saúde
LESSA	2021	O impacto da crise Covid-19 na relação entre os custos assistenciais e a provisão para ressarcimento ao SUS da OPS com maior número de beneficiários c
OLIVEIRA, MENEZES, RIBEIRO, GONÇALVES, SOUZA	2021	Análise da dinâmica de redes dos atos de concentração econômica em empresas da área de saúde no Brasil
PIRES_CARNUT_MENDES	2021	Saúde Suplementar no Brasil pela economia da saúde: a persistência do pensamento econômico clássico
ROCHA, SILVA, BRITTO	2021	Performance financeira no setor de saúde suplementar: uma análise da variância da rentabilidade das operadoras de saúde no Brasil
FERREIRA, FERREIRA, LAMOUNIER, AVELAR	2021	Fluxos de caixa livres e endividamento em Operadoras de Planos de Saúde
AREIAS, CARVALHO	2021	Reinsurance in the Supplementary Health: a Counterfactual Study on the Impacts of Reinsurance Traties Adoption by Healthcare Plan Operators in Brazil
SILVA	2021	Avaliação do Desempenho das Operadoras de Planos de Saúde com Certificado de Acreditação
REIS, MACEDO, MARQUES	2021	Financial Performance and the decisions to establish special regimes in the Brazilian supplementary health sector
OCKÉ-REIS, SÁ, VIEIRA, SERVO, BENEVIDES, PIOLA	2021	Políticas sociais: acompanhamento e análise
TEIXEIRA, RODRIGUES, LIMA	2021	Economias de Escala na Saúde Suplementar Brasileira: um caminho alternativo para ampliar a lucratividade
TESSER, SERAPIONI	2021	Obstáculos à universalização do SUS: gastos tributários, demandas sindicais e subsídio estatal de planos privados
VIANA	2021	Operadoras de Planos de Saúde: um estudo sobre a Insolvência das Operadoras de Planos de Saúde
CAMPOS, CANABRAVA	2020	O Brasil na UTI: atenção hospitalar em tempos de pandemia
COSTA, BAHIA, CARVALHO, CARDOSO, SOUZA	2020	Oferta pública e privada de leitos e acesso aos cuidados à saúde na pandemia de Covid-19 no Brasil
INÁCIO, CERIBELI, FELIPE, OVÍDIO	2020	Estudo de intenção de doar dinheiro para as Santas Casas de Misericórdia Brasileiras
SANTOS, GABRIEL, MELLO	2020	Sistema único de saúde: marcos históricos e legais dessa política pública de saúde no Brasil
SERRA,TANAKA,SOUZA,TANAKA,SOUZA,FREITAS,MATOS,FERREIRA,PAULACUNHA	2020	Poder da informação e da transparência em cenários de incerteza: estratégia de ação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para enfrentamento da pandemia de
LIMA, SOUZA	2019	Sinistralidade em contratos de plano de saúde médico hospitalar
ALMEIDA, GUERRA	2019	Custos de Formação de preços nas operadoras de planos de saúde no Brasil
AVELAR, SOUZA, AMARAL, REYES	2019	Endividamento de Operadoras de Planos de Saúde da Modalidade Autogestão e Regulação na Saúde Suplementar
AVELAR, BOINA, SOUZA, AMARAL	2019	Endividamento em operadoras de planos de saúde filantrópicas: uma análise dos determinantes na perspectiva da regulação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (A
FALSARELLA Jr.	2019	Estratégias financeiras que colaborem para sustentabilidade de operadoras de saúde filantrópicas brasileiras
GERVÁSIO, AVELAR, VIEIRA	2019	Administração do Capital de Giro de Operadoras de Planos de Saúde: uma análise sob a perspectiva do modelo Fleuriet
AVELAR, SOUZA	2018	Gestão do Capital de Giro em Operadoras de Planos de Saúde: uma análise sob a perspectiva do modelo dinâmico
ARAUJO, SILVA	2018	Análise de tendência da sinistralidade e impacto na diminuição do número de operadoras de saúde suplementar no Brasil
BAHIA	2018	Trinta anos de Sistema Único de Saúde (SUS): uma transição necessária mas insuficiente
OLIVEIRA	2018	Análise dinâmica de redes dos atos de concentração econômica em empresas da área de saúde no Brasil
SESTELO	2018	Planos de saúde e dominância financeira
BRAGANÇA	2017	Liquidação de Operadoras de Planos de Assistência à Saúde no Brasil
BRAGA	2017	Estrutura de capital das Operadoras de Planos de Assistência à Saúde e as Influências do Órgão Regulador
DUARTE, OLIVEIRA, SANTOS, SANTOS	2017	Evolução na utilização e nos gastos de uma operadora de saúde
OLIVEIRA, KORNIS	2017	A política de qualificação da saúde suplementar no Brasil: uma revisão crítica do índice de desempenho da saúde suplementar
VECINA NETO, MALIK	2017	Gestão em Saúde
AZEVEDO, ALMEIDA, ITO, BOARATI	2016	A cadeia de Saúde Suplementar no Brasil: Avaliação de Falhas de Mercado e Propostas Políticas

Fonte: Elaborada pela autora, 2023

Tabela 09. Levantamento bibliográfico Operadoras de Saúde - parte 2

OLIVEIRA	2016	A avaliação da margem de solvência de uma operadora de plano de saúde
BAHIA, SCHEFFER, TAVARES, BRAGA	2016	Das empresas médicas às seguradoras internacionais: mudanças no regime de acumulação e repercussões sobre o sistema de saúde no Brasil
CARMO	2016	Desempenho organizacional de Operadoras de Planos de Saúde Suplementar no Brasil: estudo de caso de uma cooperativa médica
DAROS, GOMES, SILVA, LOPES	2015	A satisfação do beneficiário da saúde suplementar sob a perspectiva da qualidade e integralidade
BARBOSA PINHEIRO, PELEIAS, FERNANDES DA SILVA, MARTINS	2015	Efeitos da Regulação Econômico-Financeira nas Estratégias de Financiamento das Operadoras de Planos de Saúde
BALDASSARE	2014	Análise do desempenho econômico-financeiro de operadoras de planos de saúde no mercado de saúde suplementar brasileiro
SESTELO, SOUZA, BAHIA	2013	Saúde suplementar no Brasil: abordagens sobre a articulação público/privada na assistência à saúde
VICTORA, BARRETO, LEAL,MONTEIRO, SCHMIDT, PAIM, BASTOS, ALMEIDA, BAHIA	2011	Condições de saúde e inovações nas políticas de saúde no Brasil: o caminho a percorrer
MONTEIRO	2010	História da Saúde: Olhares e Veredas
PORTELA, LIMA, UGÁ, GERSCHMAN, VASCONCELLOS	2010	Estrutura e qualidade assistencial dos prestadores de serviços hospitalares à saúde suplementar no Brasil
RIBEIRO, JULIO	2010	Direito e Sistemas Públicos de Saúde nas Constituições Brasileiras
BAHIA	2009	O sistema de saúde brasileiro entre normas e fatos: universalização mitigada e estratificação subsidiada
RIBEIRO	2009	Desenvolvimento do sus e racionamento de serviços hospitalares
SOARES	2009	Avaliação de Indicadores Econômico-Financeiro de Operadoras de Planos de Saúde Brasileiras: uma aplicação da Análise Fatorial
BAHIA	2008	As contradições entre o SUS universal e as transferências de recursos públicos para os planos e seguros privados de saúde
OCKÉ-REIS	2007	Os desafios da ANS frente à concentração dos planos de saúde
OCKÉ-REIS, ANDREAZZI, SILVEIRA	2006	O Mercado de Planos de Saúde no Brasil: uma criação do Estado?
ARAUJO	2004	A Regulação do Mercado de Saúde Suplementar no Brasil: barreiras à entrada e saída de operadoras de planos privados de assistência à saúde
NITÃO	2004	Saúde suplementar no Brasil: um estudo da dinâmica industrial Pós-regulamentação
PINTO, SORANZ	2004	Planos Privados de assistência à saúde: cobertura populacional no Brasil
SANTOS	2003	O setor de planos e seguros de saúde e a saúde do trabalhador: que rumo devemos seguir?
BAHIA	2001	Planos Privados de Saúde: luzes e sombras no debate setorial dos anos 90
NUNES	2000	Sobre a História da saúde pública: idéias e autores

Fonte: Elaborada pela autora, 2023

2.1.1. Categorias de análise relacionadas à temática da tese

A razão pela qual os trabalhos listados na tabela acima são considerados relevantes para esta tese reside nas categorias de análise adotadas, sinteticamente caracterizadas e descritas abaixo. Quais sejam:

- Marcos Históricos: trabalhos que identificam, descrevem e analisam marcos históricos do desenvolvimento do sistema de saúde no Brasil, abrangendo a criação de instituições, marcos legais e as distinções entre os serviços públicos e privados;
- Posição no Setor: trabalhos que discutem a articulação entre os sistemas de atendimento público e privado à saúde no Brasil; trabalhos que discutem o setor econômico regulado da saúde no Brasil;
- Gestores: trabalhos que focalizam a estrutura organizacional das Operadoras de Saúde, o comportamento, visão e papel dos gestores;
- Desempenho Financeiro: Trabalhos que analisam a rentabilidade das OPS no âmbito deste Setor Regulado da Economia, bem como a escala de atividade;
- Estrutura de Capital e a regulação da ANS: trabalhos que analisam o endividamento das empresas de saúde brasileira, suas estruturas de capital bem como os efeitos da regulação da ANS sobre estes aspectos.

Marcos Históricos

Tabela 10. Levantamento bibliográfico Operadoras de Saúde - Marcos Históricos

AUTI	ANO	TÍTULO
PIRES_CARNUT_MENDES	2021	Saúde Suplementar no Brasil pela economia da saúde: a persistência do pensamento econômico clássico
SANTOS, GABRIEL, MELLO	2020	Sistema único de saúde: marcos históricos e legais dessa política pública de saúde no Brasil
BAHIA, SCHEFFER, TAVARES, BRAGA	2016	Das empresas médicas às seguradoras internacionais: mudanças no regime de acumulação e repercussões sobre o sistema de saúde no Brasil
MONTEIRO	2010	História da Saúde: Olhares e Veredas
RIBEIRO, JULIO	2010	Direito e Sistemas Públicos de Saúde nas Constituições Brasileiras
OCKÉ-REIS, ANDREAZZI, SILVEIRA	2006	O Mercado de Planos de Saúde no Brasil: uma criação do Estado?
SANTOS	2003	O setor de planos e seguros de saúde e a saúde do trabalhador: que rumo devemos seguir?
NUNES	2000	Sobre a História da saúde pública: idéias e autores
SESTELO	2018	Planos de saúde e dominância financeira

Fonte: Elaborada pela autora, 2023

Existem duas abordagens principais nos trabalhos sobre a história da saúde no Brasil: a primeira, puramente histórica, busca identificar marcos importantes da evolução dos serviços de saúde no país, e a segunda, analisa a saúde suplementar e a sua articulação com a saúde

pública em termos de investimentos governamentais. Os autores que adotam a primeira abordagem incluem Monteiro (2010), Santos, Gabriel e Mello (2020), Ribeiro e Julio (2010) e Nunes (2000). Os autores que adotam a segunda abordagem incluem Bahia *et al.* (2016), Ocké-Reis, Andreazzi e Silveira (2006) e Santos (2003). Esses trabalhos buscam entender a posição do setor de saúde suplementar e sua relação com o Sistema Único de Saúde, incluindo aspectos de oferta e demanda, regulação e sustentação financeira.

Posição das empresas do setor de planos de saúde no Brasil

Tabela 11. Levantamento bibliográfico Operadoras de Saúde - Posição das OPS no Setor Regulado da Saúde no Brasil

AUT	AN	TÍTULO
HU, MACIEL	2021	Teto de Reajustes de Preços no Setor de Saúde Suplementar Brasileiro e seus Efeitos sobre a Quantidade Negociada de Planos de Saúc
OLIVEIRA, MENEZES, RIBEIRO, GONÇALVES, SOUZA	2021	Análise da dinâmica de redes dos atos de concentração econômica em empresas da área de saúde no Brasil
SILVA	2021	Avaliação do Desempenho das Operadoras de Planos de Saúde com Certificado de Acreditação
TESSER, SERAPIONI	2021	Obstáculos à universalização do SUS: gastos tributários, demandas sindicais e subsídio estatal de planos privados
INÁCIO, CERIBELI, FELIPE, OVÍDIO	2020	Estudo de intenção de doar dinheiro para as Santas Casas de Misericórdia Brasileiras
ALMEIDA, GUERRA	2019	Custos de Formação de preços nas operadoras de planos de saúde no Brasil
BAHIA	2018	Trinta anos de Sistema Único de Saúde (SUS): uma transição necessária mas insuficiente
OLIVEIRA	2018	Análise dinâmica de redes dos atos de concentração econômica em empresas da área de saúde no Brasil
SESTELO	2018	Planos de saúde e dominância financeira
DUARTE, OLIVEIRA, SANTOS, SANTOS	2017	Evolução na utilização e nos gastos de uma operadora de saúde
OLIVEIRA, KORNIS	2017	A política de qualificação da saúde suplementar no Brasil: uma revisão crítica do índice de desempenho da saúde suplementar
AZEVEDO, ALMEIDA, ITO, BOARATI	2016	A cadeia de Saúde Suplementar no Brasil: Avaliação de Falhas de Mercado e Propostas Políticas
DAROS, GOMES, SILVA, LOPES	2015	A satisfação do beneficiário da saúde suplementar sob a perspectiva da qualidade e integralidade
SESTELO, SOUZA, BAHIA	2013	Saúde suplementar no Brasil: abordagens sobre a articulação público/privada na assistência à saúde
VICTORA, BARRETO, LEAL, MONTEIRO, SCHMIDT, PAIM, BASTOS, ALMEIDA, BAHIA et al	2011	Condições de saúde e inovações nas políticas de saúde no Brasil: o caminho a percorrer
PORTELA, LIMA, UGÁ, GERSCHMAN, VASCONCELLOS	2010	Estrutura e qualidade assistencial dos prestadores de serviços hospitalares à saúde suplementar no Brasil
BAHIA	2009	O sistema de saúde brasileiro entre normas e fatos: universalização mitigada e estratificação subsidiada
RIBEIRO	2009	Desenvolvimento do sus e racionamento de serviços hospitalares
BAHIA	2008	As contradições entre o SUS universal e as transferências de recursos públicos para os planos e seguros privados de saúde
PINTO, SORANZ	2004	Planos Privados de assistência à saúde: cobertura populacional no Brasil
BAHIA	2001	Planos Privados de Saúde: luzes e sombras no debate setorial dos anos 90
BRAGA, OLIVEIRA	2022	Dinâmica de capitalismo financeirizado e o sistema de saúde no Brasil: reflexões sob as sombras da pandemia de Covid-19
PIRES_CARNUT_MENDES	2021	Saúde Suplementar no Brasil pela economia da saúde: a persistência do pensamento econômico clássico
BAHIA, SCHEFFER, TAVARES, BRAGA	2016	Das empresas médicas às seguradoras internacionais: mudanças no regime de acumulação e repercussões sobre o sistema de saúde no Brasil
OCKÉ-REIS	2007	Os desafios da ANS frente à concentração dos planos de saúde
OCKÉ-REIS, ANDREAZZI, SILVEIRA	2006	O Mercado de Planos de Saúde no Brasil: uma criação do Estado?
NITÃO	2004	Saúde suplementar no Brasil: um estudo da dinâmica industrial Pós-regulamentação
SANTOS	2003	O setor de planos e seguros de saúde e a saúde do trabalhador: que rumo devemos seguir?

Fonte: Elaborada pela autora, 2023

A posição das empresas de saúde na oferta de serviços de saúde à população brasileira é tema de debate na pesquisa acadêmica. Foram identificados 21 trabalhos dedicados a esta temática entre 2001 e 2021. Três abordagens predominantes foram encontradas: 1. Articulações e tensões entre prestação de serviços de saúde pública e privada; 2. Qualidade dos serviços prestados pelas OPS; 3. Desempenho econômico do setor frente ao contexto brasileiro de acesso à saúde. A primeira abordagem é caracterizada por autores como Tesser e Serapioni (2021), Almeida Guerra (2019), Bahia (2018), Sestelo (2018), Victora et al. (2011) e Ribeiro

(2009), que discutem o sistema duplo de atendimento à saúde. A segunda abordagem é adotada por um número menor de trabalhos, como Silva (2021), Oliveira e Kornis (2017) e Daros et al. (2015), que analisam a qualidade dos serviços prestados pelas OPS. A terceira abordagem, envolvendo o desempenho financeiro das OPS, é abordada por Hu e Maciel (2021), Ocké-Reis, Martins e Drach (2021) e Oliveira et al. (2021). Por fim, um grupo de trabalhos elaborados por Ocké-Reis, Martins e Drach (2021), Oliveira (2018) e Oliveira et al. (2014), estuda o comportamento econômico das OPS na escala dos grupos econômicos que estão por trás da gestão e aquisição destas empresas. Estes trabalhos preocupam-se em entender a qualidade dos serviços prestados pelas OPS, responsáveis por uma proporção significativa da assistência à saúde no Brasil.

Gestores

Tabela 12. Levantamento bibliográfico Operadoras de Saúde - Gestores

AUT	AN	TÍTULO
FALSARELLA Jr.	2019	Estratégias financeiras que colaborem para sustentabilidade de operadoras de saúde filantrópicas brasileiras
VECINA NETO, MALIK	2017	Gestão em Saúde
CARMO	2016	Desempenho organizacional de Operadoras de Planos de Saúde Suplementar no Brasil: estudo de caso de uma cooperativa médica

Fonte: Elaborada pela autora, 2023

Em relação à dimensão dos gestores no desempenho econômico das OPS, poucos trabalhos foram identificados no levantamento realizado para a tese. Pinto (2020), realizou um estudo qualitativo com entrevistas em profundidade com os principais gestores e formadores de opinião de saúde suplementar de diferentes empresas prestadoras de serviços de saúde brasileiras. Falsarella Junior (2019), analisou as estratégias financeiras adotadas por gestores de 43 operadoras de saúde, articulando metodologias qualitativas e quantitativas. Neto e Malik (2017), discutem a profissionalização dos gestores da área da saúde e o efeito dos inibidores organizacionais que resultam em pouco compartilhamento de informações nas empresas. Carmo (2016), buscou detectar o impacto dos elementos organizacionais e ambientais na saúde financeira das OPS a partir da análise do testemunho de gestores de cooperativa médica. Destacam-se as temáticas da formação profissional de gestores da saúde, as estratégias financeiras adotadas por gestores e aspectos ligados à assimetria da informação *versus* externalidades negativas.

Desempenho Financeiro das OPS

Tabela 13. Levantamento bibliográfico Operadoras de Saúde - Desempenho Financeiro das OPS

AUT	AN	TÍTULO	TIPO
ROCHA, SILVA, BRITTO	2022	Avaliação da condição econômico-financeira de operadoras brasileiras de planos de saúde: uma nota sobre finanças e regulação	Artigo de periódico
ROCHA, SILVA, BRITTO	2021	Performance financeira no setor de saúde suplementar: uma análise da variância da rentabilidade das operadoras de saúde no Brasil	Artigo de periódico
AREIAS, CARVALHO	2021	Reinsurance in the Supplementary Health: a Counterfactual Study on the Impacts of Reinsurance Traties Adoption by Healthcare Plan Operators in Brazi	Artigo de periódico
TEIXEIRA, RODRIGUES, LIMA	2021	Economias de Escala na Saúde Suplementar Brasileira: um caminho alternativo para ampliar a lucratividade	Artigo de periódico
LIMA, SOUZA	2019	Sinistralidade em contratos de plano de saúde médico hospitalar	Artigo de periódico
ARAUJO, SILVA	2018	Análise de tendência da sinistralidade e impacto na diminuição do número de operadoras de saúde suplementar no Brasil	Artigo de periódico
BALDASSARE	2014	Análise do desempenho econômico-financeiro de operadoras de planos de saúde no mercado de saúde suplementar brasileiro	Dissertação
SESTELO	2018	Planos de saúde e dominância financeira	

Fonte: Elaborada pela autora, 2023

Sestelo (2018), reconhece na tese de Braga (1985) o início da discussão sobre a financeirização da saúde suplementar no Brasil. Para Braga (1985, apud SESTELO, 2018 p. 104), a dominância financeira iria configurar "um novo padrão sistêmico de definição de riqueza por meio do tripé moeda/crédito/patrimônio". Martins, Ocké-Reis e Drach (2021), em seu artigo *Financeirização dos planos de saúde: o caso das principais operadoras no Brasil*: *2007-2019*, observam por um lado, o maior engajamento das operadoras em investir em ativos financeiros, e, por outro, o fato de que a relevância dos ganhos financeiros para o processo de acumulação das operadoras é baixo, mostrando que o processo de financeirização das OPS ainda não encontrou uma forma finalizada. Em *Providing Value to New Health Technology: The Early Contribution of Entrepreneurs, Investors and Regulatory Agencies* de Lehoux et al. (2017), os autores discutem ainda a interferência dos investidores e acionistas na criação de valor a partir do uso de novas tecnologias no contexto das OPs, modificando a contribuição inicial de empreendedores, investidores e agências reguladoras.

Abordagem da estrutura de capital das OPS e o impacto da regulação da ANS

Com base em um amplo levantamento bibliográfico realizado por Gamarra (2017), que analisou a produção acadêmica sobre a Agência Nacional de Saúde Suplementar, e complementando com o trabalho de Pinheiro et al. (2015) sobre os efeitos da regulação econômico-financeira nas estratégias de financiamento das operadoras de saúde, este estudo busca compreender o impacto da regulação da ANS na estrutura financeira das OPS. Piovesan (2002), apresenta um estudo sobre as condições políticas que interagem na construção da

Agência Nacional de Saúde Pública. Embora as condições das empresas de saúde variem significativamente entre Portugal e Brasil, o trabalho de Machado (2015) sobre a estrutura de capitais do setor da saúde em Portugal é uma referência relevante. Lopes (2018), destaca a escassez de estudos brasileiros sobre a estrutura de capital em empresas do setor de saúde e apresenta sua pesquisa sobre os impactos da assimetria de informação na estrutura de capital em empresas brasileiras do setor de saúde.

Em um levantamento complementar realizado entre abril e setembro de 2022, foram identificados os títulos que constam na tabela abaixo:

Tabela 14. Levantamento bibliográfico Operadoras de Saúde - Estrutura de Capital das OPS e Impacto da ANS

AUT	AN	TÍTULO
FERREIRA, FERREIRA, LAMOUNIER, AVELAR	2021	Fluxos de caixa livres e endividamento em Operadoras de Planos de Saúde
REIS, MACEDO, MARQUES	2021	Financial Performance and the decisions to establish special regimes in the Brazilian supplementary health sector
VIANA	2021	Operadoras de Planos de Saúde: um estudo sobre a Insolvência das Operadoras de Planos de Saúde
AVELAR, SOUZA, AMARAL, REYES	2019	Endividamento de Operadoras de Planos de Saúde da Modalidade Autogestão e Regulação na Saúde Suplementar
AVELAR, BOINA, SOUZA, AMARAL	2019	Endividamento em operadoras de planos de saúde filantrópicas: uma análise dos determinantes na perspectiva da regulação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
GERVÁSIO, AVELAR, VIEIRA	2019	Administração do Capital de Giro de Operadoras de Planos de Saúde: uma análise sob a perspectiva do modelo Fleuriet
AVELAR, SOUZA	2018	Gestão do Capital de Giro em Operadoras de Planos de Saúde: uma análise sob a perspectiva do modelo dinâmico
BRAGANÇA	2017	Liquidação de Operadoras de Planos de Assistência à Saúde no Brasil
BRAGA	2017	Estrutura de capital das Operadoras de Planos de Assistência à Saúde e as Influências do Órgão Regulador
OLIVEIRA	2016	A avaliação da margem de solvência de uma operadora de plano de saúde
BARBOSA PINHEIRO, PELEIAS, FERNANDES DA SILVA, MARTINS	2015	Efeitos da Regulação Econômico-Financeira nas Estratégias de Financiamento das Operadoras de Planos de Saúde
SOARES	2009	Avaliação de Indicadores Econômico-Financeiro de Operadoras de Planos de Saúde Brasileiras: uma aplicação da Análise Fatorial
OCKÉ-REIS	2007	Os desafios da ANS frente à concentração dos planos de saúde
ARAUJO	2004	A Regulação do Mercado de Saúde Suplementar no Brasil: barreiras à entrada e saída de operadoras de planos privados de assistência à saúde
NITÃO	2004	Saúde suplementar no Brasil: um estudo da dinâmica industrial Pós-regulamentação
ROCHA, SILVA, BRITTO	2022	Avaliação da condição econômico-financeira de operadoras brasileiras de planos de saúde: uma nota sobre finanças e regulação

Fonte: Elaborada pela autora, 2023

Na análise destes trabalhos observa-se que os conjuntos de dados são, primordialmente, do tipo secundário, obtidos pelo acesso aos relatórios financeiros e operacionais disponibilizados publicamente pela ANS. Como pode-se verificar na tabela abaixo, as categorias recorrentes de análise nos estudos são, respectivamente: fluxo de caixa; indicadores econômico-financeiros face à regulação da ANS; determinantes de endividamento.

Tabela 15. Categorias de análise recorrentes nos estudos sobre Estrutura de Capital

FLUXO DE CAIXA		
AUTORES	**ANO**	**FOCO DO ESTUDO**
FERREIRA ET. AL	2019	Efeito dos fluxos de caixa livres (*free cash flows)* sobre o endividamento das OPS brasileiras entre 2010 e 2018
GERVÁSIO, AVELAR, VIEIRA	2019	Administração do capital de giro das OPS brasileiras entre 2010 e 2016 sob a ótica do modelo de Fleuriet, ou dinâmico
INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS FACE À REGULAÇÃO DA ANS		
REIS, MACEDO, MARQUES	2021	Indicadores econômico financeiros capazes de explicar a decisão da ANS de instaurar regimes especiais nas OPS - 2017-2019
VIANA	2021	Previsão de insolvência de OPS a partir da análise de indicadores financeiros considerando tipo e localização das OPS
BRAGANÇA	2017	Influência da regulação da ANS a partir da análise de indicadores econômico-financeiros com foco na continuidade da OPS
BRAGANÇA	2017	Influência da regulação da ANS a partir da análise de indicadores econômico-financeiros com foco na margem de solvência estabelecida pela ANS
OLIVEIRA	2016	Influência da regulação da ANS a partir da análise de indicadores econômico-financeiros com foco no perfil da Estrutura de Capital em coop. Médicas
BARBOSA PINHEIRO ET. AL.	2015	Influência da regulação da ANS a partir da análise de indicadores econômico-financeiros com foco no perfil da Estrutura de Capital nas OPS em geral
DETERMINANTES DE ENDIVIDAMENTO		
AVELAR ET. AL.	2019	Determinantes de endividamento em OPS autogestão sob a perspectiva da regulação da ANS
AVELAR, BOINA, AMARAL	2019	Determinantes de endividamento em OPS filantrópicas sob a perspectiva da regulação da ANS
BRAGANÇA	2017	Influência da regulação da ANS na continuidade da OPS

Fonte: Elaborada pela autora, 2023

Abordagens teóricas e métodos de análise

A tabela abaixo ilustra as abordagens teóricas utilizadas nos trabalhos levantados, bem como os seus métodos de análise. Verifica-se que nem todos os trabalhos trazem os enunciados teóricos que fundamentaram as análises realizadas.

Tabela 16. Abordagens teóricas encontradas nos trabalhos levantados

ABORDAGENS TEÓRICAS	
AUTORES	**Abordagem Teórica**
FERREIRA *et al* (2021); AVELAR, BOINA, AMARAL, REYES (2019); BRAGA (2017)	Pecking Order Theory
FERREIRA et al (2021); AVELAR, BOINA, AMARAL, REYES (2019);	Trade Off Theory
BRAGANÇA (2017); BARBOSA PINHEIRO *et al* (2015);	Teoria da Regulação Econômica
BRAGA (2017)	Teoria dos Custos de Falência
OLIVEIRA (2016)	Teoria da Agência

Fonte: Elaborada pela autora, 2023

Tabela 17. Métodos de análise encontrados nos trabalhos levantados

MÉTODOS DE ANÁLISE	
AUTORES	**Método de análise**
FERREIRA *et al (2021);* AVELAR, BOINA, AMARAL, REYES (2019); AVELAR, BOINA, SOUZA E AMARAL (2019); BRAGANÇA (2017); BRAGA (2017); BARBOSA PINHEIRO et al (2015)	**Análises qualitativas:** conteúdo, documental, exploratória, descritiva, explicativa
FERREIRA et al (2021); AVELAR, BOINA, AMARAL, REYES (2019); AVELAR, BOINA, SOUZA E AMARAL (2019); BRAGANÇA (2017); REIS, MACEDO e MARQUES (2021); GERVÁSIO, AVELAR e VIEIRA (2019); BRAGA (2017); BARBOSA PINHEIRO et al (2015)	**Análises quantitativas:** modelos econométricos, testes quantitativos e estatísticos, regressão com dados em painel; regressão logística
AVELAR, BOINA, AMARAL, REYES (2019); AVELAR, BOINA, SOUZA E AMARAL (2019) GERVÁSIO, AVELAR e VIEIRA (2019)	Análises quantitativas e causais
AVELAR, BOINA, AMARAL, REYES (2019)	Análise estatística descritiva

Fonte: Elaborada pela autora, 2023

Estudo de Variáveis

Conforme Bragança (2017) esclarece, as variáveis podem ser agrupadas em qualitativas ou quantitativas. Pertencentes ao primeiro grupo são aquelas que se relacionam com as qualidades do objeto de pesquisa; no segundo grupo encontram-se aquelas que resultam das contagens e/ou mensurações. Nos trabalhos levantados identificam-se as variáveis mais comumente estudadas, conforme tabela abaixo:

Tabela 18. Variáveis analisadas nos trabalhos levantados

ESTUDO DE VARIÁVEIS	
AUTORES	**VARIÁVEL**
FERREIRA et al. (2021); AVELAR, BOINA, SOUZA e AMARAL (2019);	Risco de Falência
FERREIRA et al. (2021)	Fluxo de Caixa
FERREIRA et al. (2021); AVELAR, BOINA, SOUZA e AMARAL (2019);	Crescimento
FERREIRA et al. (2021); AVELAR, BOINA, SOUZA e AMARAL (2019);	Lucratividade
FERREIRA et al. (2021); REIS, MACEDO e MARQUES, (2021); AVELAR, BOINA, SOUZA e AMARAL (2019) (2019)	Rentabilidade
BRAGANÇA (2017); REIS, MACEDO e MARQUES, (2021)	Liquidez
REIS, MACEDO e MARQUES, (2021); OLIVEIRA (2016)	Despesas
AVELAR, BOINA, SOUZA e AMARAL (2019)	Benefícios fiscais não provenientes de dívidas
BRAGA (2017)	Investimento em ativos fixos
BRAGA (2017)	Investimento em sociedades coligadas ou controladas
BRAGA (2017)	Folga financeira
OLIVEIRA (2016)	Sinistralidade
BRAGA (2017)	Capacidade de geração de resultados das atividades assistenciais
OLIVEIRA (2016)	Número de beneficiários
OLIVEIRA (2016)	Ticket Médio por beneficiário
AVELAR, BOINA, AMARAL, REYES (2019)	Proporção de planos antigos operada
AVELAR, BOINA, AMARAL, REYES (2019); AVELAR, BOINA, SOUZA e AMARAL (2019); BRAGA (2017)	Porte
AVELAR, BOINA, AMARAL, REYES (2019)	Idade Média dos beneficiários
AVELAR, BOINA, AMARAL, REYES (2019)	Região de atuação
AVELAR, BOINA, AMARAL, REYES (2019)	Singularidade
BRAGANÇA, 2017	Influência da ANS na continuidade da OPS
BRAGANÇA, 2017	Imobilização

Fonte: Elaborada pela autora, 2023.

Indicadores mais comumente analisados

No que se refere aos indicadores, na tabela abaixo verificam-se aqueles que foram analisados nos trabalhos levantados:

Tabela 19. Indicadores analisados nos trabalhos levantados

ESTUDO DE INDICADORES	
AUTORES	**INDICADOR**
REIS, MACEDO e MARQUES, (2021); BRAGANÇA (2017); BRAGA (2017)	EBITDA
BRAGANÇA (2017)	EBIT
BRAGANÇA (2017)	Margem de Lucro Operacional (MLO)
BRAGANÇA (2017)	Margem de Lucro Líquido (MLL
GERVÁSIO, AVELAR e VIEIRA (2019)	Capital de Giro (CDG)
BRAGANÇA (2017)	Giro do Ativo (GAT)
GERVÁSIO, AVELAR e VIEIRA (2019)	Necessidade de Capital de Giro (NCG)
GERVÁSIO, AVELAR e VIEIRA (2019)	Tesouraria (T)
REIS, MACEDO e MARQUES, (2021); BRAGANÇA (2017);	Endividamento
BRAGANÇA (2017)	Liquidez
AVELAR, BOINA, AMARAL, REYES (2019)	IDSS
BRAGA (2017)	Aumento do Grau de Alavancagem Financeira (GAF)
BRAGA (2017)	Aumento da imobilização do capital próprio (Aimob)
BRAGA (2017)	Aumento dos investimentos em sociedades controladas ou coligadas
BRAGA (2017)	Aumento da folga financeira (Liquidez imediata + Liquidez Geral)
BRAGA (2017)	Porte da Operadora

Fonte: Elaborada pela autora, 2023

2.2. Pesquisa Acadêmica sobre Estrutura de Capital

Cabe situar a revisão da literatura abordando a Estrutura de Capital das Operadoras de Saúde no contexto mais amplo dos estudos acadêmicos sobre a Estrutura de Capital das empresas no Brasil. Nesse sentido, Bittencourt e Albuquerque (2018) realizaram um extenso levantamento bibliográfico em 2017, em busca de publicações em periódicos nacionais que tratassem de Estrutura de Capital. Foi consultada a base de periódicos da Capes, que na época contava com mais de 31 mil títulos de artigos brasileiros e estrangeiros, nas várias áreas acadêmicas. As palavras-chave empregadas pelos autores foram: *"Estrutura de Capital"* e *"Estrutura da Dívida"*, consideradas termos essenciais na Teoria da Estrutura de Capital. Ao todo foram identificados 80 artigos, sendo o primeiro datado em 1980. No período entre 1980 e 2007, apenas 17 trabalhos são identificados na busca, quase cinco décadas após a publicação do trabalho seminal de Modigliani e Miller (1958), como observam os autores. A pesquisa mostra que é a partir de 2009 que os temas acerca da Estrutura de Capital passam a ser mais explorados. Em 2018, a média de trabalhos publicados por ano alcançou 5 artigos, em âmbito nacional. Destes, a distribuição de artigos por periódicos WebQualis resultou na análise apresentada no quadro abaixo:

Tabela 20. Classificação WebQualis dos periódicos em que se encontram os artigos levantados e total de artigos por periódico

Revistas classificadas como A2ª	**Total**	**%**	**Revistas classificadas como B2**	**Total**	**%**
Revista Contabilidade e Finanças	16	20,0%	Pesquisa Operacional (Impresso)	1	1,3%
Revista de Administração Contemporânea	8	10,0%	Revista Brasileira de Finanças (Impresso)	3	3,9%
Revista de Administração Eletrônica	6	7,5%	Brazilian Finance Review – RBFin	1	1,3%
Revista de Administração (FEA-USP)	3	3,9%	Revista Iberoamericana de Estratégia	1	1,3%
Revista Brasileira de Gestão de Negócios (Impresso)	1	1,3%	Revista Portuguesa e Brasileira de Gestão	1	1,3%
Cadernos EBAPE.BR (FGV)	1	1,3%			
Total	**36**	**45,1%**	**Total**	**7**	**8,8%**
Revistas classificadas como B1ª	**Total**	**%**	**Revistas classificadas como B3**	**Total**	**%**
Brazilian Business Review	1	1,3%	Contextus (Fortaleza)	1	1,3%
Contabilidade Vista e Revista	3	3,8%	Pretexto (Belo Horizonte. Impresso)	1	1,3%
Gestão e Produção (Impresso)	2	2,5%	REGE. Revista de Gestão USP	6	7,5%
Revista de Administração Mackenzie	8	10,0%	Revista de Finanças Aplicadas	1	1,3%
Revista Brasileira de Economia (Impresso)	2	2,5%	Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade	1	1,3%
Revista Contemporânea de Contabilidade (UFSC)	1	1,3%	Revista Eletrônica de Estratégia e Negócios	1	1,3%
Revista de Economia e Sociologia Rural (Impresso)	1	1,3%	Revista Gestão e Tecnologia	2	2,5%
Revista Universo Contábil	3	3,9%	Contexto (UFRGS)	1	1,3%
Total	**20**	**25,0%**	**Total**	**14**	**17,5%**
			Revistas classificadas como B4	**Total**	**%**
			FACEF Pesquisa	1	1,3%
			RCeC. Revista de Contabilidade e Controladoria.	1	1,3%
			Revista Evidenciação Contábil e Finanças	1	1,3%
			Total	**3**	**3,9%**

Fonte: Bittencourt; Albuquerque, 2018, p. 10

La Rocca et al. (2011, p. 107), afirmam que a controvérsia na literatura empírica sobre os determinantes da estrutura de capital se deve à falta de consideração dos diferentes graus de opacidade da informação e das necessidades das empresas em fases específicas de sua vida. Pfaffermayr et al. (2013), propõem um modelo estilizado de três períodos para testar hipóteses empíricas sobre tributação corporativa, idade da empresa e sua estrutura de capital. Os resultados indicam que a tributação das empresas tem um impacto positivo no índice de endividamento, e que a interação positiva entre tributação corporativa e idade da empresa implica no índice de endividamento de empresas mais antigas que é mais afetado por uma redução nas taxas de tributação do que empresas mais jovens.

Reis e Neto (2014), mostram que os fatores determinantes da estrutura de capital não são os mesmos para empresas de alto e baixo crescimento, e que há mudanças no sinal da relação com o endividamento à medida que a empresa muda de estágio de vida. O trabalho posterior de Reis, Campos e Pasquini (2017), tem como objetivo verificar se a influência do ciclo de vida das empresas altera os determinantes da estrutura de capital das empresas brasileiras de capital aberto.

2.3. Efeitos da Pandemia de Covid-19 sobre o Setor Brasileiro de Planos de Saúde (SBPS)

Passados mais de dois anos desde que a Organização Mundial de Saúde (OMS) reconheceu que o mundo atravessava uma pandemia de contaminações pelo coronavírus, em 11 de Março de 2020, um volume significativo de relatórios de institutos de pesquisa, órgãos de governo, bem como matérias jornalísticas de fôlego e até mesmo livros e trabalhos acadêmicos foram produzidos, discutindo, dentre outras perspectivas, o impacto econômico da pandemia no setor de saúde ao redor do globo, e o papel do assim chamado Complexo Industrial Economia Saúde nos sistemas de prestação de serviços de saúde para as populações. Um volume menor de trabalhos foi produzido em âmbito acadêmico, o que é compreensível tendo em vista os tempos mais longos despendidos no processo de produção do conhecimento científico. Todavia, artigos acadêmicos, dissertações de mestrado e alguns trabalhos de conclusão de curso já se encontram disponíveis para consulta on-line.

A presente seção tem como base a revisão e análise de bibliografia levantada abordando o impacto econômico da pandemia sobre as Operadoras de Saúde brasileiras, conforme ilustra a tabela abaixo:

Tabela 21. Levantamento bibliográfico: impacto da pandemia no desempenho financeiro das OPS

AUT	AN	TÍTULO	TIPO	ABORDAGENS	ABORDAGENS
BRAGA, OLIVEIRA	2022	Dinâmica de capitalismo financeirizado e o sistema de saúde no Brasil: reflexões sob as sombras da pandemia de Covid-19	Artigo de periódico	6. Impacto do Covid	2. Posição no Setor
ARANOVICH, LEANDRO	2021	Covid-19 e a Nova Concentração do Mercado de Planos de Saúde	Artigo de periódico	6. Impacto do Covid	
ARAUJO, FRANÇA, SILVA, GRECCO	2021	Impacto da Covid-19 na Sustentabilidade Financeira das Operadoras de Planos de Saúde no Brasil	Artigo de periódico	6. Impacto do Covid	
AVELAR, FERREIRA, SILVA, FERREIRA	2021	Efeitos da Pandemia de Covid-19 sobre a sustentabilidade econômico-financeira de empresas brasileiras	Artigo de periódico	6. Impacto do Covid	
CENTRO INTERNACIONAL CELSO FURTADO	2021	Desenvolvimento, saúde e mudança estrutural: o complexo econômico-industrial da saúde 4.0 no contexto da Covid-19	Número especial	6. Impacto do Covid	
GADELHA, VARGAS, MALDONADO, BARBOSA	2021	O complexo econômico-industrial da saúde no Brasil: dinâmica de inovação e implicações para o Sistema Nacional de Inovação em Saúd	Artigo de periódico	6. Impacto do Covid	
KOLASSA	2021	Pandemia chegou, e agora? Os impactos nos Indicadores econômico-financeiros nas operadoras de planos de saúde	Mestrado Prof.	6. Impacto do Covid	
LESSA	2021	O impacto da crise Covid-19 na relação entre os custos assistenciais e a provisão para ressarcimento ao SUS da OPS com maior número de beneficiári	Dissertação	6. Impacto do Covid	
SALVADOR	2021	Empresas de Planos de Saúde no Brasil: crise sanitária e estratégias de expansão	Publicação Instituc.	6. Impacto do Covid	
OCKÉ-REIS, SÁ, VIEIRA, SERVO, BENEVIDES, PIOLA	2021	Políticas sociais: acompanhamento e análise	Capítulo de livro	6. Impacto do Covid	
CAMPOS, CANABRAVA	2020	O Brasil na UTI: atenção hospitalar em tempos de pandemia	Artigo de periódico	6. Impacto do Covid	
COSTA, BAHIA, CARVALHO, CARDOSO, SOUZA	2020	Oferta pública e privada de leitos e acesso aos cuidados à saúde na pandemia de Covid-19 no Brasil	Artigo de periódico	6. Impacto do Covid	
SERRA,TANAKA,SOUZA,TANAKA,SOUZA,FREITAS,MATOS,FERREIRA,PAULA,CUNHA	2020	Poder da informação e da transparência em cenários de incerteza: estratégia de ação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para enfrentamento da pandemia de Covid-19	Artigo de periódico	6. Impacto do Covid	

Fonte: Elaborada pela autora, 2023

2.3.1. Contexto da instalação da pandemia

Em janeiro de 2020, a OMS declarou o surto do COVID-19 como Emergência de Saúde Pública Internacional, e em março do mesmo ano, reconheceu que se tratava de uma pandemia. Até março de 2022, foram registrados mais de 472 milhões de casos e 6,09 milhões de óbitos em todo o mundo. O vírus é altamente contagioso, com um asRo de 2,5, e pode causar complicações respiratórias letais. As medidas de atendimento prioritário a pacientes de Covid-

19, e o postergamento de tratamentos eletivos, afetaram as operadoras de saúde em todo o mundo com impactos variados em suas condições financeiras. Os governos de países de alta renda, como Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha e Israel, apoiaram financeiramente as operadoras de saúde para gastos diretamente relacionados ao enfrentamento da pandemia, mas de modos correspondentes à estrutura de seus sistemas de saúde. Nos Estados Unidos, os financiamentos disponibilizados foram direcionados principalmente para os hospitais mais prósperos, que serviam ao maior número de pacientes com seguros privados (OPAS, 2020; SANAR, 2022; KAYE et al., 2021; WAITZBERG et al., 2021; PWC, s.d.).

A situação financeira dos hospitais durante a pandemia apresentou variação por região e tipo de hospital. Hospitais urbanos, que tiveram grandes volumes de casos, podiam cobrir cerca de 45 dias de operações, enquanto hospitais rurais tinham uma média de quase 70 dias de dinheiro em caixa. No entanto, os hospitais rurais tinham margens operacionais mais baixas e menos capacidade de cobrir dívidas.

Em âmbito internacional, na Inglaterra, o Sistema Nacional de Saúde foi financiado por meio de um sistema de revisão de pagamentos adotado durante a pandemia. O governo inglês ainda cortou cerca de U$17.8 bilhões em débitos das prestadoras de serviços públicos de saúde e ofereceu aportes de capital para prestar atendimento durante a emergência da Covid-19. Na Alemanha, o governo aprovou medidas para compensar a queda de entradas e prover incentivos para a capacidade de atender aos pacientes de Covid-19. Em Israel, o governo aprovou um programa de apoio a hospitais da ordem de U$550 milhões. Nos Estados Unidos, o setor de saúde perdeu mais de 1.5 milhão de empregos e os hospitais menores e rurais receberam financiamentos menores do que os hospitais grandes e prósperos. (PWC, s.d.; WAITZBERG et al., 2021, p. 552-555).

2.3.2. Contexto Nacional

Em fevereiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou estado de emergência de saúde pública em âmbito internacional devido à Covid-19. Em março do mesmo ano, o Ministério da Saúde autorizou a habilitação de leitos de UTI exclusivamente dedicados a pacientes de Covid-19. Os planos de saúde foram obrigados a prestar assistência em condições excepcionais, incluindo atendimento de urgência e emergência aos segurados durante a pandemia. A Agência Nacional de Saúde tomou uma série de medidas para o enfrentamento da pandemia, como a obrigatoriedade de exames para Covid-19 e a cobertura obrigatória para

tratamento da doença. Em janeiro de 2022, a ANS estabeleceu que os planos de saúde deveriam cobrir testes rápidos de Covid-19 para beneficiários de planos de saúde de tipo ambulatorial, hospitalar ou referência (COSTA et al., 2021; BRASIL, 2020, 2022).

2.3.3. Desempenho econômico das Operadoras de Saúde Brasileiras frente à pandemia: síntese

Um estudo da revista Cadernos do Desenvolvimento de Sarti, Hiratuka e Fonseca (2021) analisou a condição das Operadoras de Saúde dentro do Complexo Econômico Industrial da Saúde (CEIS) durante a pandemia de Covid-19. O CEIS é composto por grandes empresas globais que moldam a direção do avanço tecnológico e influenciam os gastos globais em saúde, afetando diretamente o acesso aos produtos e serviços de saúde.

Embora a maioria dos trabalhos sobre o impacto da pandemia nas OPS conclua que elas obtiveram resultados financeiros positivos, as análises não são interpretadas em um contexto mais amplo ou a uma escala temporal mais alargada. Sarti, Hiratuka e Fonseca (2021) entendem que o resultado financeiro positivo das OPS pode estar relacionado a estratégias econômicas traçadas a longo prazo dentro do CEIS, visando o desempenho financeiro positivo muito antes da crise pandêmica.

Uma hipótese a ser explorada é a de que um cenário de epidemia grave já poderia estar sendo contemplado em projeções de cenários futuros realizadas por empresas que lidam com saúde em termos mundiais, portanto, suas estratégias financeiras já continham elementos de prevenção de perdas diante de uma possível crise. Os trabalhos disponíveis acerca do efeito da pandemia sobre os indicadores econômicos das OPS abordam tópicos como a entrada de novos clientes, a inadimplência ou atraso no pagamento de mensalidades, a redução da utilização de pronto atendimento e realização de exames, a baixa sinistralidade e os reajustes de mensalidades (SCHEFFER; BAHIA, 2021). Ainda os tópicos abaixo são contemplados:

Relação Endividamento / Capital Próprio

Estudos recentes apontam para um aumento no uso de capital próprio em detrimento do endividamento como os de Araújo et al. (2021); Aranovich e Leandro (2021); Araújo (2020); Kolassa (2021); Lessa (2021); Lima (2021); Lima et al. (2021); Morais (2021). Entretanto, Macedo (2021) destaca que algumas empresas ainda utilizam mais capitais de terceiros para se

financiar.

Tendência de aumento de concentração horizontal e vertical

A pandemia favoreceu a realização de fusões e aquisições no setor de saúde, especialmente por OPS com grande volume de caixa e baixa sinistralidade (SCHEFFER; BAHIA, 2021). Empresas como Hapvida e NotreDame Intermédica aproveitaram as oportunidades de endividamento a baixo custo para adquirir empresas menores e ampliar seus negócios (SCHEFFER; BAHIA, 2021). O BNDES também contribuiu para o sucesso dessas operações, concedendo empréstimos generosos às empresas (SCHEFFER; BAHIA, 2021).

Os estudos sobre o impacto da pandemia nas Operadoras de Saúde apontam ainda para a melhoria dos indicadores econômicos e o aumento da concentração horizontal e vertical (SARTI; HIRATUKA; FONSECA, 2021). No entanto, alguns trabalhos não abordam a dificuldade de acesso aos serviços de saúde pela população e interpretam o crescimento econômico como resultado da busca por lucros sem atenção à qualidade do serviço. Não há, entre os estudos analisados, discussão sobre o papel das OPS no contexto do CEIS brasileiro e seu potencial em articulação com o sistema público de saúde (SARTI; HIRATUKA; FONSECA, 2021).

3. MODELOS TEÓRICOS

3.1 Marcos do surgimento das Empresas de Planos de Saúde no Brasil

3.1.1. Santas Casas de Misericórdia, Beneficências e Institutos de Aposentadoria e Pensões

A Santa Casa de Misericórdia é uma irmandade católica que cuida de doentes, desvalidos e crianças abandonadas em suas dependências (IBAO, s.d.). Segundo a Santa Casa de Misericórdia dos Passos (2016), a primeira Santa Casa foi fundada em Lisboa em 1498 por Frei Miguel Contreiras, confessor da rainha portuguesa Leonor de Lencastre, dando origem à "Confraria de Nossa Senhora de Misericórdia". No Brasil, as primeiras Santas Casas foram instaladas em cidades portuárias, voltadas para o atendimento dos doentes que chegavam em embarcações (IBAO, s.d.). Desde sua origem, sua manutenção depende das doações de suas comunidades (CMB, 2020). Transformações importantes ocorreram no período de governo de Getúlio Vargas, em que se instaura a regulamentação trabalhista e os Institutos de

Aposentadorias e Pensões (IAPs), momento em que o setor filantrópico passa a atuar por meio de contratos e convênios com os IAPs (PSCHEIDT, 2014). Com a criação do INPS e posteriormente do INAMPS, a iniciativa privada sem fins lucrativos passou a suprir a maior parte da demanda por serviços de assistência médica (PSCHEIDT, 2014; CMB, 2020).

A distribuição das entidades assistenciais pelo Brasil levou ao estabelecimento de parcerias com o governo para remunerar hospitais sem fins lucrativos por procedimentos realizados, porém, essa remuneração não é suficiente para a viabilidade econômica dessas entidades (CMB, 2020; INÁCIO et al., 2020). Esta queda no volume de doações pode estar associada à percepção equivocada de que as entidades assistenciais são públicas (CMB, 2020). Hoje, as Santas Casas de Misericórdia representam cerca de 60% dos atendimentos do Sistema Único de Saúde em muitas cidades brasileiras (THATY, 2019 apud INÁCIO et al., 2020, p. 111). Mais de 2100 estabelecimentos de assistência à saúde sem fins lucrativos distribuem-se pelo Brasil, inspirados pelas Santas Casas de Misericórdia e outras iniciativas religiosas (CMB, 2020).

3.1.2. Planos de Saúde Privados no Brasil dos anos 1940 a 1988

Os planos de saúde privados surgiram nas décadas de 1940 e 1950 como complemento à assistência médico-hospitalar pública, inicialmente oferecidos aos funcionários de empresas tanto do setor público quanto privado (BAHIA, 2001). A partir da década de 1960, os convênios médicos celebrados entre o meio empresarial e as cooperativas médicas sinalizaram a direção empresarial em que a prestação de serviços da medicina estava tomando (BAHIA, 2010). Segundo Pscheidt (2014), com a edição da Lei nº 9656/1998, que estabeleceu um novo marco regulatório para a saúde suplementar, se instituiu algum tipo de regulação para o setor. Entretanto, a expansão do setor sem regulação adequada não garantiu a prestação de serviços de qualidade ou oferta de cobertura adequada para procedimentos especializados (PSCHEIDT, 2014).

3.1.3. Planos de Saúde Privados no Brasil entre 1988 e 2000

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 incluiu o direito à saúde como um dos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros, estabelecendo que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser regulamentados, fiscalizados e controlados pelo poder público. Além disso, a Constituição permitiu a prestação de serviços de saúde por

empresas privadas, mas com regulamentação e controle do Estado. Após a promulgação da Constituição, houve expansão do mercado de planos de saúde privados, com hospitais e empresas médicas oferecendo serviços individuais. Até 1998, a regulamentação dos planos de saúde era exercida pela Susep, autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda. As operadoras de saúde celebravam contratos de compra de serviços médico-hospitalares com base em protocolos clínicos e parâmetros de utilização (ARAÚJO, 2004; BAHIA, 2010).

A expansão das empresas de saúde suplementar, que em 1999 contava com 2700 operadoras em atuação, foi impulsionada pela insuficiente regulamentação até então existente, e por um período de reformas conservadoras em âmbito internacional, que diminuiu o papel do Estado na implementação das políticas sociais e na atenção aos serviços públicos de saúde (ARAÚJO, 2004; BRASIL, 2011). A ampliação de espaço para a instalação de OPS gerou a necessidade de regulação, tanto por parte das empresas prestadoras de serviços de saúde, que precisavam estabelecer regras claras de competição, quanto por parte dos beneficiários, governo e entidades médicas, que enfrentavam entraves no atendimento e tratamento de pacientes portadores do HIV (BRASIL, 2011). No processo de construção de uma legislação específica para o setor, duas visões concorrentes interagiam: a visão do serviço de saúde como produto financeiro, defendida pelo Ministério da Fazenda, e a visão do serviço de saúde como primordialmente uma questão de saúde, defendida pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2011). A dimensão de "produto financeiro" tornou-se essencial na estruturação do Setor Brasileiro de Planos de Saúde, motivando a produção de diversos estudos sobre a Estrutura de Capital das empresas neste contexto (BRASIL, 2011).

3.1.4. A Transição para a regulação: da Lei N. 9656/1998 ao Início do Funcionamento da ANS em 2001

A Lei nº 9656/98 estabeleceu novos padrões para os serviços de saúde suplementar no Brasil. Ela regulamentou os planos e seguros privados de assistência à saúde e exigiu a revisão dos modos de prestação de serviços. A ANS, que começou a funcionar em 2001, regulamentou as Garantias Financeiras para as Operadoras e estabeleceu um novo formato mais profissional, competitivo e estável para o mercado (ARAÚJO, 2004, p. 67). A regulação teve como foco corrigir a assimetria de informações nas relações entre OPS e consumidores, o que era um requisito para a permanência das OPS no mercado que atendia cerca de 35 milhões de pessoas na época. A estrutura da nova regulamentação pode ser visualizada no quadro abaixo:

Figura 02. Quadro de regulamentações complementares, período de 1999 a 2000

Quadro 1 – Regulamentações complementares, período de 1999 a 2000

Tipo	Quantidade
Até 1999	
Resoluções CONSU	23
Total Geral das Regulamentações Complementares da ANS até 1999	**23**
Desde 2000	
Regulamentações Normativas	
Instruções Normativas	**25**
Desenvolvimento Setorial (DIDES)	14
Gestão (DIGES)	2
Operadoras (DIOPE)	1
Produtos (DIPRO)	8
Resoluções	**21**
Desenvolvimento Setorial (DIDES)	7
Operadoras (DIOPE)	5
Produtos (DIPRO)	6
Fiscalização (DIFIS)	3
Resoluções CONSU	**2**
Resoluções da Diretoria Colegiada	**69**
Resoluções Normativas	**25**
Súmulas Normativas	**4**
Total	**144**
Regulamentações Operacionais	
Portarias do Diretor Presidente	**1**
Resoluções da Diretoria Colegiada	**26**
Resoluções Normativas	**118**
Total	**145**
Total Geral das Regulamentações Complementares da ANS desde 2000	**289**

Fonte: ANS

Fonte: ANS apud ARAÚJO, 2004, p.53

A Lei 9656/98 e a Lei 9961/2000, juntamente com as medidas provisórias que as sucederam, estabelecem normas para a constituição de operadoras de planos e seguros de saúde, incluindo a obrigatoriedade de registro de produtos e a definição de planos de referência hospitalar, ambulatorial e odontológica. A Lei 9656/98 também estabelece requisitos para a obtenção da autorização de funcionamento das operadoras de planos de saúde, como o registro nos Conselhos Regionais de Medicina e Odontologia e a demonstração da viabilidade econômico-financeira dos planos privados de assistência à saúde oferecidos. Antes da edição da RDC nº 77, de 17 de julho de 2001, as operadoras funcionavam sem regulação, resultando em instabilidade no mercado. A ANS respondeu a este clima de instabilidade com um "volume enorme de regras", o que é um aspecto relevante a ser considerado na análise da influência dessas regras na Estrutura de Capital das OPS (NORONHA; LIMA; MACHADO apud BRASIL, 2011; ARAÚJO, 2004; KORNIS; RODRIGUES apud BRAGANÇA, 2003).

3.1.5. Marcos temporais no Processo de Regulação do Setor de Saúde Brasileiro

Apresenta-se abaixo uma sequência de marcos temporais significativos na evolução do processo de regulação do Setor de Saúde Brasileiro:

- 1539 - atual

  Coroa Portuguesa no Brasil;

  Santas Casas de Misericórdia, Beneficências e Institutos de Aposentadoria e Pensões.

- 1923

  Lei Elói Chaves;

  Caixas de Aposentadoria e Pensão

- 1930-1945

  Governo Getúlio Vargas;

  Institutos de Aposentadoria e Pensões.

- 1940 (década)

  Primeiros planos de saúde oferecidos aos funcionários de empresas públicas e privadas.

- 1960-1970 (décadas)

  Contratação, por parte da Previdência Social, de serviços médicos oferecidos por redes privadas de saúde.

- 1966

  Decreto-Lei N. 73/1966, constituindo o Sistema Nacional de Seguros Privados.

- 1988

  Constituição da República Federativa do Brasil reconhecendo a saúde como direito.

- 1998

  Lei N. 9656/1998, estabelecendo um novo marco regulatório para a saúde suplementar.

- 2000

  Lei 9961/2000, que cria a Agência Nacional de Saúde Suplementar.

- 2001

RDC N.77/2001, dispondo sobre "os critérios de constituição de garantias financeiras a serem observados pelas OPS."

Tabela 22. Linha do Tempo de Políticas e Planos de Saúde no Século XX

Ano	Política		Planos de Saúde
1923	República Velha	Obrigatoriedade das CAPs	
1930	Era Vargas		
1933		Criação do primeito IAP	
1944		Criação do SAMDU	Criação: Cassi
1945			Criação: Assistência Patronal dos funcionários do IAPI
1946	Instabilidade Democrática		
1953			Petrobrás criada com assist^ncia mpedica supletiva para seus funcionários
1956			1º plano pré-pagamento. Criação: Policlinca Central
1958			Inauguração: Hospital da Sul America
1959		Filantrópicas isentas da contribuição da previdência	
1960		LOPS padroniza IAPs	
1962		IAPB compra Hospital da Sul America	Criação: SAMCIL
1963			1º plano individual. Criação: SENASA
1964	Golpe Militar	PAEG e Reformas Institucionais	1º convênio-empresa (Volkswagem
1966		Criação INPS e SUSEP. Norma convênio-empresa	Criação: ABRAMGE
1967			Criação: SEMIC, Rio-Clinicas, 1ª Unimed (Santos)
1968			Criação: AMA (Medial), Interclinicas e Intermedica
			Criação: 30 cooperativas médicas no Estado de SP
1971		Prorural	Compra da Policlinica Central pela SAMCIL
1972			Criação: Golden Cross, Medial Saúde e Unimed de Santa Maria
1974	Ditadura: abertura gradual	Criação do MPAS e do FAZ. Lançamento do PPA	
1977		Criação do SINPAS, Incluindo INAMPS	
1978			Criação: AMIL
1979		Inicio de restrições convenios-empresa	Indorporações (Ex.: compra da Amico pelo Hospital Corporation América)
1982		INAMPS compra hospital da SEMIC. Decreto de utilidade pública para a Golden Cross.	
1985	Transição		
1987		Criação do SUDS	
1988	Democracia	Constituição: cria SUS	Criação: SINAMGE
1990		Codigo de Defesa do Consumidor	
1993		Extinção do INAMPS	
1994		Plano Real	Elevação das mensalidades
1998		Lei 9.656	
1999			
2000		Criação da ANS	

Fonte: Oliveira, 2016

3.1.6. Conceitos fundamentais na estruturação das Empresas brasileiras do Setor de Saúde a partir da criação da ANS

O sistema de saúde brasileiro se divide em subsistemas público e privado, sendo o primeiro financiado e gerido pelo SUS e o segundo composto pelo subsetor liberal clássico e o de saúde suplementar. O subsetor liberal clássico consiste em profissionais autônomos que estabelecem

contratos diretamente com seus clientes, enquanto o subsetor de saúde suplementar é composto por planos e seguros de saúde financiados pela iniciativa privada e com subsídios públicos (PIETROBON; PRADO; CAETANO, 2008; BRASIL, 2011).

Tendo em vista o exposto acima, observa-se na tabela abaixo o comparativo entre os dois subsistemas que compõem o sistema de saúde:

Tabela 23. Comparativo de subsistemas de saúde

SUBSISTEMA PÚBLICO	SUBSISTEMA PRIVADO
› Financimaneto: público, com a participação das esferas da federação. › Gestão: pública, única, com integração e articulação entre as diferentes esferas. › Prestadores de Assistência: serviços da rede própria de Municípios, Estados e União; serviços públicos de outras áreas de governo; serviços privados contratados ou conveniados.	› Financimaneto: privado, com subsídios do setor público. › Gestão: privada, em processos de regulamentação pela ANS. › Prestadores de Assistência: privados credenciados pelos planos e seguros de saúde ou pelas cooperativas médicas; serviços próprios dos planos e seguros de saúde, etc.; serviços privados conveniados ou contratados pelo subsistema público que são contratados por empresas de planos de saúde, passando a fazer parte da rede credenciada dos mesmos.

Fonte: Brasil, 2011

A Resolução DC/ANS nº 39 de 27 de outubro de 2000 define os termos que estabelecem o entendimento do sistema regulatório de Operadoras de Planos de Assistência à Saúde (ANS, 2000). São eles:

- Operadoras de Planos de Assistência à Saúde;
- Rede própria;
- Tipos de atenção prestados pelas Operadoras;
- Segmentação;
- Classificação.

A resolução define que as Operadoras de Planos de Assistência à Saúde são empresas e entidades que operam planos de assistência à saúde no mercado de saúde suplementar, conforme disposto na Lei nº 9.656/1998 (ANS, 2000). A rede própria é definida como o recurso físico hospitalar ou profissional assalariado ou cooperado da operadora. Os tipos de atenção prestados pelas operadoras segmentam-se em médico-hospitalar e odontológico. A segmentação das operadoras é dividida em categorias de acordo com o custo assistencial relativo aos gastos em serviços hospitalares ou médicos referentes aos planos privados de

assistência à saúde. Por fim, a classificação das operadoras é definida em sete modalidades: administradora, cooperativa médica, cooperativa odontológica, autogestão, medicina de grupo, odontologia de grupo e filantropia (ANS, 2000).

O sistema de Saúde Suplementar é formado por uma cadeia de atividades que conecta de um lado os insumos e de outro, os beneficiários. Assim, em uma ponta temos o fornecimento de materiais médicos, equipamentos e medicamentos entregues por seus próprios meios aos agentes distribuidores e estes, por sua vez, são recebidos pelos agentes prestadores de serviços que integram a infra-estrutura de atenção à saúde, composta por prestadores de serviços de saúde, ou seja, profissionais da medicina, além das próprias clínicas, hospitais, laboratórios e estabelecimentos de medicina diagnóstica. Por sua vez, os pacientes têm acesso a este sistema via OPS, por meio de um contrato de plano de saúde.

Existem quatro principais modalidades de empresas atuando no setor privado de saúde suplementar, o que chamamos de "segmentação das Operadoras de Saúde": Medicina de Grupo, Seguro de Saúde, Cooperativa de Trabalho Médico, Seguradora Especializada em Saúde, Autogestão e Administradora de Benefícios (ANS, 2024).

Na categoria Medicina de Grupo, estão empresas que operam planos privados de assistência à saúde com rede própria, ou seja, hospitais, clínicas, centros de diagnóstico. Em setembro de 2022 havia 242 Medicinas de grupo representando 39% do mercado brasileiro de assistência suplementar à saúde. As OPS com mais de 500 mil beneficiários nesta modalidade são: Hapvida, Notre Dame Intermédica e Amil (ANS 2022)

Figura 03. OPS na modalidade Medicina de Grupo acima de 500 mil beneficiários, apurados em setembro de 2024



ANS Agência Nacional de Saúde Suplementar — ANS TABNET

Inicio Consultas Ajuda

Atenção: Os dados do Tabnet têm carga trimestral. Números de beneficiários com carga mensal podem ser consultados na **Sala de Situação**.

Beneficiários por Operadora

Benef. Asst. Médica segundo Operadora
Modalidade: Medicina de Grupo
Faixa de Benef: Acima de 500.000 beneficiários
Período: Set/2024

Operadora	Benef. Asst. Médica
TOTAL	13.419.637
302147-PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE L	574.099
309222-GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA	557.631
326305-AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2.665.374
342033-SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA SA	420.184
348520-NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S	504.536
359017-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	3.293.287
368253-HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	4.284.565
416428-SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S.A.	551.521
421715-BRADESCO SAUDE - OPERADORA DE PLANOS S/A	568.440

Copia como .CSV Copia para TabWin

Fonte: SIB/ANS/MS - 10/2024.

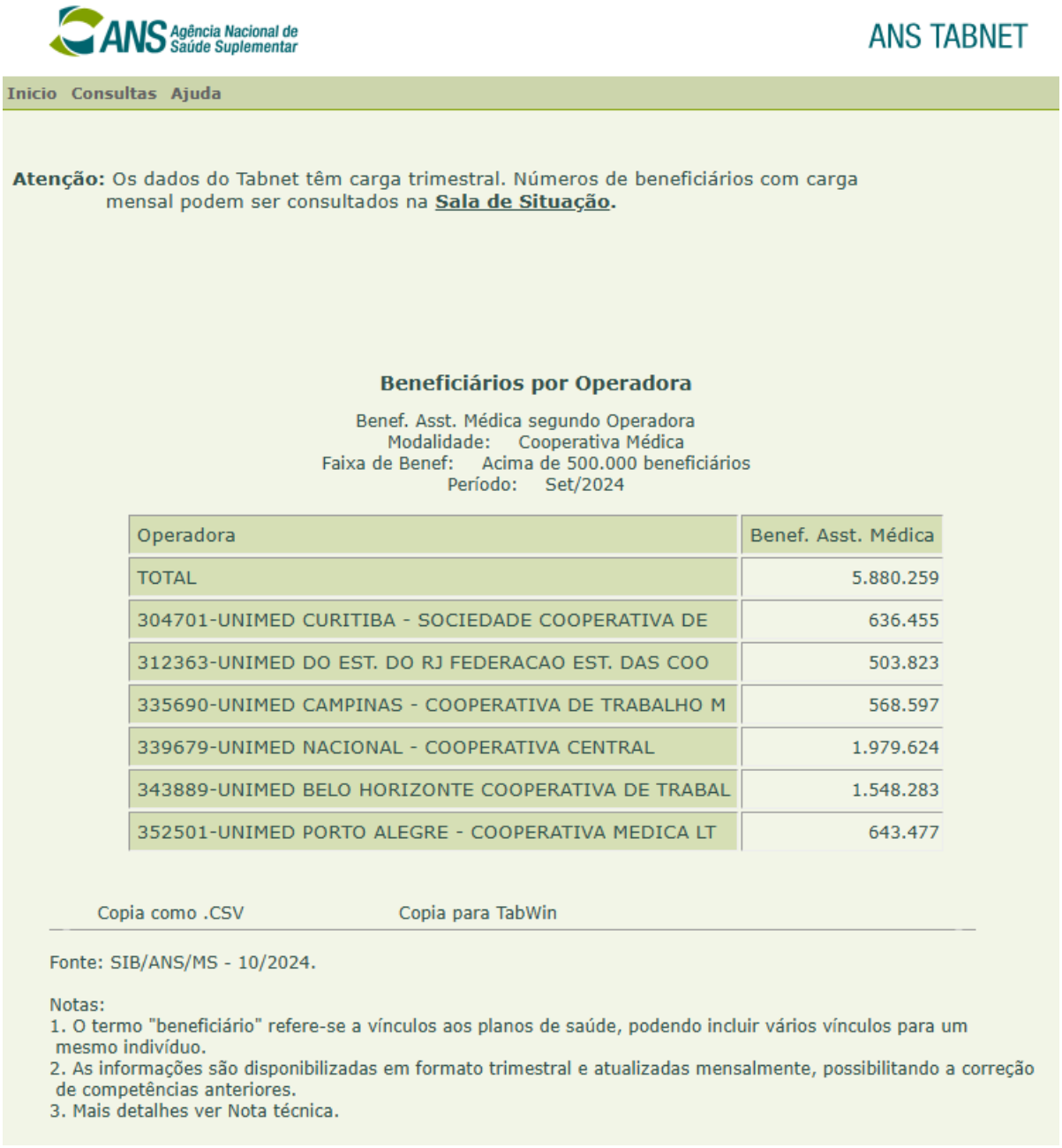
Notas:
1. O termo "beneficiário" refere-se a vínculos aos planos de saúde, podendo incluir vários vínculos para um mesmo indivíduo.
2. As informações são disponibilizadas em formato trimestral e atualizadas mensalmente, possibilitando a correção de competências anteriores.
3. Mais detalhes ver Nota técnica.

Fonte: ANS, 2024

As Cooperativas Médicas consistem em empresas dedicadas à prestação de serviços de saúde sem fins lucrativos organizados por médicos. A maioria delas são Unimeds, possuindo serviços próprios e especializados em sua maioria oferecidos pelos próprios cooperados. Em setembro de 2021 havia 281 operadoras funcionando nesta modalidade, representando 38% do mercado brasileiro tendo em vista o número de vidas. Nesta modalidade, as OPS que atingem 500 mil

beneficiários ou mais são as Unimed: Curitiba, Campinas, Central Nacional, Belo Horizonte, Porto Alegre e Rio Cooperativa de Trabalho Médico (ANS 2024).

Figura 04. OPS na modalidade Cooperativa Médica acima de 500 mil beneficiários, apurados em setembro de 2024



ANS Agência Nacional de Saúde Suplementar

ANS TABNET

Inicio Consultas Ajuda

Atenção: Os dados do Tabnet têm carga trimestral. Números de beneficiários com carga mensal podem ser consultados na **Sala de Situação**.

Beneficiários por Operadora

Benef. Asst. Médica segundo Operadora
Modalidade: Cooperativa Médica
Faixa de Benef: Acima de 500.000 beneficiários
Período: Set/2024

Operadora	Benef. Asst. Médica
TOTAL	5.880.259
304701-UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE	636.455
312363-UNIMED DO EST. DO RJ FEDERACAO EST. DAS COO	503.823
335690-UNIMED CAMPINAS - COOPERATIVA DE TRABALHO M	568.597
339679-UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL	1.979.624
343889-UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABAL	1.548.283
352501-UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LT	643.477

Copia como .CSV Copia para TabWin

Fonte: SIB/ANS/MS - 10/2024.

Notas:
1. O termo "beneficiário" refere-se a vínculos aos planos de saúde, podendo incluir vários vínculos para um mesmo indivíduo.
2. As informações são disponibilizadas em formato trimestral e atualizadas mensalmente, possibilitando a correção de competências anteriores.
3. Mais detalhes ver Nota técnica.

Fonte: ANS, 2024

As seguradoras de saúde são caracterizadas por operar com reembolso. Estas empresas não possuem rede própria, mas uma rede credenciada de hospitais, clínicas e laboratórios que

podem ser utilizados ou não pelos beneficiários. Estes podem escolher entre utilizar a rede própria ou outros estabelecimentos. Neste último caso, o valor dos serviços será reembolsado pela seguradora. Em setembro de 2021 havia 9 empresas deste tipo no Brasil representando 13% do mercado. As OPS atuando com mais de 500 mil beneficiários no mercado são: Porto Seguro, Unimed Seguros, Bradesco Saúde e Sulamérica (DUAS VIAS, 2020).

Figura 05. OPS na modalidade Seguradora Especializada em Saúde acima de 500 mil beneficiários, apurados em setembro de 2024

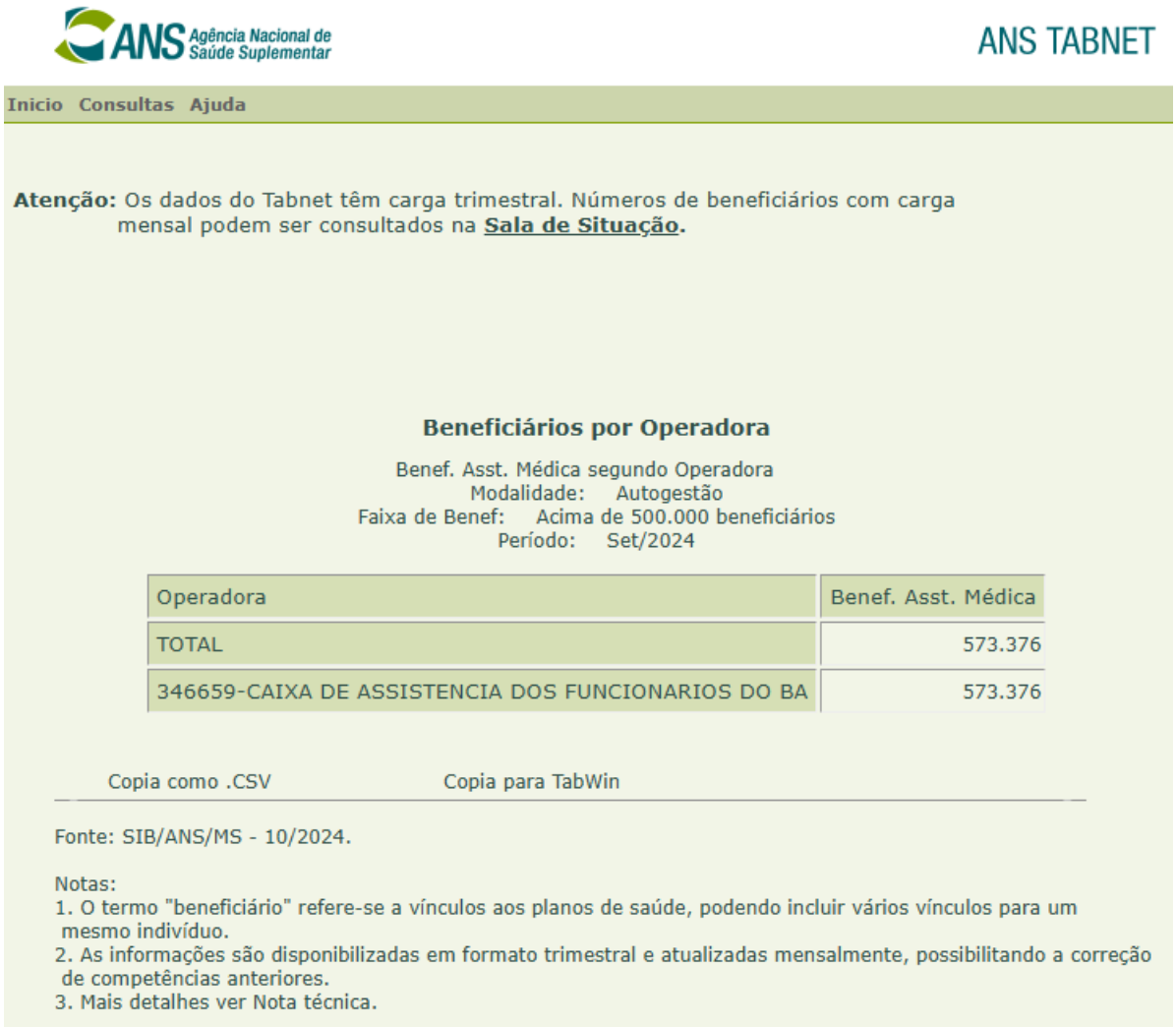


Fonte: ANS, 2024

Na modalidade autogestão, a própria empresa faz a gestão do plano de saúde de seus

funcionários. Em setembro de 2021 havia 155 autogestões representando 10% do mercado brasileiro. A principal autogestão brasileira, com mais de 500 mil beneficiários, é a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (DUAS VIAS, 2020).

Figura 06. OPS na modalidade Autogestão em Saúde acima de 500 mil beneficiários, apurados em setembro de 2024



Fonte: ANS, 2024

Embora cada um destes segmentos possua estruturas organizacionais diferentes, e inclusive sejam representados por órgãos distintos, "a natureza da atividade por elas desenvolvida é basicamente a mesma", Conass (s.d/s.a.).

Tabela 24. Beneficiários de planos privados de saúde, por cobertura assistencial (Brasil, 2014-2024)

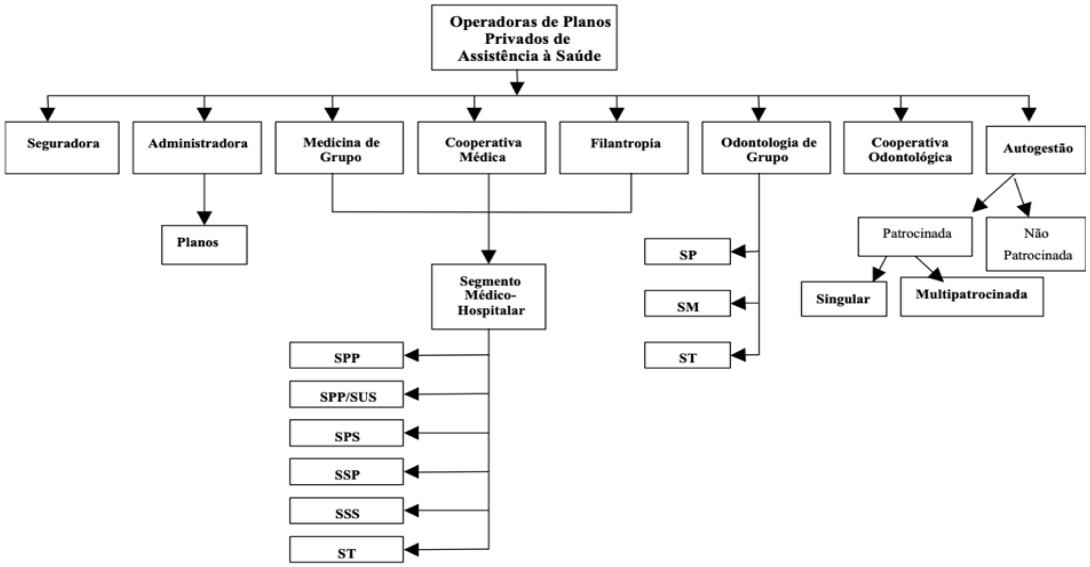
Ano	Beneficiários em planos privados de assistência médica com ou sem odontologia	Beneficiários em planos privados exclusivamente odontológicos
Dez/14	50.531.748	20.081.836
Dez/15	49.279.085	20.780.720
Dez/16	47.685.266	21.181.491
Dez/17	47.144.909	22.271.134
Dez/18	47.122.155	24.033.193
Dez/19	47.076.596	25.336.520
Dez/20	47.468.971	25.905.267
Dez/21	48.820.702	28.112.547
Dez/22	50.066.425	30.033.457
Dez/23	50.801.802	32.393.673
Set/24	51.481.212	34.046.045

Fonte: Sistema de Informações de Beneficiários-SIB/ANS/MS

Dados atualizados até set/2024

O esquema abaixo ilustra a segmentação do mercado de saúde suplementar:

Figura 07. Segmentação do Mercado de Saúde Suplementar



Fonte: Araújo, 2004, p.60

3.1.7. Crescimento da saúde suplementar no Brasil - gastos públicos x gastos privados

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 reconheceu a saúde como um direito social e criou o Sistema Único de Saúde (SUS) financiado por meio de impostos gerais, contribuições sociais, desembolso direto e gastos dos empregadores com saúde. Apesar da existência do sistema público de saúde de acesso universal, a estrutura de oferta de serviços é insuficiente devido à falta de recursos públicos (MELO, 2004; OCKÉ-REIS; ANDREAZZI; SILVEIRA, 2006 apud CARMO, 2016; FIGUEIREDO et al., 2018). Isso gerou uma condição contraditória em que houve avanços na universalidade e integralidade do SUS, enquanto o setor privado também cresceu (OCKÉ-REIS, 2012, apud SÁ et al., 2021, p. 17).

Desde 2014, observa-se um avanço na privatização dos serviços de saúde, especialmente após a recessão de 2015-16 e a Emenda Constitucional 95, que reduziu o volume de recursos federais destinados à saúde (MORETTI; FUNCIA; OCKÉ-REIS, 2020 apud SÁ et al., 2021, p. 18). Os gastos privados em saúde são maiores que os gastos públicos, apontando para a avantajada proporção do sistema privado de saúde no Brasil (FIGUEIREDO et al., 2018). Em comparação

com outros países com sistemas de saúde similares, universais e públicos, o Brasil foi o que destinou a menor proporção de orçamento público para a saúde no período de 2000 a 2014 (FIGUEIREDO et al., 2018)

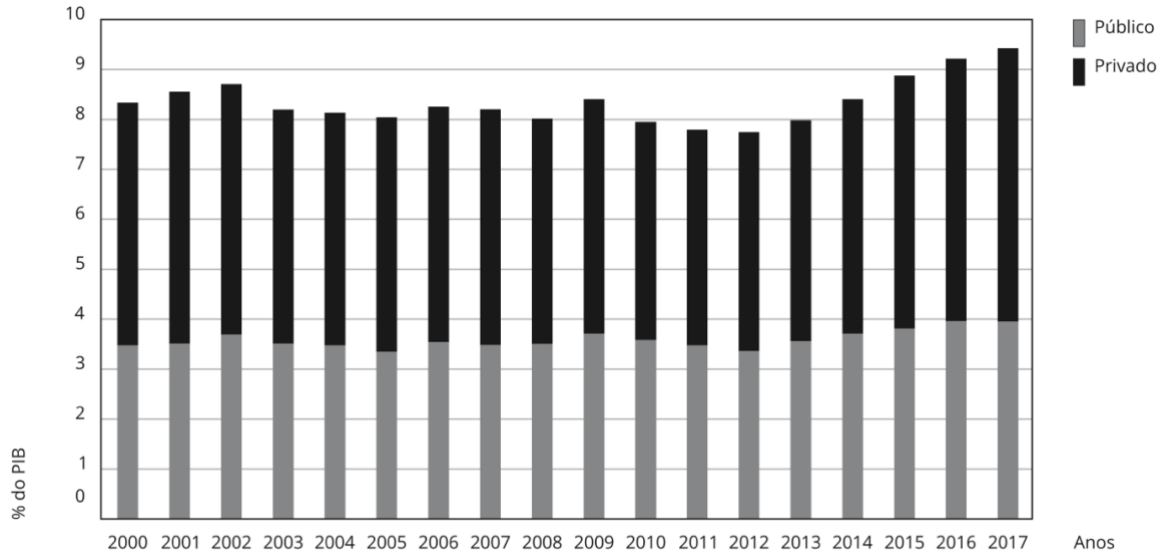
Tabela 25. Gasto público em saúde como porcentagem do gasto total em saúde dentre os países com sistemas de saúde similares

Países	2000	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Brasil	40,3	43,8	44,4	45,8	45,2	44,3	45,1	46
França	79,4	77,3	77,5	77,5	77	77,2	77,1	78,2
Itália	72,1	76,9	77	77	75,1	75,3	75,6	75,6
Portugal	67,7	67,4	68,7	68,7	66,5	64	65,2	64,8
Espanha	71,6	74	75,7	75,1	73,9	71,7	71,5	70,9
Reino Unido	79,6	81,6	83,2	83,5	83,2	82,9	83,3	83,1

Fonte: Figueiredo et al., 2018, p.42

A fim de aprofundar a análise, pode-se acompanhar no gráfico abaixo o percentual do Produto Interno Bruto (PIB) e proporção de despesas públicas e privadas no Brasil entre 2000 e 2017:

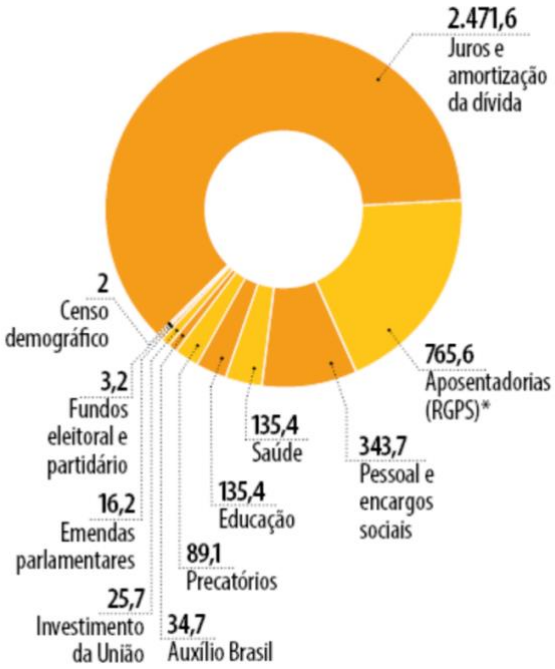
Gráfico 01. Gastos com saúde, percentual do Produto Interno Bruto (PIB) e proporção de despesas públicas e privadas no Brasil (2000-2017)



Fonte: Braga; Oliveira, 2022, p.9

Finalmente, os gráficos abaixo ilustram a proporção de investimentos da União em 2022, em relação às demais principais despesas:

Gráfico 02. Principais despesas da União em 2022 (em $bilhões).



Fonte: Brasil, 2021

Gráfico 03. Despesas não obrigatórias por setor



Fonte: Brasil, 2021

Os Planos Privados de Saúde e Seguro Saúde, neste contexto, podem ser vistos como agentes de desoneração do Estado na prestação eficiente de serviços de saúde a seus beneficiários (MELO, 2004, p.17). A contradição apontada acima residiria no fato de que, ainda que os serviços públicos de saúde se constituam em direito garantido pela Constituição de 1988, uma proporção importante da população brasileira opta pela contratação de planos privados de saúde, com o objetivo de obter um melhor atendimento (BAHIA, 2001). Esta escolha poderia ser interpretada como uma migração da classe média para os planos privados, em resposta a pelo menos dois fatores: segundo Reigada e Romano (2018, p. 1), uma percepção de ineficiência do SUS, "medo da falta de leitos para internação e atendimento de emergência"; e o efeito do aumento do oferecimento de planos de saúde aos funcionários de empresas tanto públicas quanto privadas (PINTO; SONRAZ, 2004 apud CARMO, 2016, p. 16). Soma-se a estes fatores o possível "racionamento da oferta de serviços" apontado por Ribeiro (2009) como uma "estratégia de controle de custos" por parte do governo.

3.1.7.1 Caracterização dos riscos do mercado de saúde suplementar

O mercado de saúde suplementar é complexo e apresenta particularidades, como pagamentos sem correspondência com serviços prestados e beneficiários que tomam decisões que beneficiam os prestadores de serviços (AZEVEDO et al., 2016). As OPS atuam como terceiro-pagador, comercializando planos pré-pagos intermediando o acesso de beneficiários aos serviços de saúde privados (OCKÉ-REIS; ANDREAZZI; SILVEIRA, 2006). A incorporação de novas tecnologias pode implicar em aumento de custos, como o tratamento de doenças antes incuráveis (AZEVEDO et al., 2016). O mercado de planos de saúde apresenta dinâmica de oferta que orienta a procura, externalidades, demanda inelástica, custos crescentes e falhas de mercado, como seleção adversa e assimetria de informações entre os agentes econômicos (SALVATORI; VENTURA apud CARMO, 2016). A seleção adversa ocorre quando a OPS admite um beneficiário sem ter conhecimento prévio de uma condição de saúde pré-existente (CARMO, 2016).

O risco moral ocorre quando o beneficiário faz uso excessivo do plano de saúde, o que pode ser motivado pela falta de arcar diretamente com os custos dos serviços e pela indução de profissionais da saúde (CARMO, 2016; AZEVEDO et al., 2016). A assimetria de informação entre empresas de saúde, beneficiários e prestadores de serviços também é um problema, especialmente na dinâmica de contratação de serviços nas redes credenciadas (CARMO, 2016;

AZEVEDO et al., 2016). Para minimizar as consequências da seleção adversa e do risco moral, as OPS podem estabelecer formas de seleção do risco e monitoramento do uso dos planos (AZEVEDO et al., 2016). Na concorrência, as OPS de maior porte têm vantagem na inovação e na diluição de custos (CARMO, 2016; AZEVEDO et al., 2016).

3.1.7.2 Aspectos econômicos do mercado de saúde suplementar

Entre 2014 e 2018 houve um aumento acentuado nos preços dos planos de saúde devido às políticas regulatórias, levando à saída de 3 milhões de beneficiários do sistema (OCKÉ-REIS; FIUZA; COIMBRA, 2019). As OPS registraram resultados econômicos positivos em 2018, faturando 192,1 bilhões, devido à queda da taxa de sinistralidade e aumento do lucro líquido per capita (OCKÉ-REIS et al., 2021). A inflação acumulada entre 2000 e 2018 foi de 208%, enquanto o aumento dos planos ultrapassou os 382%, gerando questionamentos sobre o método de cálculo de reajustes da ANS (OCKÉ-REIS et al., 2021). Durante a pandemia, a redução da demanda por serviços médico-hospitalares contribuiu para o resultado líquido positivo das OPS (OCKÉ-REIS et al., 2021). Em junho de 2022, o número de beneficiários em planos de assistência médica atingiu 49,8 milhões, atendidos por 694 OPS (ANS, 2022). Os dados apresentados no Boletim Covid-19 da ANS de julho de 2022 ilustram a situação atual do mercado de planos de saúde.

Tabela 26. Taxa de crescimento (%) do número de beneficiários em relação a dezembro do ano anterior (Brasil, 2014-2024)

Ano	Beneficiários em planos privados de assistência médica com ou sem odontologia	Beneficiários em planos privados exclusivamente odontológicos
Dez/14	2,1	2,7
Dez/15	-2,5	3,5
Dez/16	-3,2	1,9
Dez/17	-1,1	5,1
Dez/18	0,0	7,9
Dez/19	-0,1	5,4
Dez/20	0,8	2,2
Dez/21	2,8	8,5
Dez/22	2,6	6,8
Dez/23	1,5	7,9
Set/24	1,3	5,1

Fonte: Sistema de Informações de Beneficiários-SIB/ANS/MS

Dados atualizados até 10/2024

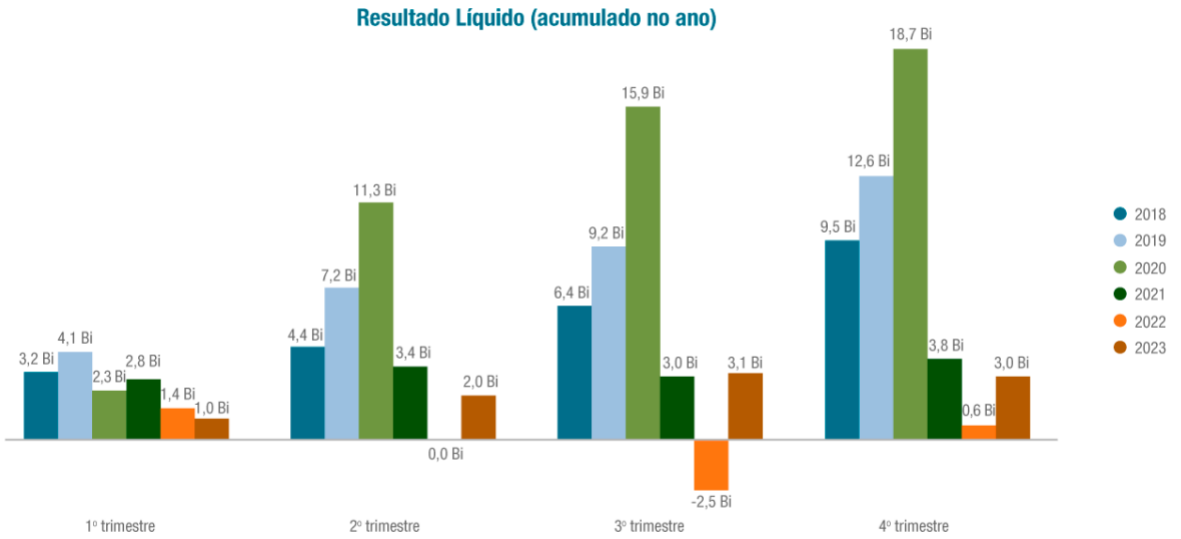
Segundo dados da ANS o desempenho econômico-financeiro do setor observado em 2023 é o mais positivo do período pós pandemia.

Nos números agregados por segmento, os resultados líquidos no ano de 2023 foram positivos para todos: as administradoras de benefícios registraram lucro de R$ 406,4 milhões; as operadoras exclusivamente odontológicas, de R$ 652,8 milhões; e as médico-hospitalares, de R$ 1,93 bilhões.

Seguindo uma dinâmica comum no setor, as operadoras médico-hospitalares, que são o principal segmento do setor, fecharam o ano de 2023 com resultado operacional negativo acumulado no ano de R$ 5,9 bilhões. Entretanto, o resultado do 4° trimestre isolado é o melhor resultado de um trimestre desde o 1° trimestre de 2021. Esse prejuízo operacional foi compensado pelo resultado financeiro recorde de R$ 11,2 bilhões, advindo principalmente da remuneração das suas aplicações financeiras, que acumularam, ao final do período, quase R$ 111 bilhões.

“A recuperação está acontecendo, os resultados são melhores do que o que foi projetado para o setor. Se em 2022 foi registrado prejuízo na casa de 530 milhões no segmento médico-hospitalar, 2023 já trouxe lucro de 1,9 bilhão. Inclusive, poderíamos até mesmo ter números melhores, mas houve ajustes contábeis significativos em operadoras maiores que tiveram impacto nos resultados gerais.

Gráfico 04. Resultado Líquido (acumulado no ano de 2024)



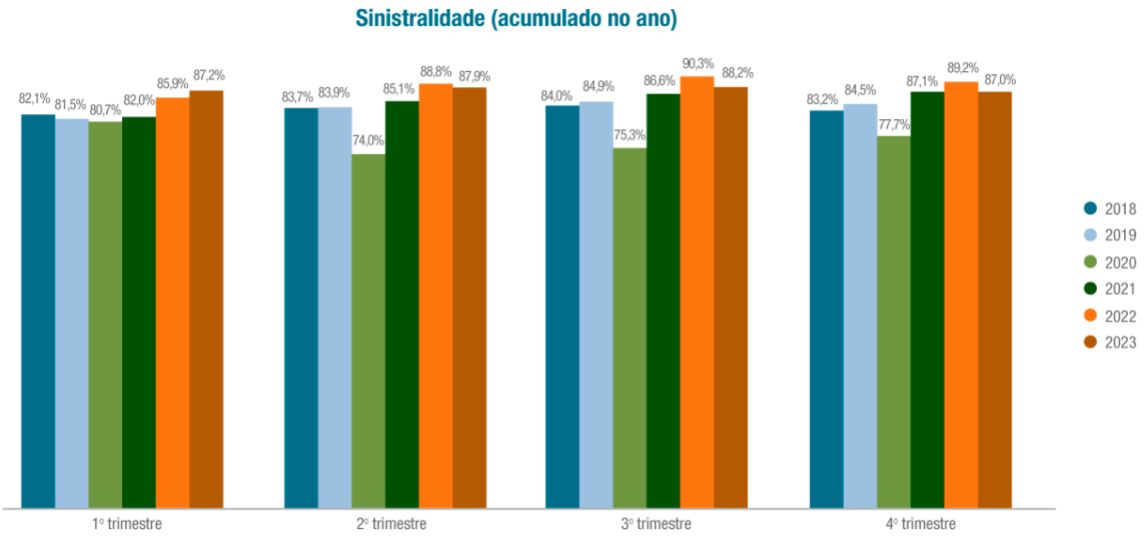
Fonte: ANS, 2024

Sinistralidade

A sinistralidade, principal indicador que explica o desempenho nas operadoras médico-hospitalares, registrou no ano de 2023 o valor de 87,0% (2,2 pontos percentuais abaixo do apurado no ano anterior), o que indica que em torno de 87% das receitas advindas das mensalidades são utilizadas com as despesas assistenciais.

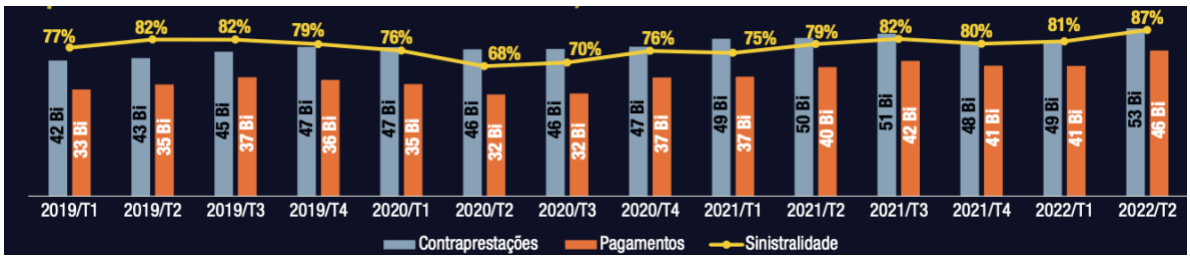
Tal resultado, embora ainda superior ao observado nos anos pré-pandemia e fortemente impulsionado por algumas das maiores operadoras do país, é o melhor dos últimos três anos. A redução da sinistralidade atual em relação aos mesmos períodos dos anos anteriores resulta, principalmente, da recomposição das mensalidades dos planos – em especial das grandes operadoras – quando comparada à variação das despesas. Sobre este aspecto, cabe ressaltar que continua a se observar uma tendência de maior crescimento das mensalidades médias (ajustadas pela inflação do período observado) em relação à despesa assistencial por beneficiário (também ajustada pela inflação), o que parece sugerir que o setor passa por um período de reorganização de seus contratos, a fim de recuperar os resultados na operação. Isso ocorre em um contexto de aumento de beneficiários e queda dos juros básicos da economia brasileira – que tendem a reduzir o resultado financeiro em relação aos períodos anteriores.

Gráfico 05. Sinistralidade (acumulado no ano de 2024)



Fonte: ANS, 2024

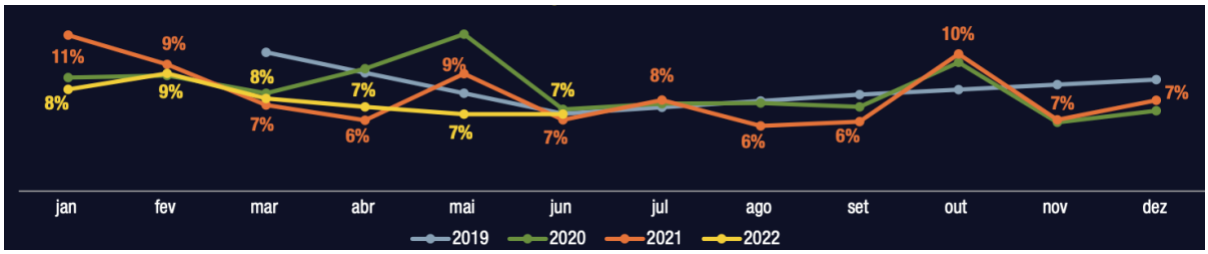
Gráfico 06. Recebimentos de pagamento dos beneficiários (contraprestações), valores pagos a fornecedores e prestadores assistenciais e sinistralidade de caixa, com dados trimestrais[1]



Fonte: ANS, 2022

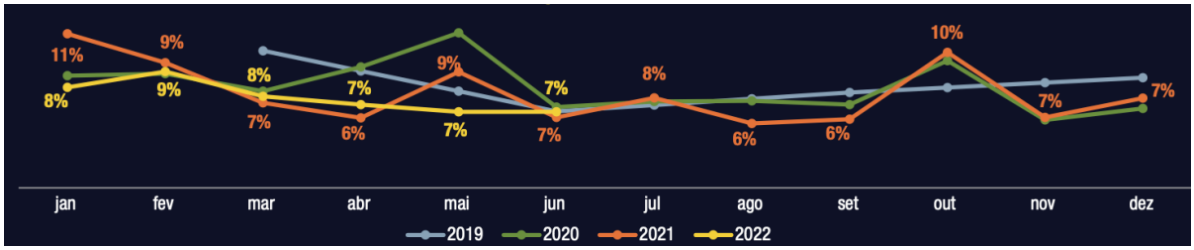
[1] De acordo com a ANS (2021, n.p.), os dados das contraprestações e pagamentos dos meses que compõem o trimestre são somados para compor o respectivo trimestre, entretanto o índice de sinistralidade mais uma vez não é calculado como uma média de números mensais do agregado da amostra, mas sim pela mediana da sinistralidade das operadoras da amostra. Consequentemente, a mediana encontrada no trimestre agregado não necessariamente se encontra entre os valores da mediana verificada mensalmente.

Gráfico 07. Inadimplência[2] de planos com preço preestabelecido (apurada no mês de cobertura)



Fonte: ANS, 2022

Gráfico 08. Inadimplência[3] de planos com preço preestabelecido por tipo de contratação (apurada no mês de cobertura)



Fonte: ANS, 2022

3.1.7.3. Concentração do mercado de planos de saúde

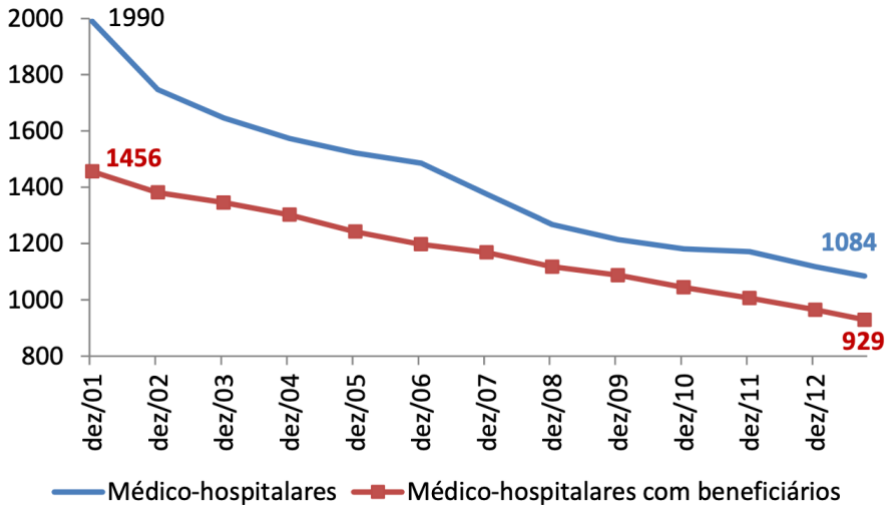
O contexto descrito acima auxilia na compreensão do atual contexto de concentração do mercado de planos de saúde, na medida em que este, como afirma Azevedo et al. (2016, p. 14-5) "tende a ser mais eficiente na presença de número reduzido de empresas de maior porte e mais integradas verticalmente". Por um lado, algum nível de concentração tende a ser positivo, uma vez que pode levar as empresas do SBPS a ter condições de oferecer garantia a suas operações (ALMEIDA, 2009 apud AZEVEDO et al. 2016, p. 19). Por outro, a concentração de mercado, e a escala de operações necessária para que a OPS possa fazer frente às falhas de

[2] Segundo a ANS (2021, n.p.), os índices de inadimplência foram calculados pela mediana dos índices de cada operadora individualmente (não por dados agregados), visando eliminar o viés da amostra pelos maiores valores. Os dados de cada ano são apresentados em linhas distintas para facilitar a visualização. Entre os meses de março, junho, setembro e dezembro de 2019, e em janeiro de 2020, foi usada interpolação linear. Isto porque tais informações foram coletadas trimestralmente via DIOPS/ANS até o início da pandemia; após, dados mensais também, via RI.

[3] De acordo com a ANS (2021, n.p.), em março de 2019, maio e outubro de 2020 e janeiro, fevereiro e outubro de 2021 foram identificados valores mais elevados de inadimplência, provavelmente como efeito de datas de vencimento ocorrido em final de semana. O índice considera inadimplência a parcela vencida e não paga integralmente ao fina do mês da cobertura. Em julho de 2021, ainda que o último dia do mês tenha transcorrido em um final de semana, esse efeito não foi percebido de forma tão intensa

mercado, impõe barreiras e dificuldades a empresas de menor porte e, portanto, diminui ou elimina a concorrência. O gráfico abaixo ilustra a tendência de concentração do mercado.

Gráfico 09. Operadoras de planos privados de saúde em atividade (Brasil, 2001-2013)

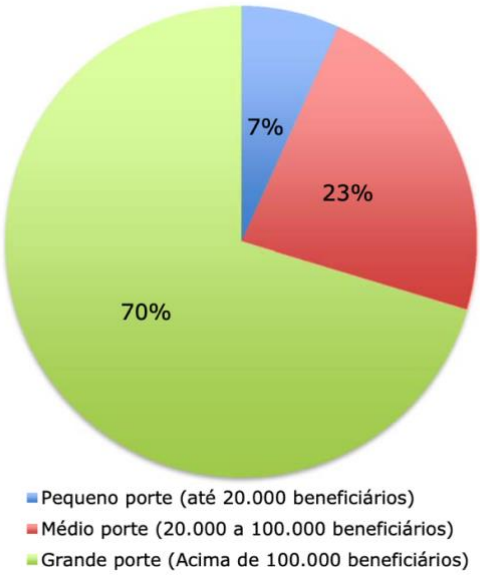


Fonte: Azevedo et al., 2016, p. 19

Com efeito, há evidências de que o mercado de saúde venha se concentrando, nas últimas décadas, no mecanismo favorecido pelas vantagens obtidas pelo SBPS no efeito de economia de escala que, ao mesmo tempo, impõem barreiras à entrada de novos competidores, que precisam ingressar neste mercado já dotados de vultosa carteira de beneficiários. Desta forma, práticas que podem prejudicar os consumidores podem ser adotadas pelas OPS, como o reajuste excessivo de preços dos planos e diminuição na qualidade do atendimento, sem que estes fatores sejam combatidos pelos mecanismos de concorrência (AZEVEDO et al., 2016, p. 20). Falhas de mercado como essa justificam a existência de mecanismos de regulação, conforme discutiu-se neste trabalho.

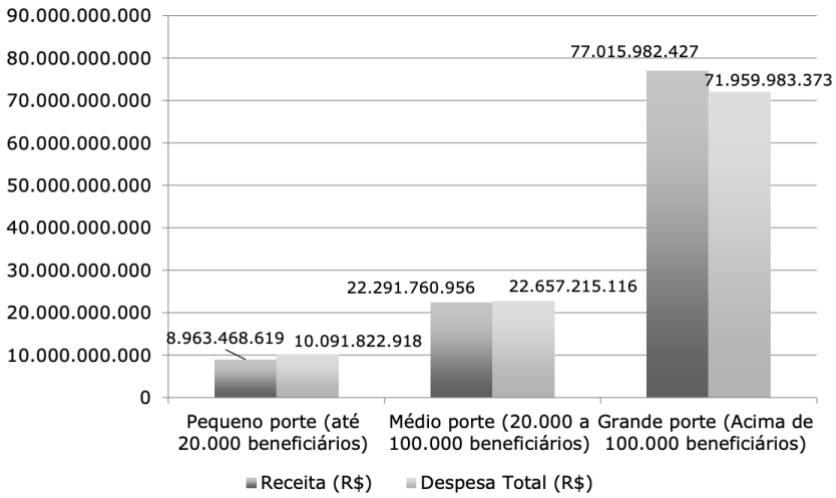
Nos gráficos abaixo, nota-se que a proporção de OPS de grande porte atuando no mercado em 2013 já sugeria esta tendência de concentração. Dados da ANS mostram neste período que apenas as empresas de grande porte auferiram lucro. Dentre as OPS de pequeno porte, o déficit registrado foi de, em média, 10%:

Gráfico 10. Operadoras de planos de saúde por porte



Fonte: Azevedo et al., 2016, p. 47

Gráfico 11. Receitas e Despesas das OPS por porte em 2013



Fonte: Azevedo et al., 2016, p. 48

Os dados apresentados na tabela abaixo demonstram a diminuição progressiva no número de OPS nos últimos 10 anos, isto ocorre em função do maior nível de controle e governança.

Tabela 27. Operadoras com beneficiários no período entre 2014-2024

Ano	Operadoras médico-hospitalares	Operadoras exclusivamente odontológicas	Total de operadoras com beneficiários
Dez/14	874	343	1.217
Dez/15	828	327	1.155
Dez/16	790	305	1.095
Dez/17	766	291	1.057
Dez/18	749	289	1.038
Dez/19	727	280	1.007
Dez/20	711	260	971
Dez/21	703	254	957
Dez/22	692	241	933
Dez/23	680	238	918
Out/24	670	235	905

Fonte: Cadastro de Operadoras / ANS/MS e Sistema de Informações de Beneficiários - SIB/ANS/MS (2024).

Tabela 28. Receita de contraprestações das OPS (em R$) entre 2014-2024

Ano	Receita de contraprestações	Outras receitas operacionais	Despesa assistencial	Despesa administrativa	Despesa de comercialização	Outras despesas operacionais	Receitas Administrativas
2014	127.777.444.503	14.910.944.501	106.496.081.722	16.816.617.032	4.172.816.917	15.048.990.235	0
2015	144.701.906.083	15.333.832.284	120.119.877.388	17.830.659.710	4.839.088.798	16.111.089.254	0
2016	163.246.294.916	17.240.240.037	137.123.914.097	19.372.921.338	5.384.362.883	17.946.513.808	0
2017	180.893.859.503	17.028.477.006	150.583.574.465	20.176.363.171	5.455.991.738	18.025.945.719	0
2018	197.438.238.418	13.268.654.502	161.469.397.459	20.578.358.346	5.924.588.751	16.236.544.754	0
2019	213.457.018.559	12.738.781.354	174.539.061.631	21.540.715.476	6.503.128.793	16.293.459.922	0
2020	223.431.176.273	10.811.263.760	167.220.246.487	21.873.199.058	7.202.207.791	17.516.332.484	0
2021	245.402.959.767	12.989.073.926	207.649.359.814	24.023.848.908	7.981.025.537	18.121.093.198	0
2022	238.308.332.614	15.540.109.565	208.138.594.141	25.930.435.596	8.363.982.290	20.728.471.337	22.600.492
2023	282.295.323.509	15.750.144.641	240.833.081.946	28.618.908.009	9.606.554.566	23.871.724.085	348.728.404
2024	233.834.093.460	13.946.055.673	193.833.869.424	22.498.438.907	8.091.679.980	19.451.343.046	37.399.421

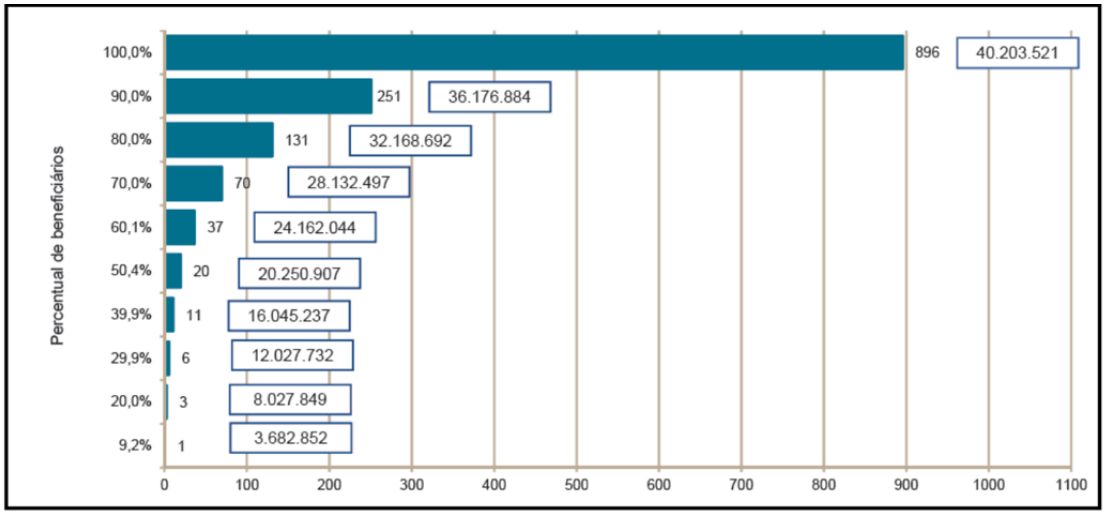
Fonte: DIOPS/ANS/MS (2024).

Abaixo, prossegue a discussão analisando a evolução da movimentação econômica e do número de beneficiários das OPS brasileiras.

3.1.7.4. Evolução da movimentação econômica do setor brasileiro de planos de saúde

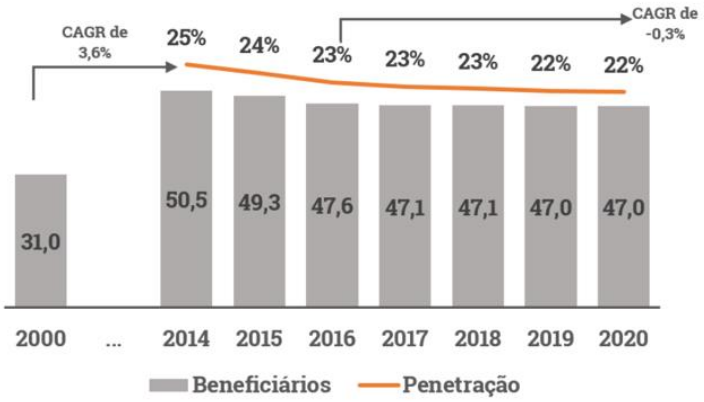
O mercado de planos de saúde vem apresentando, em termos de movimentação econômica, crescimento contínuo desde sua implantação, ainda que o número de beneficiários tenha oscilado. Como vemos no gráfico abaixo, entre os anos de 2014 e 2017, o número de beneficiários de planos de saúde caiu de 51 para 47.1 milhões, após um crescimento médio anual de 3,6% registrado entre 2000 e 2014 (PINI; SOARES; UNGARETTI, 2021).

Gráfico 12. Distribuição dos beneficiários de planos privados de assistência médica coletivos entre as operadoras (Brasil, junho/2014)



Fonte: Carmo, 2016, p. 66

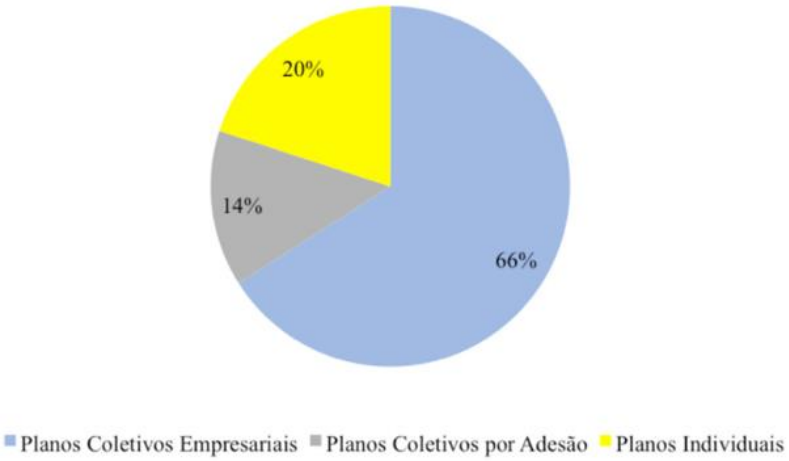
Gráfico 13. Beneficiários de Planos de Saúde (milhões) e Penetração (%) - período de 2014 a 2017



Fonte: Pini; Soares; Ungaretti, 2021

O Relatório de Gestão da ANS registrava, em 2015, um total de 1095 empresas brasileiras de planos de saúde com registros ativos, composto de 72% de operadoras no segmento médico-hospitalar e 28% no segmento odontológico (LIMA e SOUZA, 2019, p. 235). Em 2017, verifica-se ainda que esta composição estava bastante associada a contratos coletivos empresariais, vinculados à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária, representando naquele ano 66% do total de beneficiários (LIMA e SOUZA, 2019, p. 235).

Gráfico 14. Tipos de Planos de Saúde (Brasil, 2017)

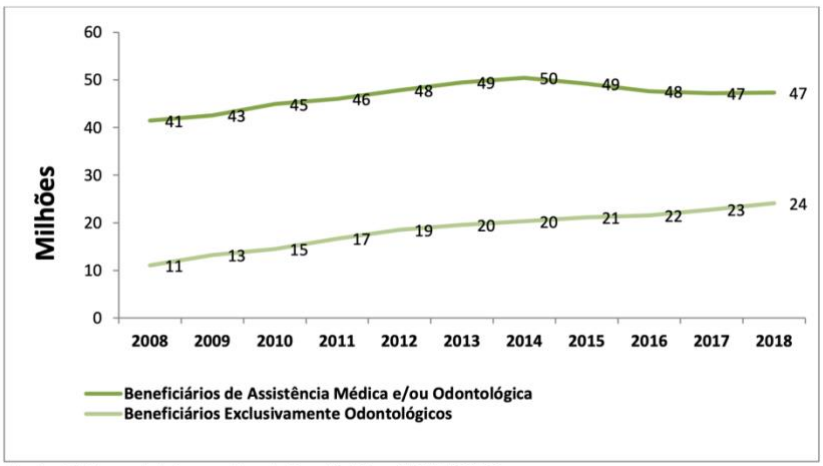


Fonte: Lima; Souza, 2019, p.236

Dados coligidos e analisados por Balbinotto Neto (2020), mostram por sua vez, como a participação do setor de saúde na economia brasileira vem aumentando. Para o período compreendido entre 2010 e 2017, as Contas de Saúde mostram um crescimento de 8% do PIB em 2010 para 9,2% do PIB em 2017, representando um valor de R$ 608,30 bilhões, uma despesa per capita anual de R$2.940,00. No tocante à participação das atividades de saúde no total das remunerações, o aumento foi de 8,3% para 9,6% no mesmo período. Para Balbinotto Neto (2020), estes dados mostram que o setor de saúde vem se tornando cada vez mais relevante no cenário econômico brasileiro, "tanto em termos de sua participação no PIB como fator gerador de renda e emprego".

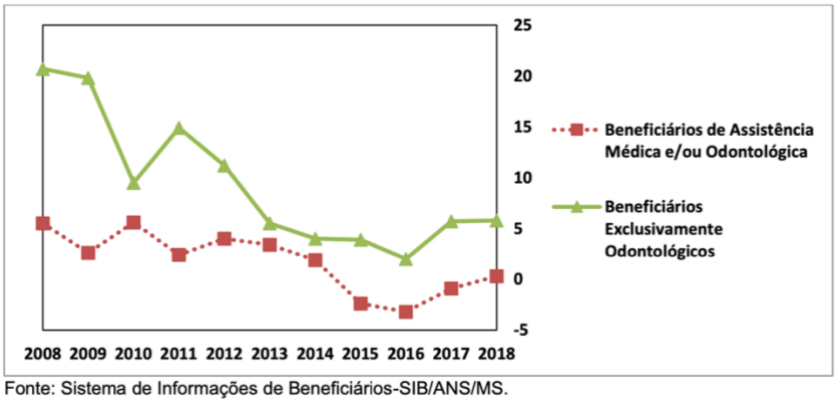
Observa-se, nos gráficos abaixo, a retomada do número de beneficiários na década compreendida entre 2008 e 2018, dado que ilustra a intensificação da participação da prestação de serviços de saúde na economia brasileira no período. Estes números representam um aumento de 14,63% para os de planos de assistência médica e 118,18% para os planos exclusivamente odontológicos (RODRIGUES NETO, 2019, p. 13).

Gráfico 15. Beneficiários de planos privados de saúde, por cobertura assistencial (Brasil, 2008-2018)



Fonte: Rodrigues Neto, 2019, p.14

Gráfico 16. Beneficiários de planos privados de saúde, por cobertura assistencial (Brasil, 2008-2018)



Fonte: Rodrigues Neto, 2019, p.14

Em 2021, em plena vigência da pandemia de Covid-19, registrou-se aumento de 1,83% nas contratações de planos de saúde na modalidade médico-hospitalar, acentuando-se a tendência de ênfase nos planos coletivos empresariais, que cresceu 2,47% em comparação com o primeiro trimestre de 2020 (BLOXS, 2021).

Tabela 29. Beneficiários de planos privados de saúde, por cobertura assistencial, no período 2012-2022

Ano	Beneficiários em planos privados de assistência médica com ou sem odontologia	Beneficiários em planos privados exclusivamente odontológicos
Dez/12	47.846.092	18.538.837
Dez/13	49.491.826	19.561.930
Dez/14	50.531.748	20.081.836
Dez/15	49.279.085	20.780.720
Dez/16	47.685.266	21.181.491
Dez/17	47.137.029	22.263.252
Dez/18	47.117.237	24.073.668
Dez/19	47.053.327	25.597.931
Dez/20	47.456.197	26.501.063
Dez/21	48.891.138	28.888.334
Jun/22	49.664.356	29.842.380

Fonte: Sistema de Informações de Beneficiários - SIB/ANS/MS, 2022

Tabela 30. Beneficiários de planos privados de saúde, por época de contratação do plano, segundo cobertura assistencial e tipo de contratação do plano (Brasil, junho/2022)

Cobertura assistencial e tipo de contratação do plano	Planos		
	Novo	Antigo	Total
Assistência médica com ou sem odontologia	**46.620.480**	**3.043.876**	**49.664.356**
Individual ou Familiar	8.108.205	886.386	8.994.591
Coletivo Empresarial	33.231.701	1.107.303	34.339.004
Coletivo por adesão	5.279.922	1.002.021	6.281.943
Coletivo não identificado	396	0	396
Não Informado	256	48.166	48.422
Exclusivamente odontológicos	**29.604.747**	**237.633**	**29.842.380**
Individual ou Familiar	5.258.020	1.547	5.259.567
Coletivo Empresarial	21.500.267	208.083	21.708.350
Coletivo por adesão	2.844.779	23.736	2.868.515
Coletivo não identificado	1.628	0	1.628
Não Informado	53	4.267	4.320

Fonte: Sistema de Informações de Beneficiários - SIB/ANS/MS, 2022

Tabela 31. Taxa de crescimento (%) do número de beneficiários em relação a dezembro do ano anterior, período de 2012-2022

Ano	Beneficiários em planos privados de assistência médica com ou sem odontologia	Beneficiários em planos privados exclusivamente odontológicos
Dez/2012	4,0	11,2
Dez/2013	3,4	5,5
Dez/2014	2,1	2,7
Dez/2015	-2,5	3,5
Dez/2016	-3,2	1,9
Dez/2017	-1,1	5,1
Dez/2018	0,0	8,1
Dez/2019	-0,1	6,3
Dez/2020	0,9	3,5
Dez/2021	3,0	9,0
Jun/2022	1,6	3,3

Fonte: Sistema de Informações de Beneficiários-SIB/ANS/MS
Dados atualizados até 07/2022

Fonte: Sistema de Informações de Beneficiários - SIB/ANS/MS, 2022

3.1.7.5. Distribuição geográfica do SBPS - Mercados Relevantes

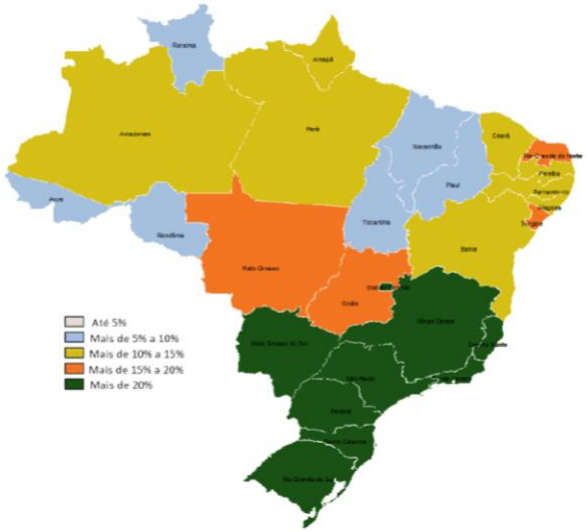
A RDC No. 77, de 17 de julho de 2001, classifica as empresas brasileiras de planos de saúde de acordo com suas regiões de atuação, sendo a oferta pública de serviços de saúde bastante desigual entre as diferentes regiões do país. A dependência do SUS em relação à iniciativa privada para oferecer acesso público a serviços de média e alta complexidade é uma realidade que não tem perspectivas de mudança (SÁ et. al., 2021, p. 10).

A delimitação dos mercados relevantes é uma ferramenta importante para o regulador, que permite avaliar a concentração dos diferentes mercados e identificar as empresas que detém poder de mercado. No âmbito da ANS, a compreensão dos mercados relevantes fornece subsídios para diversas atividades, em especial, para a regulação econômico-financeira das operadoras (ANS, 2021, p. 15).

A distribuição das empresas brasileiras de Planos de Saúde em relação às Regiões de Saúde é heterogênea, concentrando-se principalmente nas regiões Sul e Sudeste. Esta concentração é

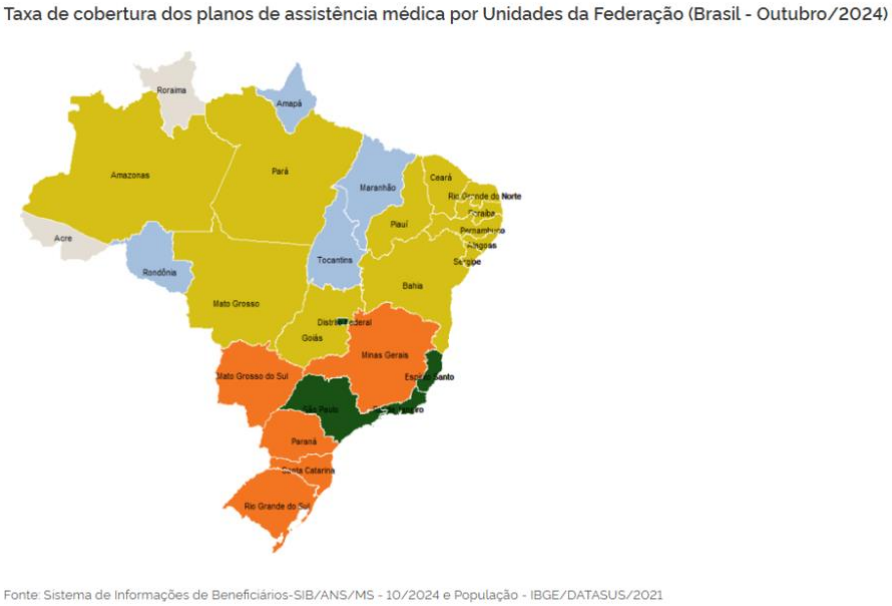
associada aos processos de urbanização e industrialização brasileiros, que trouxeram consigo aumento da renda e do emprego formal (LIMA; SOUZA, 2019, p. 235). Em 2022, a tendência de concentração em algumas regiões permanece, com os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, liderando a concentração de OPS ofertando serviços (RODRIGUES NETO, 2019, p. 16).

Figura 08. Taxas de cobertura de assistência médica por Unidades da Federação em 2009



Fonte: Sistema de Informações de Beneficiários - SIB/ANS/MS e População - IBGE /DATASUS, 2012

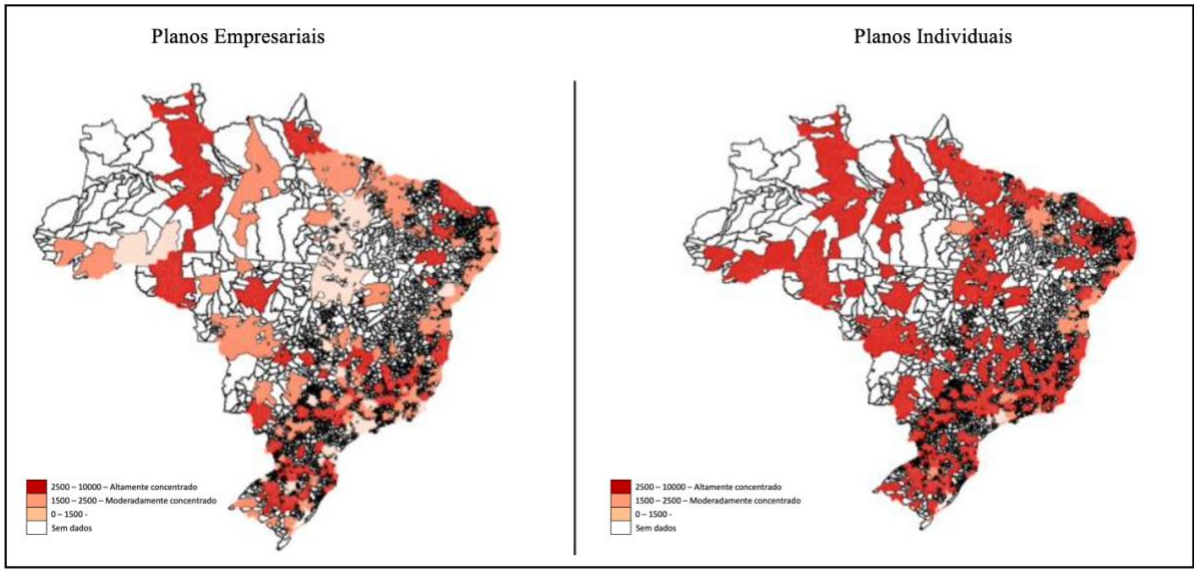
Figura 09. Taxas de cobertura de assistência médica por Unidades da Federação em 2024



Fonte: Sistema de Informações de Beneficiários - SIB/ANS/MS e População - IBGE /DATASUS, 2012

Abaixo, o Mapa de mercados relevantes geográficos, de Aranovich e Leandro (2021), elaborado de acordo com o índice Herfindal-Hirschman (HHI), detalha esta concentração.

Figura 10. Mapa de HHI dos mercados relevantes geográficos



Fonte: Ferreira; Pontual, 2020 apud Aranovich; Leandro, 2021, p. 81

A figura apresenta a distribuição dos planos de saúde empresariais e individuais pelo Brasil em 2020, mostrando uma alta concentração nos mercados relevantes. Esses mercados são definidos como o menor espaço em que o poder de mercado pode ser exercido por um agente ou grupo de agentes coordenados. A regulação utiliza essa definição como instrumento de monitoramento do mercado, permitindo avaliar tendências de concentração e desenvolver políticas públicas e instrumentos regulatórios. A Lei nº 9656/98 marcou o início da transição para o modelo regulatório das OPS, equiparando a prestação de serviços de saúde ao sistema financeiro nacional. Esse marco estabeleceu as dinâmicas de forças entre os três tipos de atores discutidos nesta tese.

3.2. Caracterização dos atores

Nesta seção da tese será descrito o papel, as responsabilidades e expectativas de três grupos cujos interesses estão relacionados ao desempenho econômico do SBPS, identificando os

conflitos que emergem em torno da principal convergência: o interesse na sustentabilidade das empresas ao longo do tempo. As empresas, portanto, precisam estabelecer estratégias de financiamento que, ao mesmo tempo que levem em conta as regras regulatórias da ANS, obtenham desempenho econômico que satisfaça gestores, sócios, proprietários, investidores e acionistas (BRAGA, 2017, p. 34-5).

3.2.1. ANS - Função de Regulação e sua Atuação no Setor Brasileiro de Planos de Saúde

3.2.1.1 O ambiente regulatório do setor de saúde

Com o crescimento do mercado de planos de saúde, o governo federal passou a mediar e regular as relações entre o provimento público e privado dos serviços de saúde. Diversos agentes interferem no funcionamento do Sistema de Saúde Suplementar, incluindo o Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e outras associações. A ANVISA é responsável pela regulação sanitária e econômica das atividades econômicas relacionadas à saúde, enquanto o CADE atua na defesa da concorrência, analisando atos de concentração e condutas praticadas pelas empresas e associações de classe (CARMO, 2016; AZEVEDO et al., 2016).

3.2.1.2 A Agência Nacional de Saúde

A ANS é um órgão regulador que tem como finalidade promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais (Lei nº 9.661, 2000). A agência monitora a qualidade dos serviços prestados pelas OPS por meio de programas como o Programa de Qualificação Operacional (PQO) e a Resolução Normativa 507, que dispõe sobre o Programa de Acreditação de Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde (BRASIL, 2022). O Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS), é um índice que reflete os resultados da avaliação das OPS, estabelecendo uma pontuação com base em indicadores de avaliação nas seguintes categorias: qualidade em atenção à saúde, garantia de acesso, sustentabilidade de mercado e gestão de processos e regulação (ANS, 2020). A divulgação da pontuação das OPS no IDSS torna mais transparente o sistema de publicização das informações sobre as OPS, reduzindo assim a assimetria de informação e estimulando a concorrência.

Figura 11. Exemplo de tabela de divulgação da pontuação das OPS no IDSS de acordo com as dimensões avaliadas.

Dimensão	Nome Fantasia	Indicador do Ano-Base 2020	Peso
Global	Selo de Qualidade	Programa de Operadora Acreditada - Pontuação Base no IDSS da OPS de acordo com o Nível de Acreditação obtida	Pontuação Base no IDSS: Nível I: 0,30 Nível II: 0,23 Nível III: 0,15
IDQS	Estímulo ao Parto Normal	1.1 - Proporção de Parto Cesáreo	3
	Atenção ao Pré-Natal	1.2 - Taxa de Consultas Pré-Natal	2
	Fratura em Idosos	1.3 - Taxa de Internação por Fratura de Fêmur em Idosos	2
	Cuidado Integral da Criança até os 4 anos	1.4 – Razão de Consultas Ambulatoriais de Pediatria por Beneficiário de 0 a 4 anos	2
	Preventivo de Câncer de Colo do Útero	1.5 - Taxa de Citopatologia Cérvico-Vaginal Oncótica	2
	Cuidado ao Diabético	1.6 - Taxa de Exames de Hemoglobina Glicada	3
	Prevenção da Cárie	1.7 - Proporção de Procedimentos Preventivos em Saúde Bucal - CÁRIE	2
	Cuidados com a Gengiva	1.8 - Proporção de Procedimentos Preventivos em Saúde Bucal - PERIODONTIA	2
	Cuidado Integral do Idoso	1.9 Razão de Consultas Médicas Ambulatoriais com Generalista/Especialista para idosos	3
	Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças dos Clientes	1.10 - Programa de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças - Pontuação Base	Pontuação base de 0,10 na IDQS
	Participação do Plano de Saúde em Projetos de Qualidade	1.11 Participação em Projetos de Indução da Qualidade da ANS Pontuação Base	Pontuação Base de até 0,30 na IDQS
	Adoção de remuneração que considere a qualidade para hospitais, clínicas, laboratórios e profissionais de saúde	1.12 - Participação no Projeto de Modelos de Remuneração Baseados em Valor- Pontuação Base	Pontuação base de 0,10 na IDQS
IDGA	Renal Crônico	2.1 Taxa de Sessões de Hemodiálise Crônica por Beneficiário	1
	Médico de Referência do Idoso	2.2 - Taxa de Consultas Médicas Ambulatoriais com Generalista por Idosos	2
	Acesso a Urgência e Emergência	2.3 - Índice de Dispersão Combinado de Serviços de Urgência e Emergência	1
	Consulta com Dentista	2.4 - Taxa de Primeira Consulta ao Dentista no ano por Beneficiário	1
	Acesso ao Dentista	2.5 - Índice de Dispersão Combinado da Rede Assistencial Odontológica	1
	Qualidade de Hospitais	2.6 - Frequência de Utilização de Rede de Hospitais com Atributo de Qualidade	1
	Qualidade de Laboratórios	2.7 - Frequência de Utilização de Rede de SAUTcom Atributo de Qualidade	1
	Acesso à Contratação Individual	2.8 - Índice de efetiva comercialização de planos individuais - Bônus	Bônus de até 10% sobre a IDGA
IDSM	Solidez do seu Plano de Saúde	3.1 - Índice de Capital Regulatório (ICR)	3
	Resolução de Queixas do Cliente	3.2 - Taxa de Resolutividade de Notificação de Intermediação Preliminar	2
	Reclamações Gerais do Cliente	3.3 - Índice Geral de Reclamações (IGR)	1
	Preço do Plano de Saúde	3.4 - Proporção de NTRPs com Valor Comercial da Mensalidade Atípicos	1
	Satisfação do Cliente/Paciente	3.5 - Pesquisa de Satisfação do Beneficiário - Pontuação Base	Pontuação Base de 0,25 na IDSM
	Gestão Financeira Ativa	3.6 -Autorização prévia anual para movimentação da carteira de títulos e valores mobiliários - Bônus	Bônus de 10% sobre a IDSM
	Moderação de Reajustes	3.7 - Índice de Reajuste Médio Ponderado aplicado aos Planos Coletivos	0
IDGR	Qualidade dos Dados do Cadastro do Cliente	4.1 Índice composto de Qualidade Cadastral (SIB)	2
	Utilização do SUS por Cliente de Plano de Saúde	4.2 - Taxa de utilização do SUS	1
	Qualidade da Informação em Saúde Enviada para a ANS	4.3 - Razão de Completude do Envio dos Dados do Padrão TISS (Razão TISS)	2
	Relacionamento do Plano de Saúde com Hospitais, Laboratórios e Profissionais de Saúde	4.4 - Proporção de Glosas de Pagamentos a Prestadores de Serviços de Saúde	1
	Qualidade dos Dados do Diagnóstico	4.5 Proporção de Diagnósticos Inespecíficos nos Eventos de Internação Preenchidos nas Guias TISS - Bônus	Bônus de 10% sobre a IDGR

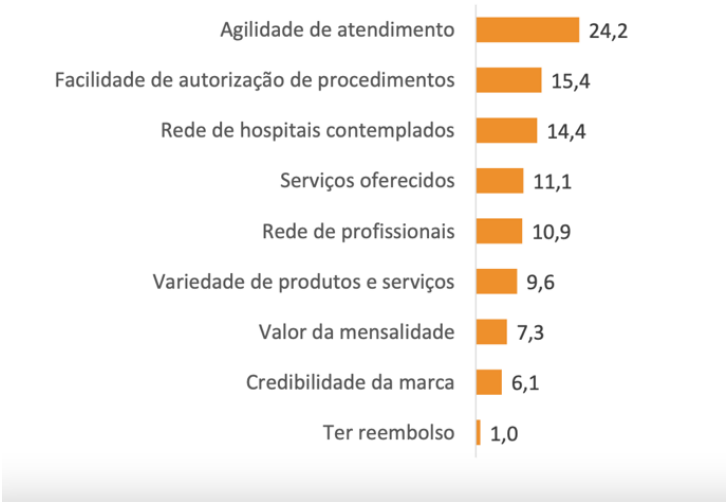
Legenda

Dimensão	Nome	Nome Fantasia das Dimensões
IDQS	Dimensão Qualidade em Atenção à Saúde	Qualidade da Assistência Médica Prestada
IDGA	Dimensão Garantia de Acesso	Qualidade e Acesso aos Hospitais, Laboratórios e Profissionais de Saúde
IDSM	Dimensão Sustentabilidade de Mercado	Satisfação do Cliente e Solidez do Plano de Saúde
IDGR	Dimensão Gestão de Processos e Regulação	Qualidade da Gestão Administrativa do Plano de Saúde

Fonte: ANS, 2020

Ainda, sob a perspectiva dos beneficiários, cabe destacar os resultados da pesquisa realizada pela Associação Nacional das Administradoras de Benefícios (ANAB), que em 2021 constata os seguintes atributos mais importantes para um plano de saúde:

Figura 12. Os atributos mais importantes dos planos de saúde, de acordo com levantamento feito pela ANAB em 2021, junto a beneficiários de planos de saúde



Fonte: ANAB, 2021, p. 9

A qualidade dos serviços prestados pelas Operadoras de Planos de Saúde (OPS) está relacionada à instalação física médico-hospitalar, incluindo a arquitetura, infraestrutura predial e sistemas de informação, bem como o parque de equipamentos instalados (PEREIRA, 2020). É importante que esses aspectos estejam adequados à RDC 50 da ANS, que dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde (ANS, 2002).

A governança das OPS deve adotar práticas mínimas para gerenciamento de riscos e promover a solvência da operadora, conforme a RN 518 da ANS (BRASIL, 2022). A transparência de dados, equidade no tratamento de proprietários e beneficiários, responsabilidade nos processos de prestação de contas, e responsabilidade corporativa são princípios que devem ser observados nas práticas de governança, assim como as práticas e estruturas destas devem ser formalizadas e amplamente disponibilizadas às partes interessadas (BRASIL, 2019). Enfatiza-se a importância dos aspectos econômico-financeiros na governança das OPS.

3.2.1.3 Objetivos da Agência Nacional de Saúde

A ANS tem como objetivo a manutenção do equilíbrio do mercado, o controle da assimetria de informação e a maximização da participação do consumidor no mercado privado de saúde. Para tanto, a mesma estabelece padrões financeiros, regula cláusulas contratuais, publicidade de planos de saúde, e as relações entre OPS e prestadores de serviços. A permanência das OPS no setor depende do atendimento das exigências da ANS quanto à constituição de reservas e garantias que assegurem a solvência das OPS e a qualidade dos serviços prestados aos beneficiários. A monitorização intensiva da ANS sobre as OPS condiciona as decisões dos gestores e proprietários dessas empresas, o que pode comprometer a criação e maximização do valor do negócio de saúde. A saúde financeira das OPS é um aspecto crucial a ser estudado, envolvendo sua estrutura financeira e de capital (ARAUJO, 2004; BRAGANÇA, 2017; AVELAR; BOINA; SOUZA; AMARAL, 2019; FERREIRA et al. 2021; VIANA, 2021).

3.2.1.4 Impacto da regulação na gestão financeira e estrutura de capital das OPS

As OPS são prestadoras de assistência de saúde suplementar que oferecem serviços de interesse público, portanto, é fundamental garantir sua sustentabilidade econômico-financeira e qualidade dos serviços prestados. A ANS realiza o monitoramento financeiro das OPS por meio de indicadores estabelecidos para acompanhar sua evolução patrimonial e capacidade de honrar contratos. Desde 2019, as OPS devem implementar práticas mínimas de governança corporativa para garantir a confiabilidade das informações, eficiência na utilização de recursos e atendimento à legislação. Os riscos aos quais as OPS estão expostas incluem baixos índices de liquidez e altos índices de sinistralidade da carteira de beneficiários. A ANS pode detectar anormalidades e requerer um plano para solucioná-las, podendo adotar medidas como gestão técnica, regime especial de direção fiscal ou liquidação judicial.

A Resolução Normativa 532 de 2022 dispõe sobre os parâmetros e procedimentos de acompanhamento econômico-financeiro das OPS, que é realizado pela Gerência de Acompanhamento de Operadoras (LIMA; SOUZA, 2019; BRAGA, 2017; ANS, 2019; CARMO, 2016; REIS; MACEDO, 2021; ANS, 2022).

A RN 532/2022 estabelece que o acompanhamento das OPS tem como foco circunstâncias que possam afetar a sua situação patrimonial, econômica, financeira, administrativa e societária. Este acompanhamento é feito com base nos dados do Documento de Informações Periódicas das Operadoras (DIOPS) e resulta na NTAEF, instrumento que identifica eventuais

desconformidades que possam representar risco de descontinuidade ou queda de qualidade assistencial. Segundo a RN 532/2022, entre os critérios de análise das OPS estão as regras contábeis estabelecidas pelo Plano de Contas da ANS, que afetam a estrutura financeira das OPS, como as provisões técnicas, recursos próprios, ativos garantidores, lastro para as provisões técnicas e margem de solvência.

A ANS propôs um novo modelo de mensuração de Capital Baseado em Riscos (CBR), que inclui o risco operacional e o risco legal. O CBR é uma referência para determinar o Capital Regulatório (CR) exigido das operadoras de planos de saúde. A proposta para o modelo de mensuração de risco operacional foi baseada em *benchmarking*, recomendações internacionais e regulação de outros setores, além de dados de pesquisas com as operadoras. A falta de informações suficientes no setor levou a ANS a propor uma abordagem quantitativa, adaptada do modelo definido no Solvência II. A agregação do risco operacional e legal pode reduzir os valores de Capital Regulatório no setor, mas é necessário obter mais dados para aperfeiçoar o modelo (NUNES, 2021).

3.2.2. Os investidores e acionistas, representando os interesses privados

Em 2014, o gasto público em saúde no país representou 40% do valor total investido, enquanto em Portugal e no Reino Unido as proporções foram de 68% e 83%, respectivamente. O Brasil foi o país com menor alocação de orçamento público para saúde no período 2000-2014, entre países com sistemas de saúde semelhantes, universais e públicos (FIGUEIREDO et al., 2018). O número de operadoras de saúde ativas com beneficiários caiu de 2600 para 703 desde a criação da ANS em 1998, refletindo a complexidade da gestão das operadoras (BRAGANÇA, 2017).

O setor de saúde no Brasil passa por transformações intensas, com a entrada de capital estrangeiro, a criação de aplicativos e dispositivos de monitoramento da saúde e um cenário de lucro líquido acumulado de aproximadamente 15 bilhões de reais nos primeiros três trimestres de 2020 (BLOX, 2021). Empresas de saúde como NotreDame Intermédica, Raia Drogasil, Hapvida, Hypera, SulAmérica, Fleury e Qualicorp apresentam grande peso na carteira teórica do Ibovespa (B3SA3), sendo que a Rede D'Or São Luiz já era a nona empresa mais valiosa da bolsa brasileira pouco após seu IPO em junho de 2021 (BLOX, 2021).

Gráfico 17. Empresas de saúde na bolsa entre as mais valiosas

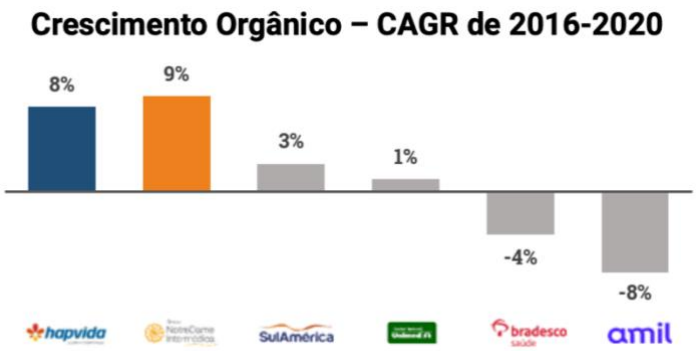


Fonte: Bronx, 2021

Tendo em vista o recorte deste trabalho, cabe observar que, dentre as OPS líderes de mercado em 2021, são classificadas como "medicina de grupo": Amil, Hapvida e Notre Dame Intermédica. Estas empresas se estabeleceram como tradicionais no mercado, caracterizando-se por estruturas verticalizadas de gestão e com oferta de atendimento aos usuários em rede própria. Avalia-se que por contarem com rede assistencial sob a mesma estrutura empresarial estas OPS podem possuir vantagens competitivas (OCKÉ-REIS; MARTINS; DRACH, 2021, p. 6).

Com efeito, verifica-se que o crescimento das operadoras verticalizadas conseguiu manter-se mesmo diante da oscilação do número de beneficiários registrada entre 2014 e 2020, conforme vimos acima. O gráfico abaixo ilustra o crescimento orgânico da Hapvida, GNDI, SulAmérica, Unimed, Bradesco Saúde e Amil:

Gráfico 18. Crescimento orgânico



Fonte: Pini; Soares; Ungaretti, 2021

De acordo com a nota técnica "Desempenho do Mercado de Planos de Saúde (2014-2018)", publicada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea, 2021), as operadoras de planos médico-hospitalares apresentaram resultados notáveis diante da estagnação da economia brasileira. Os pesquisadores Ocké-Reis, Leal e Cardoso (2021) afirmam que a queda da taxa de sinistralidade e o aumento da lucratividade foram os fatores responsáveis por esse desempenho.

Embora o número de usuários tenha registrado um pequeno aumento em 2018 em comparação com 2017, a participação dos planos individuais e familiares no mercado de planos de saúde diminuiu de 19,7% para 19,2% no período de 2014 a 2018. Por outro lado, os planos coletivos empresariais representavam 67,2% do total de usuários de planos de assistência médica em 2018, enquanto os planos coletivos por adesão abrangiam cerca de 13,6% do total de usuários (OCKÉ-REIS; LEAL; CARDOSO, 2021).

Os pesquisadores também destacam que a recuperação do número de usuários se deve principalmente à retomada do emprego formal, já que a maioria dos usuários é contratada pelos empregadores por meio de planos coletivos empresariais (OCKÉ-REIS; LEAL; CARDOSO, 2021). Os planos coletivos empresariais, tiveram um aumento de participação no mercado de planos de saúde, passando de 66,7% para 67,2% no período de 2014 a 2018 (OCKÉ-REIS; LEAL; CARDOSO, 2021). Portanto, os dados apresentados na nota técnica do Ipea indicam que, apesar da crise econômica, as operadoras de planos médico-hospitalares conseguiram manter sua lucratividade e apresentar resultados positivos, principalmente devido à retomada do emprego formal e ao aumento da participação dos planos coletivos empresariais no mercado de planos de saúde.

No Brasil, há um conflito de agência entre acionistas controladores e minoritários devido à concentração de propriedade (SILVEIRA et al., 2004). A presença de grandes acionistas controladores pode ter efeitos positivos, como o efeito-incentivo e a solução parcial para o problema de monitoramento dos gestores. Porém, também pode gerar efeitos negativos, como o efeito-entrincheiramento e a falta de diversificação, acarretando custos para as empresas (SILVEIRA *et al.*, 2004). As operadoras de planos de saúde tiveram resultados notáveis diante da estagnação da economia brasileira em 2018 (Ocké-Reis et al., 2019).

O modelo de governança das companhias abertas brasileiras é caracterizado pela concentração das ações com direito a voto nas mãos dos acionistas controladores, com uma ausência quase total de empresas com estruturas de propriedade pulverizadas (LEAL et al., 2002; MONACO, 2000; SILVEIRA, 2002). Em média, os acionistas controladores detêm 88% das ações emitidas com direito a voto (MONACO, 2000). Além disso, é comum a emissão de ações preferenciais, que compreendem em média 46% do capital total das companhias abertas, sendo utilizadas como o principal mecanismo de separação entre a propriedade e controle nas companhias (LEAL; VALADARES, 2002).

Essa concentração de controle nas empresas brasileiras é em parte explicada por incentivos dados no passado para a abertura de capital das companhias, que trouxe ao mercado de ações empresas que, na ausência de tais incentivos, provavelmente teriam sido mantidas privadas e controladas por poucos indivíduos (CLAESSENS et al., 2000). No entanto, essa concentração de controle pode gerar problemas, já que os benefícios de ter um grande acionista controlador, como um monitor mais eficaz dos gestores da companhia, são reduzidos em grande parte no Brasil (SILVEIRA et al., 2004).

Isso ocorre porque apesar da grande concentração das ações ordinárias, a emissão de elevado percentual de ações sem direito a voto e a utilização de esquemas piramidais fazem com que muitos controladores sejam, na verdade, acionistas minoritários das empresas controladas. Essa situação gera uma combinação de muito poder com baixa alocação de recursos próprios na companhia, diminuindo os benefícios de se ter um acionista controlador e aumentando o potencial de expropriação dos acionistas minoritários (SILVEIRA et al., 2004).

O setor de saúde tem sido alvo de grandes investimentos por parte de fundos de *private equity*, como é o caso do fundo Pátria e sua investida ATHENA SAÚDE, e da *Bain Capital*, que permaneceu por cerca de 8 anos no capital da Notre Dame Intermédica até a fusão com a Hap Vida, formando o maior grupo de saúde da América Latina. Esses investimentos são motivados

pela crescente demanda por serviços de saúde de qualidade, além da busca por eficiência e rentabilidade no setor.

O setor de saúde tem se mostrado um mercado atrativo para investimentos de fundos de *private equity*, como Pátria e *Bain Capital*, que buscam rentabilidade e eficiência no setor. A crescente demanda por serviços de saúde de qualidade é um dos fatores que impulsiona esse tipo de investimento (PÁTRIA INVESTMENTS, 2021; BAIN CAPITAL, 2021).

A busca por eficiência também é um fator relevante, uma vez que a gestão de custos e a otimização de processos são fundamentais para a manutenção da rentabilidade desses investimentos (MARTINS et al., 2020). Além disso, a consolidação do mercado de saúde, com a formação de grandes grupos, como o resultado da fusão entre Notre Dame Intermédica e Hap Vida, também é vista como uma estratégia para aumentar a eficiência e reduzir custos (MCKINSEY; COMPANY, 2020).

Nesse contexto, os interesses dos investidores e acionistas estão voltados para a maximização do retorno financeiro, por meio da busca por eficiência e rentabilidade no setor de saúde. A oferta de serviços de qualidade é um meio para alcançar esse objetivo, mas não é o único fator relevante para esses investidores (PÁTRIA INVESTMENTS, 2021; BAIN CAPITAL, 2021).

3.2.3. Aspectos das tomadas de decisão dos gestores sobre as dimensões econômico-financeiras

Pode-se classificar os principais tipos de decisões a serem tomadas em três grupos: investimento, financiamento, dividendos (ARAÚJO, 2004). Ainda, é importante considerar como as implicações advindas da regulação impactam na estrutura de capital das OPS. (BRAGA, 2017). A atuação da ANS impacta diretamente os gestores de Operadoras de Saúde, que precisam considerar as normas e diretrizes estabelecidas pela agência ao tomar decisões relacionadas a investimentos, financiamentos e dividendos.

O grupo de investimentos refere-se às decisões de alocação de recursos em projetos que visam aumentar a rentabilidade da empresa. Os gestores devem analisar cuidadosamente as oportunidades de investimento, levando em consideração o risco e o retorno esperado. Segundo Gitman (2010), é importante que os gestores utilizem técnicas de análise de investimentos, como o Valor Presente Líquido (VPL) e a Taxa Interna de Retorno (TIR), para avaliar a viabilidade dos projetos. No que se refere aos investimentos, a ANS estabelece regras para a constituição de reservas técnicas, que são fundos destinados a garantir o cumprimento das

obrigações financeiras da operadora. Além disso, a agência define limites para a aplicação dos recursos das operadoras em investimentos de maior risco, como ações e fundos de investimento. Os gestores precisam levar em conta essas restrições ao decidir onde alocar os recursos da empresa.

O grupo de financiamentos envolve as decisões relacionadas à obtenção de recursos para financiar os investimentos e as operações da empresa. Os gestores devem escolher a melhor fonte de financiamento, considerando o custo e o prazo de pagamento. Segundo Assaf Neto (2010), as principais fontes de financiamento são: capital próprio, empréstimos bancários, emissão de debêntures e *leasing*. No que diz respeito aos financiamentos, a ANS estabelece regras para a negociação de contratos com prestadores de serviços de saúde, como hospitais e clínicas. Os gestores precisam considerar essas normas ao definirem os valores a serem pagos pelos serviços prestados e ao negociar prazos e condições de pagamento.

O grupo de dividendos refere-se às decisões sobre a distribuição dos lucros da empresa aos acionistas. A ANS regula a cobrança de mensalidades dos beneficiários dos planos de saúde, o que impacta diretamente a receita das operadoras e, consequentemente, a capacidade de financiamento da empresa. Por sua vez, os gestores devem equilibrar a necessidade de reter lucros para financiar os investimentos futuros com a demanda dos acionistas por dividendos. Segundo Brigham e Ehrhardt (2010), os gestores devem considerar a política de dividendos da empresa, que pode ser conservadora, agressiva ou moderada.

Em resumo, os gestores de Operadoras de Saúde no Brasil devem tomar decisões estratégicas em relação aos investimentos, financiamentos e dividendos, visando maximizar a rentabilidade da empresa e garantir sua sustentabilidade financeira. Para isso, é importante que utilizem técnicas de análise financeira e considerem as diversas fontes de financiamento disponíveis. Ainda, os gestores de Operadoras de Saúde precisam estar atentos às normas e diretrizes estabelecidas pela agência ao tomar decisões relacionadas a investimentos, financiamentos e dividendos, a fim de garantir o sucesso econômico-financeiro da empresa.

Cabe destacar que os gestores das empresas do SBPS enfrentam constantes desafios econômico-financeiros, como a alta dos custos médicos e hospitalares, a regulação governamental e a competitividade do mercado. Para lidar com esses desafios, os gestores podem adotar estratégias operacionais, de financiamento e de investimento.

No âmbito operacional, os gestores podem buscar a eficiência na gestão dos recursos, por meio de ferramentas de gestão de custos, como a análise de indicadores e a negociação com

fornecedores. Além disso, a adoção de tecnologias de informação pode otimizar processos e reduzir custos, como a telemedicina e a gestão eletrônica de documentos. Já no âmbito de financiamento, os gestores podem buscar fontes de recursos para financiar suas atividades, como a captação de recursos no mercado de capitais ou a utilização de linhas de crédito. Enquanto, no âmbito de investimento, os gestores podem buscar oportunidades de investimento em áreas relacionadas à saúde, como a aquisição de clínicas e hospitais ou a expansão da rede de atendimento (ANDRADE et al. 2018).

De acordo com o estudo de Andrade et al. (2018), é fundamental que os gestores das operadoras de saúde busquem a diversificação de fontes de receita e de investimentos, para reduzir a exposição a riscos específicos do setor. Além disso, a adoção de práticas de governança corporativa e a transparência na divulgação de informações financeiras podem aumentar a confiança dos investidores e dos clientes, contribuindo para a sustentabilidade da empresa.

Tabela 32. Estratégias financeiras

Tipos de Estratégias Financeiras	**Descrição Sucinta**	**Direcionador de valor**
Operacionais	Focalizam principalmente sistemas de distribuição e logística com maior eficiência e maior giro de estoques.	Crescimento das vendas; prazos operacionais de cobrança e pagamentos; giro dos estoques; margem de lucro.
Financiamento	Compreendem as decisões relacionadas à substituição do capital próprio para financiamento das operações pelo capital de terceiros mais barato.	Estrutura de capital; custo do capital próprio; custo do capital de terceiros; risco financeiro.
Investimento	Podem ser implementadas pela busca eficiente de novas oportunidades de mercado e são criadoras de valor. Destaca-se que certas empresas apresentam seu sucesso fortemente lastreado em investimentos em novos produtos.	Investimento em capital de giro; investimento em capital fixo; oportunidades de investimentos; análise de giro *versus* margem; risco operacional.

Fonte: Braga, 2017, p. 34

Vale ainda destacar que, para criar valor e aumentar sua riqueza, as operadoras de planos de saúde precisam de estratégias que considerem a cultura organizacional, a gestão do conhecimento e a vantagem competitiva (GONÇALVES; COELHO; SOUZA, 2011). É necessário que a estrutura da organização seja adequada para a realização de estratégias adaptadas à criação de valor e ao atendimento às regras regulatórias da ANS (BRAGA, 2017).

Tabela 33. Novos papéis atribuídos às operadoras necessários para a criação de valor

Papel antigo: cultura da negação	Papel novo: possibilitar a competição baseada em valor e focada em resultados
Restringir a escolha de prestadores e de tratamento.	Possibilitar a escolha bem embasada por pacientes e médicos e o gerenciamento da saúde dos pacientes.
Microgerenciar os processos dos prestadores e as escolhas feitas por eles.	Mensurar e recompensar os prestadores com base nos resultados.
Minimizar o custo de cada serviço e tratamento.	Maximizar o valor dos serviços de saúde ao longo do prazo do ciclo de atendimento.
Engajar-se em papelada e transações administrativas complexas com os prestadores e clientes para controlar os custos e liquidar as faturas.	Minimizar a necessidade de transações administrativas e simplificar o faturamento.
Competir na minimização dos aumentos das mensalidades pagas pelos clientes.	Competir em resultados de saúde para os clientes.

Fonte: Braga, 2017, p. 35

Os novos papéis propostos por autores na área de planos de saúde contribuem para a criação de valor para a operadora (BRAGA, 2017, p. 36). Entretanto, é importante analisá-los no escopo das finanças corporativas, considerando as estratégias de financiamento de recursos. A regulamentação da ANS requer a criação de valor, mas também restringe a flexibilidade das decisões, exigindo um *trade-off* entre a criação de valor e a resolutividade dos serviços de saúde e satisfação dos beneficiários (BRAGA, 2017, p. 36).

O sucesso de uma operadora de planos de saúde está associado às estratégias financeiras focadas nas fontes de financiamento de recursos, que devem ser analisadas pelos gestores para obter uma estrutura de capital ótima, utilizando um mix de financiamentos e considerando o *trade-off* de risco e retorno (BRAGA, 2017, p. 36). Dessa forma, o desempenho esperado e a criação de valor poderão atender às expectativas dos *stakeholders*.

3.3. Modelos Teóricos adjacentes

3.3.1. Teoria da Agência

A Teoria da Agência visa explicar as relações contratuais que são estabelecidas entre os componentes de uma organização, tendo em conta que estes componentes são por natureza motivados pelos seus interesses. É uma relação contratual em que o principal instrui o agente a prestar algum serviço em seu benefício, delegando determinados poderes decisórios para esse fim (OLIVEIRA, 2016, p. 28). De acordo com Oliveira (2016, p.2 8), a Teoria da agência é geralmente entendida como uma "relação baseada na estrutura básica de um principal e um agente devidamente engajados em comportamento cooperativo, e que possuem objetivos e

atitudes diferentes em relação ao risco". O contrato firmado entre o principal e o agente é a unidade de análise da teoria da agência. Ressalta-se que esses contratos não necessariamente existem de forma física e/ou formalizada, podendo ser apenas informais (OLIVEIRA, 2016).

A Teoria da Agência é amplamente discutida na literatura financeira. Uma das principais referências sobre o assunto é o artigo seminal de Jensen e Meckling (1976), intitulado "*Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*". Outros autores importantes que contribuíram para o desenvolvimento da teoria da agência incluem Ross (1973), Myers (1984) e Fama e Jensen (1983). Esses estudos fornecem insights valiosos sobre como os conflitos de interesses entre acionistas e gestores podem afetar a estrutura de capital das empresas e como a estrutura ótima de capital pode ser determinada.

Em síntese, a teoria da agência é uma abordagem que busca entender as relações entre os agentes (gestores) e os principais (acionistas) em uma organização. De acordo com essa teoria, os gestores são contratados pelos acionistas para gerenciar a empresa e maximizar seus lucros, mas podem ter interesses próprios que não estão alinhados com os interesses dos acionistas. Essa divergência de interesses é chamada de problema de agência (JENSEN; MECKLING, 1976).

No contexto das empresas do SBPS, a Teoria da Agência pode ser aplicada para entender os desafios enfrentados pelos gestores em relação à gestão econômico-financeira. Segundo Ross (1973), essa teoria trata da relação entre um principal e um agente, em que o principal delega poderes ao agente para agir em seu nome. No entanto, há um conflito de interesses entre o principal e o agente, o que pode levar a comportamentos oportunistas por parte do agente. Nesse sentido, os acionistas das Operadoras de Saúde esperam que os gestores maximizem os lucros da empresa, enquanto os usuários dos serviços de saúde esperam que as Operadoras de Saúde ofereçam serviços de qualidade e que atendam às suas necessidades (ROSS, 1973).

Essa tensão entre os interesses dos acionistas e dos usuários pode levar a conflitos de interesse e a problemas de agência. Por exemplo, os gestores podem cortar custos de forma excessiva, o que pode comprometer a qualidade dos serviços oferecidos. Além disso, os gestores podem tomar decisões que beneficiam a si mesmos em detrimento dos acionistas e dos usuários (ROSS, 1973).

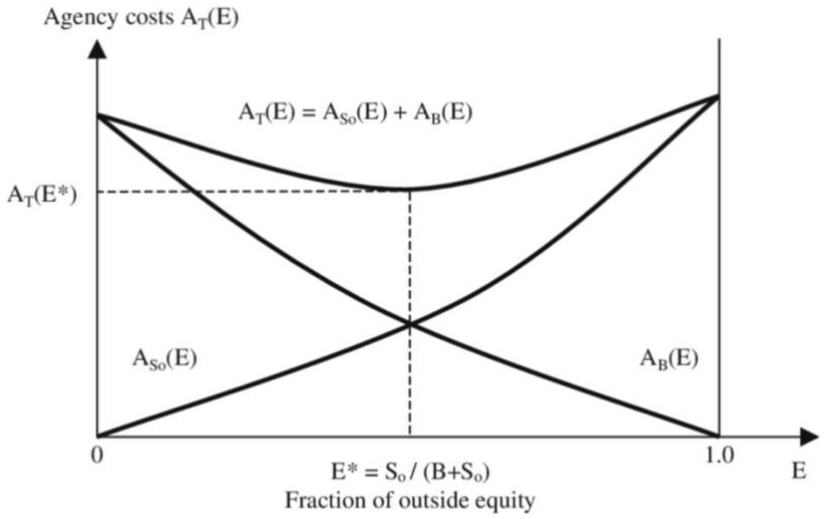
Para lidar com esses desafios, as Operadoras de Saúde precisam adotar práticas de gestão eficientes e transparentes, que permitam uma boa comunicação entre os gestores e os acionistas. Além disso, é importante que as Operadoras de Saúde sejam regulamentadas de

forma adequada pelo Estado, de forma a garantir que os interesses dos usuários sejam protegidos.

A Teoria da Agência é uma das principais abordagens para entender a estrutura ótima de capital. Segundo essa teoria, os conflitos de interesses entre os acionistas e os gestores de uma empresa podem levar a decisões que não maximizam o valor da empresa como um todo. A estrutura ótima de capital, nesse contexto, seria aquela que equilibra os benefícios e os custos de cada fonte de financiamento, levando em conta as preferências dos acionistas em relação ao risco e ao retorno, e que permite aos gestores manterem um certo grau de flexibilidade financeira. Dessa forma, a estrutura ótima de capital seria uma forma de minimizar os custos decorrentes da assimetria de informações e dos conflitos de agência, e de maximizar o valor da empresa (ROSS; WESTERFIELD; JAFFE, 2002; JENSEN; MECKLING, 1976).

De acordo com a Teoria da Agência, a estrutura ótima de capital seria aquela que alinha os interesses dos acionistas e dos gestores, de modo a garantir que os gestores ajam em benefício da empresa como um todo. Isso implica em manter um nível adequado de capital próprio para que os acionistas tenham um interesse direto no sucesso da empresa, e em utilizar a dívida de forma a equilibrar o benefício fiscal com o custo do endividamento. Além disso, a estrutura ótima de capital deve permitir aos gestores manterem um certo grau de flexibilidade financeira, para lidar com mudanças no ambiente de negócios e aproveitar oportunidades de investimento (ROSS; WESTERFIELD; JAFFE, 2002).

Gráfico 19. Estrutura Ótima de Capital de acordo com a Teoria da Agência



The Optimal Capital Structure according to Agency Theory.

Fonte: Chen; Roger, 2005

3.3.1.1. Observações sobre a adoção, pela ANS, do Capital de Risco

A estrutura de capital e o capital de risco são dois conceitos importantes no mundo dos negócios. A estrutura de capital refere-se à forma como uma empresa financia suas atividades, incluindo a proporção de dívida e capital próprio que a empresa utiliza para financiar seus investimentos. Já o capital de risco é um tipo de financiamento em que investidores fornecem capital a uma empresa em troca de uma participação acionária, com o objetivo de obter um retorno financeiro significativo no futuro (ROSS; WESTERFIELD; JAFFE, 2002; GOMPERS; LERNER, 2006).

A estrutura de capital é importante porque afeta a capacidade de uma empresa de obter financiamento e sua capacidade de gerar lucros. Empresas que utilizam uma grande quantidade de dívida em sua estrutura de capital podem ter dificuldades em obter financiamento adicional e podem enfrentar desafios em tempos de crise financeira. Por outro lado, empresas que utilizam uma grande quantidade de capital próprio podem ter mais flexibilidade financeira, no entanto, podem enfrentar desafios em termos de lucratividade.

O capital de risco é um tipo de financiamento que pode ajudar as empresas a superar esses desafios, fornecendo capital para investimentos em troca de uma participação acionária. Os investidores de capital de risco geralmente estão dispostos a assumir riscos maiores do que os investidores tradicionais, o que pode ajudar as empresas a obter financiamento quando outras fontes de financiamento não estão disponíveis (SILVA; MACHADO, 2017).

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) adotou recentemente o Capital de Risco como uma forma de incentivar a inovação e o desenvolvimento de novas tecnologias e práticas na área da saúde. Essa medida foi tomada em resposta às mudanças no mercado de saúde, que tem sido cada vez mais impactado pela tecnologia e pela necessidade de oferecer serviços de qualidade aos pacientes.

De acordo com a ANS, o Capital de Risco pode ser uma ferramenta importante para as operadoras de saúde, que podem utilizar os recursos financeiros para investir em novas tecnologias e processos que melhorem a qualidade do atendimento e reduzam os custos operacionais. Além disso, o Capital de Risco pode ajudar as operadoras a se adaptarem às mudanças regulatórias e de mercado, que exigem cada vez mais inovação e eficiência (ANS).

Segundo a ANS, o Capital de Risco é uma forma de financiamento que pode trazer benefícios tanto para as operadoras de saúde quanto para os pacientes, que terão acesso a serviços mais

modernos e eficientes. No entanto, é importante ressaltar que o Capital de Risco também envolve riscos, já que as empresas que recebem esse tipo de financiamento geralmente são startups e estão em fase inicial de desenvolvimento (ANS)

Portanto, a adoção do Capital de Risco pela ANS representa uma oportunidade para as operadoras de saúde investirem em inovação e melhorarem seus serviços, mas é necessário que esses investimentos sejam feitos de forma responsável e sustentável, levando em consideração os riscos envolvidos.

3.4. Estrutura de Capital das Empresas Brasileiras do Setor de Planos de Saúde

3.4.1. Estrutura de Capital no Contexto da Estrutura Financeira da Empresa

A análise financeira de uma empresa consiste em uma revisão detalhada dos dados financeiros, levando em consideração os acontecimentos internos e externos que a afetam financeiramente. Os indicadores financeiros são técnicas adequadas para análises comparativas entre empresas ao longo de vários períodos, sendo os mais fáceis de serem calculados e interpretados. É importante que o indivíduo saiba quais dados são necessários para sua análise e defina a quantidade e o tipo de indicadores, pois um grande volume pode confundir e uma quantidade pequena pode não ser suficiente. Os indicadores de desempenho na área da saúde surgem como resposta à necessidade de qualificar os cuidados de saúde e compartilhar informações valiosas para a tomada de decisões. Portanto, os indicadores são instrumentos que possibilitam quantificar os resultados de ações e auxiliam na mensuração dos resultados, possibilitando comparações do desempenho entre empresas e ao longo do tempo. Os índices financeiros de lucratividade, estrutura de capitais e liquidez são indispensáveis ferramentas de auxílio na análise das empresas, indicando qual retorno é feito sobre o investimento e avaliando o resultado e eficiência das empresas no uso de seus geradores de financiamentos para obter lucros a longo prazo, pagar seus credores e remunerar seus proprietários (SILVA, 2008; MARTINS, 2005; MATARAZZO, 2003; MALETTA, 2000; PADOVEZE, 2003; SANTANA; CASTRO, 2005).

Os indicadores de lucratividade, como o ROA e ROE, são importantes para analisar qualquer tipo de empresa e comparar investimentos (SALIM, 2001). Na área da saúde, surgem como resposta à necessidade de qualificar os cuidados e melhorar os serviços oferecidos aos clientes (SILVA et al., 2008). Os indicadores são instrumentos que quantificam os resultados de ações e auxiliam na avaliação de empresas (MALETTA, 2000). A análise financeira é a metodologia

mais utilizada para avaliar o desempenho empresarial, porém, é necessário utilizar índices econômicos para detalhar os aspectos do desempenho (PADOVEZE, 2003; COPELAND; KOLLER; MURRIN, apud SANTANA; CASTRO, 2005). Os índices de lucratividade são indispensáveis para avaliar o resultado e eficiência das empresas no uso de seus geradores de financiamentos para obter lucros a longo prazo, pagar seus credores e remunerar seus proprietários (SILVA, 2008).

As normas da ANS refletem nas fontes de financiamento das operadoras e influenciam sua situação patrimonial e de liquidez (BRAGA, 2017, p. 26). O Plano de Contas Padrão é uma relação detalhada de contas contábeis para registro dos fatos administrativos, sendo padronizado para as operadoras e apresentando diversas premissas e diretrizes (RN 209, 2012). São levados em conta: a margem de solvência mensura a capacidade da operadora de permanecer atuando no mercado no médio e longo prazo e as provisões técnicas, que tratam de dívidas assistenciais decorrentes da utilização de serviços médicos e hospitalares pelos beneficiários (RN 209, 2009).

A ANS edita suas normas conforme a necessidade de regulamentação, o que pode alterar significativamente as decisões dos gestores das operadoras sobre fontes de financiamento e a posição patrimonial (BRAGA, 2017, p. 27). A regulamentação da ANS estabelece diversos critérios e premissas que influenciam as decisões sobre finanças corporativas, como as regras relacionadas à margem de solvência e às reservas financeiras para quitação das dívidas assistenciais, como a RN 206 e 209, 2009 (BRAGA 2017, p. 28).

3.4.2. Estrutura de Capital da Empresa: indicadores

Os índices financeiros utilizados na análise fundamentalista para avaliar a estrutura de capital de empresas de um mesmo setor são considerados indicadores (VOGLINO, 2020). No Brasil, a taxa de crescimento real do PIB apresenta relação negativa com a alavancagem das empresas, indicando que em períodos de crescimento econômico, as organizações tendem a apresentar menor alavancagem (TERRA, apud MITSUSHIMA et. al., 2010, p. 5) O estudo de Correa, Basso e Nakamura (2013), aponta a relação negativa da alavancagem com o grau de tangibilidade dos ativos e a lucratividade, o que corrobora a *Pecking Order Theory*.

As mudanças econômicas no mercado brasileiro impactam as decisões relativas à estrutura de capital das grandes empresas (MACHADO et. al., 2015, p. 385).

No contexto da análise dos índices de estrutura de capital, a tangibilidade dos ativos é uma

variável que afeta o nível de endividamento das empresas, pois organizações com maior proporção de ativos tangíveis tendem a apresentar um endividamento maior (POHLMANN; IUDÍCIBUS, 2010). O tamanho da empresa pode influenciar o nível de endividamento, sendo sua influência positiva, uma vez que as grandes empresas tendem a ser mais diversificadas, e também a ter melhor reputação junto ao mercado credor e menores níveis de assimetria informacional (FRENCH; FAMA, 2002; FRANK; GOYAL, 2009).

A lucratividade/rentabilidade é uma variável central na avaliação das decisões de financiamento das empresas, porém, há discordâncias na interpretação de seu efeito no nível de endividamento (FAMA; FRENCH, 2005; POHLMANN; IUDÍCIBUS, 2010). O crescimento pode influenciar o nível de endividamento, pois empresas em fase de crescimento tendem a se endividar mais, enquanto empresas com elevadas taxas de crescimento podem ter alto custo de falência (FORTE et al., 2013; BRIT*O* et al., 2007). A singularidade das empresas, relacionada à especificidade dos ativos, pode torná-las mais conservadoras em relação ao endividamento, a fim de evitar o risco de falência (PEROBELLI; FAMA, 2002; BESANKO et al., 2012; AVELAR, 2019).

Pohlmann e Iudícibus (2010), afirmam que tributos elevados sobre o lucro aumentam o endividamento das empresas. Modigliani (1958) e Miller (1963), questionaram o papel do endividamento corporativo no valor das empresas, concluindo que a estrutura de capital era irrelevante na criação de valor. Posteriormente, Modigliani e Miller (1963) revisaram o trabalho anterior, concluindo que a tributação sobre o lucro incentiva o endividamento, já que a dedutibilidade dos juros reduziria a base de cálculo dos tributos e aumentaria os fluxos de caixa disponíveis. Titman e Wessels (1988), destacam que deduções como depreciação e amortização aumentam o endividamento. Gelbcke et al. (2018) conceituam a depreciação e a amortização como perda de valor de ativos, reduzindo o lucro tributável. Quanto mais altas as despesas, menor o incentivo para a empresa optar por se endividar. O risco está negativamente relacionado ao endividamento, já que as perdas esperadas pela maior probabilidade de falência são representadas por taxas de juros mais altas e os custos de falência esperados aumentam quando a empresa apresenta níveis elevados de alavancagem (FORTE et al., 2013; LEMMON; ZENDER, 2010; AVELAR, 2019).

3.4.3. Estrutura de Capital das empresas do Setor Brasileiro de Planos de Saúde

A adequação dos planos privados de assistência à saúde é realizada atendendo ao disposto na

resolução da ANS, RDC n. 77, que estabelece as garantias financeiras. O perfil de adequação econômico-financeira do BHC é analisado em fiscalizações pró-ativas realizadas pela ANS. A obrigatoriedade de fornecimento de dados, constituição de reservas técnicas e realização de auditorias contábeis fazem parte dos custos de transação das empresas que atuam na área da saúde (ARAÚJO, 2004).

Resultados da análise dos instrumentos de regulação econômica podem auxiliar não só a ANS, mas todos os atores presentes nesse mercado de saúde suplementar, a estabelecer maior efetividade na formulação de estratégias e mudanças em suas formas de relacionamento (ARAÚJO, 2004, p. 16).

Os indicadores para a análise econômico-financeira dos operadores são:

- **Cumprimento de capital mínimo ou provisão operacional:** o Capital Mínimo destina-se a representar o montante mínimo de capital que o operador deve ter para garantir suas operações além das provisões. O Capital Mínimo é obtido pela multiplicação de um fator de ponderação da variável K, obtido na tabela A do anexo I da RDC nº 77, pelo capital base de R$ 3.100.000,00 segundo o critério médico-hospitalar cobertura versus a região de atuação da operadora;
- **Constituição da Provisão de Risco:** a regulamentação das provisões técnicas visa preservar a segurança e liquidez dos operadores e corresponde a valores a contabilizar nas contas do passivo do operador para assegurar o cumprimento das obrigações financeiras para com os seus beneficiários. A provisão de risco visa garantir as obrigações contratuais, com base no conceito de apropriação e insuficiência de contraprestação. A constituição da provisão para riscos é mensal, correspondendo ao maior dos valores entre as duas hipóteses a seguir: 1) 50% das contraprestações líquidas emitidas nas modalidades de pré-pagamento; 2) média dos eventos indenizáveis líquidos conhecidos, na modalidade de pré-pagamento, nos últimos 12 meses, multiplicada pelo fator Y na tabela B do anexo I da RDC nº. 77 (ARAÚJO, 2004, p. 18-19).

Indicadores

Os indicadores de estrutura de capital permitem demonstrar o grau de dependência de uma empresa em relação a fontes externas de recursos para financiar suas operações e aumentar sua lucratividade. Além das fontes externas, as empresas também podem contar com fontes

próprias, como lucros retidos ou aporte de capital (VOGLINO, 2020). A verificação da composição da estrutura de capital de uma empresa a partir de recursos próprios e externos é de interesse de vários agentes, como a ANS, acionistas e investidores. É importante para os gestores promover a administração mais eficiente possível e alcançar uma estrutura de capital ótima. Empresas com grande participação de terceiros correm maior risco, uma vez que a remuneração deste capital e a apresentação de garantias para a liberação do crédito são exigidas (VOGLINO, 2020). A tabela abaixo apresenta a Fórmula dos Indicadores de Estrutura de Capital:

Tabela 34. Fórmula dos Indicadores de Estrutura de Capital

Índice	Endividamento Geral	Endividamento com terceiros	Composição do endividamento	Imobilização sobre recursos não recorrentes
Fórmula	EG= (PC+PNC)÷AT	ET=(PC+PNC)÷PL	CE=PC÷(PC+PNC)	ARNC=AP÷(PNC+PL)
Análise	Quanto a empresa deve em relação ao total aplicado	Quanto a empresa levou de capital de terceiros para cada real de capital próprio	Qual o percentual de dívidas a curto prazo em relação às dívidas totais	Qual o percentual de recursos não correntes a empresa aplicou no ativo permanente.
Interpretação	Quanto menor, melhor	Quanto menor, melhor	Quanto menor, melhor	Quanto menor, melhor

*Legenda: AT – Ativo Total; PL – Patrimônio Líquido; PC– Passivo Circulante; PNC – Passivo Não Circulante; AP – Ativo Permanente

Fonte: Voglino, 2020

A adequação dos planos privados de assistência à saúde é realizada por meio do atendimento ao disposto na RDC nº 77, que estabelece as garantias financeiras (ARAÚJO, 2004). A ANS realiza fiscalizações pró-ativas para analisar o perfil de adequação econômico-financeiro das OPS (ARAÚJO, 2004). A exigência de fornecimento de dados, criação de reservas técnicas e realização de auditorias contábeis são custos de transação das empresas que trabalham com a área de saúde (ARAÚJO, 2004, p. 15).

A análise dos instrumentos de regulação econômica pode auxiliar a ANS e todos os atores presentes no mercado de saúde suplementar a estabelecerem maior efetividade na formulação de estratégias e mudanças em suas formas de relacionamento (ARAÚJO, 2004, p. 16). Os indicadores para a análise econômico-financeira das operadoras incluem a observância do capital mínimo ou provisão de operação, que tem por objetivo representar o valor mínimo de

capital de que a operadora deverá dispor para garantir suas operações em complementação às provisões (ARAÚJO, 2004, p. 18).

A constituição da provisão de risco, visa preservar a segurança e liquidez das operadoras e corresponde a montantes a serem contabilizados em contas do passivo da operadora, com o objetivo de garantir que as obrigações financeiras para com os seus beneficiários sejam cumpridas (ARAÚJO, 2004, p. 19). A fonte de financiamento das operações pode contribuir de forma significativa para a obtenção do resultado esperado, e as evidências indicam que as operadoras que buscam recursos de terceiros e no curto prazo apresentam rentabilidade menor em relação às operadoras que buscam recursos próprios (KUDLAWICZ, 2013; VIANA, 2012; BRAGA, 2017)

A gestão eficiente de capital de giro é fundamental para a obtenção de um desempenho satisfatório e fortalecimento da solvência e sobrevivência da operadora de saúde (BRAGA, 2017). O investimento inicial necessário para a viabilidade econômico-financeira de uma operadora depende da sua forma de operação, sendo que uma operadora com rede própria, terá um investimento inicial mais elevado (ARAÚJO, 2004). As barreiras à entrada são maiores quanto maior for o investimento inicial, pois esses investimentos tendem a ser custos irrecuperáveis que terão importantes implicações sobre o comportamento estratégico das empresas (ARAUJO, 2004). A ANS delimita os preços a serem praticados pelas OPS, os serviços ou procedimentos oferecidos aos beneficiários e a amplitude de clínicas, hospitais e laboratórios que atendem aos beneficiários (ANS, 2016 apud BRAGANÇA, 2017). As provisões técnicas são obrigatórias e devem ser garantidas pelas entidades por meio de uma conta no ativo da entidade (RODRIGUES NETO, 2019).

A ANS estabelece um plano de recuperação para operadoras de saúde que apresentam problemas econômico-financeiros, com medidas administrativas corretivas e uma projeção de fluxo de caixa para retorno à normalidade. A agência utiliza quatro tipos de indicadores para monitorar o controle econômico-financeiro das operadoras, incluindo os indicadores de estrutura de capital, que avaliam a capacidade financeira da operadora. As operadoras devem informar periodicamente dados econômico-financeiros à ANS, incluindo índices financeiros e reajustes praticados nos planos e produtos comercializados. A ANS regula as cobranças de mensalidades, as formas de apropriação das receitas, e a liquidação dos saldos aos prestadores de serviços da rede credenciada. A complexidade do ambiente da saúde suplementar inclui um conflito de interesses na relação das operadoras com seus prestadores de serviços. As operadoras precisam gerir suas atividades e conhecer seu real desempenho para superar as

adversidades do ambiente (BRAGANÇA, 2017; LIMA; SOUZA, 2019; BRAGA, 2017; ALVES, 2008; GONÇALVES; COELHO; SOUZA, 2011; CARNEIRO JUNIOR et al., 2008).

Os indicadores utilizados para o controle econômico-financeiro das operadoras de saúde suplementar podem ser divididos em quatro tipos: liquidez, estrutura de capital, custos e rentabilidade. A liquidez avalia a capacidade da operadora em honrar seus compromissos de curto e longo prazos. A estrutura de capital monitora o grau de endividamento e o nível de imobilização da operadora. Os indicadores de custos medem a capacidade da operadora em se manter em operação a longo prazo. E o indicador de rentabilidade expressa a atratividade financeira do setor. É importante ressaltar que, a análise individualizada de cada indicador pode apresentar uma visão distorcida, sendo necessário um acompanhamento conjunto e interdependente (RODRIGUES, 2013.).

Os indicadores utilizados para avaliação da qualidade econômico-financeira são: grau de endividamento, imobilização do patrimônio líquido, liquidez corrente, liquidez geral ajustada, rentabilidade, índice de despesa assistencial, índice combinado e índice combinado ampliado. (Fonte: ANS. Monitoramento da Garantia de Atendimento, 2021).

A RN nº 67, de 4 de fevereiro de 2004, dispõe sobre a diversificação dos ativos das operadoras de planos privados de assistência à saúde para aceitação como garantidores e estabelece que recursos podem ser alocados como ativos garantidores, nos segmentos de: renda fixa, renda variável e imóveis. Na utilização para imóveis, segue a regra citada acima: 90% em rede própria e 30% em rede que não seja própria. Este disposto não se aplica à autogestão patrocinada e à seguradora (ARAÚJO, 2004, p. 65).

O endividamento, a nota de desempenho das OPS, o giro do ativo, a imobilização e a liquidez imediata, para defasagem de um ano, bem como o endividamento e a margem de lucro líquida, para dois anos de defasagem, são consideradas variáveis significativas na predição de insolvência das OPS. Destas, o endividamento constitui-se elemento constitutivo na definição da estrutura de capital.

A RN nº 206 (2009) modificou a apuração do resultado da operadora, adequando a apropriação da receita conforme a cobertura do contrato de plano de saúde. A cobertura refere-se à possibilidade de custeamento de serviços médicos e hospitalares a partir da adesão ao plano, a mesma também determinou a reversão de uma provisão técnica, que se refere a uma dívida assistencial com a rede credenciada. Ela estabeleceu os critérios para constituição da margem de solvência, que se refere à suficiência do patrimônio líquido da operadora para honrar

compromissos de médio e longo prazos. A RN 314 (2012) permitiu o aproveitamento de gastos em programas de promoção da saúde e prevenção de doenças como redutor da necessidade de constituição de margem de solvência, também exigiu o registro de uma nova dívida assistencial, que trata da provisão de prêmios ou contribuições não ganhas. Essa norma afeta o patrimônio líquido da operadora, impactando no saldo das provisões técnicas, e na necessidade de vinculação de ativos garantidores e nas formas de apropriação das receitas (BRAGA, 2017).

As normas RN's 206, 209 e 314, estabelecidas pela ANS em 2009 e 2012, trouxeram mudanças significativas para as operadoras de planos de saúde, afetando as suas decisões de financiamento e perfil de endividamento. A cobertura mensal deve ser concedida ao beneficiário sem cobrança fora do período de cobertura, o que afeta o saldo da PPCNG e as receitas assistenciais das operadoras. A ANS, como regulador do segmento da saúde suplementar, busca garantir condições seguras e fidedignas aos beneficiários, mas estabelece restrições às operadoras que podem comprometer seu desempenho e criação de valor. O Sumário Executivo de Impacto Regulatório de 2018 aponta o risco de insolvência e descontinuidade de operações de planos de saúde decorrentes de falhas de controles internos e baixa capacidade de gestão dos riscos a que estão expostas as operadoras (BRAGA, 2017; ANS, 2018).

4. METODOLOGIA

Classificação da pesquisa

De acordo com Hair et al. (2005) as pesquisas podem ser classificadas quanto aos seus objetivos gerais, podendo ser classificadas em: exploratórias, descritivas e explicativas. De acordo com essas classificações, o presente trabalho pode ser categorizado como uma pesquisa descritiva que objetiva identificar os principais fatores que determinam a ocorrência de um fenômeno. Neste caso, objetiva-se pesquisar os fatores que determinam as escolhas de financiamento de estrutura de capital em empresas OPS.

Além disso, pode-se classificar como uma pesquisa ex-post facto, visto que o presente trabalho busca delimitar o objeto de estudo e suas relações, as formas de controle e de observação que exercem sobre o objeto de pesquisa, extraído de dados secundários. Quanto a abordagem, pode-se classificar como uma pesquisa quantitativa, visto que busca utilizar métodos estatísticos para análise dos dados (HAIR et al., 2005).

4.1. Amostra, Período e Coleta de Dados

A base de dados utilizada para composição das variáveis de análise compreende dados anuais de empresas Operadoras de Planos de Saúde (OPS) extraídas da base de dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) com dados entre 2018 e 2023.

A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) estabelece regras rigorosas sobre o sigilo e a proteção de dados dos beneficiários dos planos de saúde, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), garantindo que informações sensíveis, como dados médicos e pessoais, sejam mantidas em sigilo e acessadas apenas por profissionais autorizados. No entanto, a ANS também exige que as Operadoras de Planos de Saúde (OPS) divulguem dados operacionais, como qualidade de serviços prestados, número de beneficiários, e indicadores de saúde, para possibilitar a fiscalização e o monitoramento do setor. A abertura desses dados é fundamental para assegurar a transparência, permitir a comparação entre planos de saúde, facilitar a tomada de decisões por parte dos consumidores e garantir que as OPS cumpram com os padrões estabelecidos, promovendo um sistema mais eficiente, competitivo e seguro para os usuários.

As Operadoras de Planos de Saúde (OPS) desempenham um papel fundamental no sistema de saúde do Brasil, sendo responsáveis pela gestão de milhões de beneficiários e pelo financiamento de serviços médicos, hospitalares e odontológicos em todo o país. Esse setor é altamente regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e pelo Ministério da Saúde, que impõem rigorosos requisitos para garantir a qualidade, transparência e eficiência dos serviços prestados. Além disso, as OPS devem se adaptar a mudanças constantes nas normativas, como ocorreu durante a pandemia de Covid-19, quando houve uma intensificação do monitoramento, ajustes nas coberturas e novos protocolos de atendimento, refletindo as necessidades emergenciais da população. Com um orçamento significativo destinado à saúde, representando uma fatia considerável da renda nacional (cerca de 9% do PIB, com os brasileiros destinando uma parte substancial de sua renda a planos de saúde e tratamentos médicos), o setor de OPS se configura como um campo estratégico, não apenas pela sua relevância econômica, mas também pelo impacto direto que tem na qualidade de vida da população.

Nesse sentido, utilizaram-se como população as empresas Operadoras de Planos de Saúde (OPS) analisados compreendidas nos períodos de 2018 até 2023. O total de empresas que estão

na base da ANS são de 1.292, desse total foram feitos alguns recortes para da população chegando à amostra final de 200.

As regras para recortes da amostra da população de empresas acompanhadas pela ANS estão na tabela a seguir:

Tabela 35. Recorte da amostra da pesquisa

Empresas	Filtros	Justificativas
1.292	Total de OPS cadastradas na ANS	Não há recortes
722	Empresa com Ativos abaixo de 1 milhão.	São empresas que possuem maior rigor de apresentação de dados financeiros
54	Empresas com Patrimônio Líquido negativos	Essas empresas não possuem indicadores mensuráveis para análise do problema de pesquisa
200	Total líquido após filtros que compõem a amostra final das OPS acompanhadas pela ANS	Corresponde a amostra final da pesquisa

Fonte: Elaborada pela autora, 2024

Para tratamento dos *outliers* da base de dados, conforme Castro Junior e Yoshinaga (2012) sugerem, foi utilizada a técnica de "winsorização" onde os dados são ordenados de forma crescente, separando os dados localizados no primeiro e último percentil, sendo estas observações alterados pelo valor mais próximo dentro do intervalo de 1% e 99%. O objetivo dessa técnica é diminuir a influência de valores extremos, porém sem descartar nenhuma observação, tornando os *outliers* menos relevantes para que os dados apresentem um comportamento mais próximo de uma curva norma (BARNETT; LEWIS, 1994).

4.2. Seleção das Variáveis da amostra da pesquisa

Todas as variáveis da amostra tanto dependentes quanto independentes foram coletadas com base nos autores seminais na teoria de estrutura de capital, por exemplo, Rajan e Zingales (1995), Welch (2011), Keefe e Yaghoubi (2016), Frank e Goyal (2009; 2022) e Frank e Goyal (2020). Além disso, foram utilizados variáveis de interesse do setor das OPS com o intuito de inovar as pesquisas sobre estrutura de capital, conforme Frank e Goyal (2022) essa busca tem sido um quebra-cabeças desafiador, mas fundamental para as finanças, visto que as imperfeições informacionais desempenham um papel nas decisões de estrutura de capital, assim como, as peculiaridades do setor da empresas OPS, por isso, conclui o autor nenhuma teoria unificada explica adequadamente todos os fatores explícitos e implícitos.

Variáveis Dependentes

Conforme problema de pesquisa a proxy para estrutura de capital é a alavancagem da empresa essa mesma vem sendo capturada de diferentes formas pelas pesquisas de estrutura de capital e conforme a pesquisa de Welch (2011) a escolha da melhor proxy vai além de se buscar em autores anteriores, mas deve-se entender o problema de pesquisa a fim de se obter a melhor proxy para o modelo a ser estudado.

Foram considerados três proxies com base na literatura e que melhor explicam o problema de pesquisa: Lev1: Dívida Líquida sobre o Ativo total menos caixas que equivale ao endividamento total menos caixa; Lev2: Dívida Total sobre Ativo Total e Lev3: Passivo não circulante sobre Ativo Total, conforme tabela a seguir:

Tabela 36. Variáveis Dependentes: Alavancagem (Lev)

Variável	Sigla	Fórmula	Autores
Alavancagem	Lev1	[Dívida total - (Caixas e Equivalentes + Aplicações Financeiras de curto prazo)] / Ativo Total - (Caixas e equivalentes + aplicações financeiras de curto prazo)	Rajan e Zingales (1995); Frank e Goyal (2009); Welch (2011) e Keefe e Yaghoubi (2016)
Alavancagem	Lev2	Dívida Total / Ativo Total	Rajan e Zingales (1995); Frank e Goyal (2009); Welch (2011) e Keefe e Yaghoubi (2016)
Alavancagem	Lev3	Passivo não Circulante / Ativo Total	Welch (2011); Keefe e Yaghoubi (2016)

Fonte: Elaborada pela autora, 2024

Variáveis Independentes de Interesse

As principais variáveis de interesse são: Sinistralidade, Reserva Técnica, Vidas Saúde e Vidas Odonto. Estas são variáveis específicas do setor das OPS, em todos os casos a ANS acompanha de perto esses indicadores e divulga trimestralmente os indicadores do setor e por empresa, devendo as empresas reportarem as informações de forma fidedigna à ANS. Essas variáveis são consideradas em termos de **valores relativos**, o que permite análises mais consistentes e comparáveis entre empresas de diferentes tamanhos. A **sinistralidade**, por exemplo, é calculada como a proporção entre as despesas assistenciais e as receitas operacionais da operadora, expressando o percentual dos recursos alocados ao pagamento de serviços de saúde. Da mesma forma, a **Reserva Técnica** reflete obrigações esperadas em relação ao ativo total da empresa, enquanto o **Retorno Operacional (ROA)** é medido como o lucro antes de juros e impostos (EBIT) dividido pelo ativo total. Já as variáveis **Vidas Saúde** e **Vidas Odonto** são tratadas como dummies que indicam a presença ou ausência de receitas provenientes desses tipos de planos. Essa abordagem relativa facilita a interpretação e possibilita uma avaliação mais precisa das estratégias financeiras das OPS dentro de um setor altamente regulado e competitivo.

A **sinistralidade** é uma variável de interesse complexa no estudo das Operadoras de Planos de

Saúde (OPS) e pode apresentar tanto sinais positivos quanto negativos em relação à alavancagem, dependendo do referencial teórico e das condições específicas do setor. Isso ocorre porque a **sinistralidade**, que representa o percentual das receitas operacionais utilizado para cobrir despesas assistenciais, possui características que podem influenciar a estrutura de capital de maneiras contraditórias.

Justificativa para Sinal Positivo

Sob a perspectiva da teoria de *trade-off*, a sinistralidade elevada pode forçar as empresas a recorrer ao endividamento para equilibrar a pressão financeira causada por altos custos operacionais. Neste caso, o crédito é utilizado para sustentar operações e evitar perdas de mercado. Isso é comum em cenários de alta competição ou quando a regulação limita a possibilidade de reajustar preços ou reduzir coberturas, como é frequentemente observado no setor regulado pela ANS.

Justificativa para Sinal Negativo

Por outro lado, segundo a teoria de *pecking order*, um aumento na sinistralidade pode ser percebido como um fator de risco que reduz a capacidade da empresa de acessar crédito em condições favoráveis. As OPS podem priorizar a utilização de recursos internos ou reduzir investimentos para evitar custos adicionais de endividamento. Além disso, credores podem exigir maior garantia ou taxas de juros mais elevadas, dificultando o acesso ao crédito.

Implicações Metodológicas

Como discutido, o impacto da sinistralidade é influenciado por fatores sistêmicos e operacionais que podem variar entre empresas e momentos econômicos. A análise econométrica buscou considerar essa ambiguidade teórica e os modelos com dados em painel ajudam a capturar essas variações.

Seguindo Frank e Goyal (2022) e Welch (2011) o quebra-cabeça das variáveis que explicam as decisões de estrutura de capital das empresas pode possuir particularidades de setor, específicos as empresas, e no caso desta pesquisa, exclusivos ao setor das OPS no Brasil.

Nesse sentido proxy de Sinistralidade (índice de despesas assistenciais ou despesas médicas) equivale a equação: Mostra a relação entre despesas assistenciais e o total das receitas com operação de planos de saúde da operadora. De forma geral, representa o percentual das receitas assistenciais (advindas das mensalidades) que são utilizadas com o pagamento de despesas assistenciais.; a Reserva de Técnica (As provisões técnicas devem refletir todas as obrigações

esperadas das operadoras com a operação de plano de saúde, conforme a normativa vigente) equivale a equação: A necessidade de contabilizar reservas técnicas e de manter ativos garantidores junto à ANS estão entre as principais regras prudenciais vigentes para o setor de saúde suplementar (RN n° 521/22 e RN n° 574/23); Vidas Saúde (Beneficiários em planos privados de assistência médica) equivale a *dummy* que assume valor 1 quando a empresa possui receitas em vidas saúde e zero para as demais empresas e Vidas Odonto (Beneficiários em planos privados exclusivamente odontológicos) equivale a *dummy* que assume valor 1 quando a empresa possui receitas em vidas odonto e zero para as demais empresas, as variáveis de interesse encontram-se consolidadas na tabela a seguir:

Tabela 37. Variáveis Independentes de Interesse e Controle

Nome	**Sinal esperado**	**Fórmula**	**Referências**
Sinistralidade	+/-	Relação entre despesas assistenciais e o total das receitas com operação de planos de saúde da operadora	ANS (2024)
Reserva Técnica	+/-	Reflete todas as obrigações esperadas das operadoras com a operação de plano de saúde, conforme a normativa vigente.	ANS (2024)
Vidas Saúde	+	Assume 1 se empresa com receitas de vidas saúde e zero para demais	ANS (2024)
Vidas Odonto	+	Assume 1 se empresa com receitas de vidas odonto e zero para demais	ANS (2024)
Tangibilidade	+	Ativo Fixo/Ativo Total	Rajan e Zingales (1995); Frank e Goyal (2009)
ROA	+/-	Ebit/[4]Ativo Total	Rajan e Zingales (1995); Frank e Goyal (2009)

Fonte: Elaborada pela autora, 2024

[4] O **EBIT** (Earnings Before Interest and Taxes) é um indicador financeiro que mede o lucro operacional de uma empresa antes do pagamento de juros e impostos. Ele reflete a capacidade da empresa de gerar lucro exclusivamente com suas operações principais, sem considerar custos financeiros ou carga tributária, sendo uma métrica útil para avaliar a eficiência operacional.

Variáveis Independentes de Controle

Para responder o problema de pesquisa, foram adotados os fatores que Frank e Goyal (2009; 2022), Welch (2011) consideram mais confiáveis para explicar a alavancagem como variáveis de controle e que ajudam a explicar os modelos propostos para o problema de pesquisa são estas: Tangibilidade e ROA.

A Tangibilidade equivale aos Ativos fixos sobre Ativo total, enquanto ROA equivale ao resultado operacional: *earnings before interest and taxes* (ebit) sobre os ativos totais. Todas as informações dessas variáveis de controle estão levando em consideração as métricas e equações acompanhadas e divulgadas pela base de dados da ANS, conforme tabela anterior.

4.3. Modelos Econométricos

O modelo econométrico utilizado foi análises de regressão com dados em painel, que apresenta como vantagem mensurar o estudo das diferenças existentes em determinado fenômeno, estrutura de capital ($Lev_{i,t}$) entre indivíduos em cada *cross-section*, empresas do setor OPS (i), além de permitir a análise da evolução temporal (t) deste mesmo fenômeno para cada indivíduo.

Para Fávero e Belfiore (2017), os modelos longitudinais de regressão proveem maior quantidade de informações, maior variabilidade dos dados, menor multicolinearidade entre as variáveis, maior número de graus de liberdade e maior eficiência para estimação dos parâmetros.

Conforme a proposto para este estudo, os modelos a seguir definem as equações para responder o problema de pesquisa para testar a variável de Alavancagem (Lev).

Foram propostos seis modelos para responder o problema de pesquisa conforme apresentado:

Modelo 1 (Lev1):

$$Lev1_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 \times Sinistralidade_{i,t} + \beta_2 \times Reserva\ Técnica_{i,t} + \beta_3 \times Tangilidade_{i,t} + \beta_4 \times ROA_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

Modelo 2 (Lev1):

Equivale a extensão do modelo 1 em que se inclui as variáveis *dummies* Vida Saúde e Vida Odonto.

$$Lev1_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 Sinistralidade_{i,t} + \beta_2 Reserva\ Técnica_{i,t} + \beta_3 Vida\ Saúde_{i,t} + \beta_4 Vida\ Odonto_{i,t} + \beta_5 Tangilidade_{i,t} + \beta_6 ROA_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

Modelo 3 (Lev2):

$$Lev2_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 \times Sinistralidade_{i,t} + \beta_2 \times Reserva\ Técnica_{i,t} + \beta_3 \times Tangilidade_{i,t} + \beta_4 \times ROA_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

Modelo 4 (Lev2):

Equivale a extensão do modelo 3 em que se inclui as variáveis *dummies* Vida Saúde e Vida Odonto.

$$Lev2_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 Sinistralidade_{i,t} + \beta_2 Reserva\ Técnica_{i,t} + \beta_3 Vida\ Saúde_{i,t} + \beta_4 Vida\ Odonto_{i,t} + \beta_5 Tangilidade_{i,t} + \beta_6 ROA_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

Modelo 5 (Lev3)

$$Lev3_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 \times Sinistralidade_{i,t} + \beta_2 \times Reserva\ Técnica_{i,t} + \beta_3 \times Tangilidade_{i,t} + \beta_4 \times ROA_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

Modelo 6 (Lev3):

Equivale a extensão do modelo 5 em que se inclui as variáveis *dummies* Vida Saúde e Vida Odonto.

$$Lev3_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 Sinistralidade_{i,t} + \beta_2 Reserva\ Técnica_{i,t} + \beta_3 Vida\ Saúde_{i,t} + \beta_4 Vida\ Odonto_{i,t} + \beta_5 Tangilidade_{i,t} + \beta_6 ROA_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

Para todos os modelos de 1 a 6 as representações das variáveis quanto aos seus significados nos respectivos modelos são: Lev representa a variável dependente que varia entre indivíduos (empresa) e ao longo do tempo, β_0 que representa o intercepto para cada indivíduo e pode assumir efeitos fixos (FE) ou efeitos aleatórios (RE), β_j (***j*** = 1, 2, 3, 4, 5 e 6) são os coeficientes de cada variável explicativas, segundo cada modelo proposto, que também variam entre indivíduos e ao longo do tempo, e ε que representa os termos de erro idiossincráticos. Os subscritos ***i*** representam cada um dos indivíduos da análise (***i***=1, 2, 3, 4, ...n, em que n é a quantidade de indivíduos na amostra, que pode variar para cada variável no modelo, visto que o painel é desbalanceado e os subscritos ***t*** representam os períodos em que foram coletados os dados (***t*** = 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023).

Conforme discutido por Britto, Serrano e Franco (2018), o critério utilizado pelas empresas para compor sua estrutura de capital é um tema polêmico na área de finanças corporativas. O substancial corpo de pesquisas produzido sobre o tema "estrutura de capital" ainda não produziu um volume de resultados suficiente para determinar com precisão os procedimentos de escolha, bem como a forma como se dará o financiamento de seus investimentos (capital próprio ou dívida). Para identificar os indicadores utilizados pelas OPS para se financiarem, busca-se propor uma análise/diagnóstico que inclua os seguintes fatores para determinar sua estrutura de capital: Rentabilidade; Risco; Tamanho; Composição de Ativos; Crescimento; Tipo de Capital.

Para tanto, utiliza-se as teorias de *pecking order*, *trade-off* e teoria da agência. Os pressupostos teóricos serão testados em ambiente empírico com o objetivo de verificar o poder preditivo das teorias supracitadas para a compreensão das variáveis que influenciam as decisões de financiamento das OPS. Tendo em conta as considerações de Shadish, Cook e Campbell (2002) sobre a variabilidade dos potenciais agentes causadores de um determinado efeito, em que se considera que as experiências requerem: 1. variação de tratamento; 2. medidas de resultados pós-tratamento e 3. mecanismos de inferência sobre qual seria o resultado sem o tratamento. Considerando como essas premissas se aplicariam ao campo da pesquisa acadêmica em finanças, será considerado e comparado o uso de duas teorias na interpretação dos resultados da análise da estrutura de capital das OPS: teoria de *pecking order* e teoria de *trade-off*.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 Estatística Descritiva

Tabela 38. Estatística Descritiva

Variáveis	N	média	p25	p50	p75	mín	Máx	d.p
Lev1	1.145	-1,64	-1,42	-0,68	-0,31	-29,58	0,16	3,75
Lev2	1.145	0,04	0,00	0,00	0,05	0,00	0,36	0,08
Lev3	1.138	0,16	0,07	0,14	0,23	0,00	0,60	0,13
Sinistralidade	1.143	0,75	0,70	0,77	0,83	0,00	1,21	0,17
Reserva Técnica	1.130	0,25	0,16	0,23	0,32	0,04	0,74	0,13
ROA	1.145	0,05	-0,01	0,05	0,11	-0,37	0,51	0,14
Tangibilidade	1.109	0,17	0,03	0,12	0,29	0,00	0,64	0,17

Fonte: Elaborada pela autora, 2024

As empresas do setor de OPS são monitoradas pela ANS e precisam reportar os dados para acompanhamento e transparência das empresas, em parte, um dos objetivos é analisar a capacidade das empresas em atender os seus clientes mantendo sua capacidade operacional alinhado com a demanda. Nesse sentido as empresas não podem, necessariamente, se alavancar como as empresas dos outros setores, com isso, a alavancagem deve se manter em patamares seguros, assim como pode ser visto na tabela acima (estatística descritiva) para variáveis Lev1, Lev2 e Lev3 dão indicações.

As empresas do setor OPS devem apresentar alguns indicadores, *covenants* econômicos financeiros tanto para a ANS quanto para o mercado, em ambos, as empresas buscam manter maior caixa possível e manter as reservas técnicas o mais saudáveis possíveis.

As duas variáveis apresentam garantias, quanto maior as reservas técnicas maiores serão as receitas financeiras oriundas dessas reservas, visto que costumam ter aplicações com liquidez diárias a cima de 120% do CDI (taxa de juros dos empréstimos interbancários que é utilizado para remunerar diversos ativos financeiros), em períodos de altas taxas Selic as empresas do setor OPS costumam ter altas receitas financeiras advindas das reservas técnicas.

Em resumo a somatória das receitas financeiras das reservas técnicas mais o caixa da empresa

mantém os *covenants* do setor OPS saudáveis. Tais indicadores podem ser observados na variável dependente Lev2 em que o percentil 25 (p25) e a mediana (p50) apresentam valores próximos de zero. Outra indicação desse acompanhamento do setor pode ser observada na variável dependente Lev1 que apresenta valores negativos, visto que em media as empresas apresentam mais caixa do que endividamento.

A variável sinistralidade apresenta despesas assistenciais em relação as receitas totais, o percentil 75 (p75) apresentou para essa amostra no período entre 2018 e 2023 o peso de 83% das receitas totais com operação de planos de saúde. Observa-se que tanto a média quanto a mediana apresentam valores acima de 50%, respectivamente, 75% e 77%. Essa informação, no período do Covid-19, pôde demonstrar que os riscos de negócio do setor das OPS podem se distanciar da lógica da Teoria de Trade-off, visto que os riscos de sinistralidades têm uma lógica diferente conectados a riscos sistêmicos que estão fora do controlo do modelo de negócio das OPS.

A reserva técnica é a principal proxy de acompanhamento de risco da empresa, esta variável deve dar garantias de que as OPS irão suportar os riscos sistêmicos, independente do cenário de estresse. Logo em linha com essa proxy pode-se observar que o valor máximo apresentado na tabela 38 foi de 74% dos ativos das OPS contidos na amostra. Essa característica do setor das OPS indica o quão desafiados é manter uma OPS funcional, e certamente, os riscos sistêmicos comprometem a continuidade dos serviços prestados pelas empresas do setor. Isso, justifica muito o acompanhamento de perto da ANS nos indicadores de *covenants* da ANS para o setor.

A variável tangibilidade apresenta valor máximo de 64% do ativo total ao mesmo tempo que apresenta valor mínimo zero e percentil 25 (p25) de 17% do ativo total. Certamente, a tangibilidade é importante para explicar o endividamento das empresas, principalmente, as dívidas de mais longo prazo em que os credores exigem mais garantias e consequentemente as empresas com maior tangibilidade conseguem maiores endividamentos, por isso, algumas empresas apresentam os 64% do ativo total, assim como a tabela 38 indica para valor máximo da amostra, enquanto que o valor mínimo apresentado na amostra referem-se as empresas que têm menor necessidade de ativos tangíveis nos seus modelos de negócios.

As empresas do setor OPS são muito resilientes e conseguem lhe dar com consequências exógenas como o Covid-19, tanto que o ROA apresentou na tabela acima 51% demonstrando que existem empresas que podem apresentar bons resultados, em média. Logicamente, que não

representa, necessariamente, caixa, mas é uma boa proxy para geração de caixa que foi capturado na amostra da pesquisa. Certamente existem empresas que são altamente especializadas nesse complexo e importante setor. Ao mesmo tempo, pode-se, também, observar que o ROA mínimo e percentil 25 (p25) apresentaram valores negativos, demonstrando que os desafios do setor podem gerar consequências muito duras para o setor, e inclusive, pode ser, um dos indicadores para o aumento dos pedidos de recuperação judicial em períodos de crise sanitária como o Covid-19.

5.2 Análise da Matriz de Correlação

A matriz de correlação indica que quanto maior os ativos fixos e tangíveis maiores são as capacidades das empresas se endividarem.

Tabela 39. Matriz de correlação de Pearson

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1)	Lev 1	1						
(2)	Lev 2	0,21***	1					
(3)	Lev 3	0,29***	0,48***	1				
(4)	Sinistralidade	-0,23***	-0,15***	0,02**	1			
(5)	Reserva Técnica	0,00***	-0,2***	-0,13***	0,27***	1		
(6)	ROA	0,03***	-0,06**	-0,2***	-0,49***	-0,21***	1	
(7)	Tangibilidade	0,29***	0,48***	0,31***	-0,14***	-0,35***	-0,06**	1

Fonte: Elaborada pela autora, 2024

A variável Sinistralidade apresentou correlação negativa com Lev1 e Lev2, ou seja, quanto maior a Sinistralidade menor a capacidade de alavancagem das empresas (Lev1 e Lev2). Porém a Sinistralidade apresentou correlação positiva com Lev3, isso indicou que as informações de passivos operacionais somados a variável (Lev3) apresentam relação positiva com a alavancagem (Lev3), portanto quanto maior a Sinistralidade maiores serão os gastos com fornecedores, provisões trabalhistas e outros passivos operacionais.

A Reserva Técnica não apresentou significância com Lev1, mas apresentou correlação negativa

e significante com Lev2 e Lev3 mostrando que quanto maior es Reservas Técnicas menores são as necessidades de Alavancagem.

Quanto às variáveis de controle ROA apresentou correlação negativa e significante com a alavancagem (Lev2 e Lev3), indicando que, estrategicamente, quanto maior a capacidade de resultado operacional menor o uso de alavancagem. Essa correlação está em linha com os *covenants* da ANS que estimulam menores alavancagens. Já Tangibilidade apresenta relação positiva e significante com todas as proxies de alavancagem (Lev1, Lev2 e Lev3), indicando que quanto maior os ativos fixos e tangíveis maiores são as capacidades das empresas se endividarem.

5.3. Análise dos Modelos Econométricos

Tabela 40. Modelo Econométrico com dados em Painel

	Painel A		**Painel B**		**Painel C**	
	Mod1	**Mod2**	**Mod3**	**Mod4**	**Mod5**	**Mod6**
Variáveis	Lev 1	Lev 1	Lev 2	Lev 2	Lev 3	Lev 3
Interesse:						
Sinistralidade	2,31*** (0,592)	1,16* (0,593)	0,007 (0,014)	0,007 (0,015)	0,04* (0,021)	0,016* (0,456)
Reserva Técnica	2,829*** (0,842)	2,82*** (0,816)	-0,018 (0,019)	-0,018 (0,019)	-0,09** (0,03)	-0,094** (0,031)
Vidas Odonto		-10,29*** (1,321)		0,007 (0,027)		-0,21*** (0,05)
Vidas Saúde		0,53 (0,510)		0,008 (0,007)		0,011 (0,575)
Controle:						
Tangibilidade	2,248* (0,849)	2,38** (0,826)	0,24*** (0,017)	0,24*** (0,017)	0,29*** (0,03)	0,29*** (0,031)
ROA	-2,151*** (0,527)	-1,25** (0,524)	-0,05*** (0,014)	-0,05*** (0,013)	-0,130*** (0,019)	-0,12*** (0,019)
Constante	-0,84* (0,499)	8,23* (1,281)	0,013 (0,012)	0,009 (0,027)	0,17*** (0,018)	0,35*** (0,049)
R2	11,65%	10,87%	27,21%	11,65%	16,54%	18,14%
F de Chow	0,00***	0,00***	0,00***	0,00***	0,00***	0,00***
LM de Breusch-Pagan	0,00***	0,00***	0,00***	0,00***	0,00***	0,00***
Teste de Hausman	0,00***	0,00***	0,18	0,37	0,00***	0,00***
Nº Obs	1.095	1.095	1.095	1.095	1.093	1.093
Nº de Empresas	191	191	191	191	191	191

Fonte: Elaborada pela autora, 2024
Nota: *; ** e *** denotam significância aos níveis de 10%; 5% e 1%, respectivamente. Os valores entre parênteses referem-se ao erro padrão.

Os painéis A e C referem-se aos modelos de dados com efeito fixo e o Painel B refere-se ao modelo com efeito aleatório. O teste de Hausman indicou que os modelos A e C devem ser com efeitos fixos, enquanto o que o modelo B indicou análise de dados com efeito aleatório.

Conforme tabela 40, o painel A apresentou os resultados para dados em painel com efeitos fixo, os modelos 1 e 2, capturaram que sinistralidade e reservas técnicas são significativas e diretamente proporcional a alavancagem. Nesse sentido quanto maior a sinistralidade maior a alavancagem, da mesma forma quanto maior as reservas técnicas maior a alavancagem.

O modelo 2 incluiu no na análise duas variáveis, uma *dummy* para indicar se as empresas têm modelos de negócios com vidas odonto e vidas saúde. Com isso, o modelo apresentou

significância para variável vidas odonto com sinal positivo indicando que esse modelo de negócio permite que as empresas aumentem sua alavancagem.

Assim como o painel A o painel C também apresentou o modelo para dados em painel com efeitos fixo. A proxy para alavancagem incluiu tanto os passivos financeiros quanto operacionais no numerador dividido pelo ativo total. Os resultados foram que a sinistralidade apresentou relação significante e positiva, esses resultados reforçam que as sinistralidades são financiadas por endividamentos, logo quanto maior a sinistralidade maior os endividamento.

Nas análises das reservas técnicas a relação foi significante, mas houve mudança no sinal para negativa indicando que na presença e passivos operacionais a relação entre endividamentos e reservas técnicas são inversamente proporcionais. Essas informações capturadas pelo painel C nas relações entre reservas técnicas e endividamento, indicam que o aumento dos passivos operacionais com conta fornecedores, salários aumentam os riscos das empresas do setor OPS afetando negativamente a relação com a alavancagem das empresas.

O Painel B não apresentou significâncias para as variáveis de interesses, porém apresentou significância para as variáveis de controle utilizados nos modelos, em que tangibilidade apresentou relação positiva e significativa com os endividamentos das empresas e roa apresentou relação negativa e significativa.

Quanto as variáveis de controle, para tangibilidade os resultados não se alteram para os seis modelos analisados indicando maior proximidade com a teoria de *trade-off*, indicando que as empresas aumentam seus endividamentos até o ponto em que os benefícios fiscais das dívidas superam os custos de falência Damodaram (2004). Enquanto a variável roa apresentou relação negativa se aproximando da teoria de *pecking order*, Correa, Basso, Nakamura (2013) indicam que as empresas do setor de OPS utilizam primeiros os recursos próprios como preferências para se financiar, essa relação se explica devido as assimetrias informacionais (MYERS; MAJLUF, 1984). Além disso, a ANS e os diferentes credores do setor aumentam o monitoramento às empresas a fim de mitigarem os custos de agências de um setor tão sensível a riscos sistêmicos Araujo (2004)

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

6.1. Síntese dos Principais Achados

O estudo buscou investigar os determinantes da estrutura de capital das Operadoras de Planos

de Saúde (OPS) no Brasil, com ênfase em como variáveis específicas do setor influenciam os níveis de endividamento.

Os resultados mostraram que a **sinistralidade** possui uma relação positiva e significativa com o nível de endividamento. Esse achado indica que, à medida que aumentam as despesas assistenciais em relação às receitas, as operadoras tendem a recorrer ao endividamento como forma de sustentar suas operações e mitigar pressões financeiras. A análise também evidenciou o papel da **reserva técnica**, variável que apresentou um comportamento dual. Em cenários com passivos financeiros, verificou-se uma relação positiva com o endividamento, sugerindo que reservas robustas contribuem para a confiança dos credores. No entanto, em contextos de passivos operacionais, a relação se tornou negativa, refletindo os riscos sistêmicos e a necessidade de liquidez diante das incertezas operacionais.

A pesquisa destacou ainda a **tangibilidade dos ativos** como um fator determinante para a alavancagem, especialmente no caso de dívidas de longo prazo. Empresas com maior tangibilidade demonstraram uma capacidade superior de atrair crédito, utilizando seus ativos como garantia, o que confirma os pressupostos da teoria de *trade-off*. Por outro lado, a análise do **Retorno sobre Ativos (ROA)** revelou uma relação negativa e significativa com o endividamento. Esse comportamento está alinhado à teoria de *pecking order*, segundo a qual empresas mais lucrativas priorizam o uso de recursos internos, minimizando a necessidade de financiamento externo.

Outro resultado relevante foi observado ao comparar diferentes modelos de negócios. Empresas que têm modelos de negócios com **planos odontológicos** apresentaram maiores níveis de endividamento em comparação às demais, pois o negócio vidas odonto tendem a ser mais rentáveis, em função da boa margem operacional destas empresas, que tendem a apresentar menor nível de sinistralidade e maior geração de caixa, aumentando a capacidade de assumir dívidas com segurança.

Em síntese, os achados demonstram que as operadoras de saúde no Brasil adotam estratégias de endividamento influenciadas por fatores setoriais, regulatórios e operacionais específicos. O estudo revelou a coexistência de elementos das teorias de *trade-off* e *pecking order*, com variações dependendo das condições financeiras e das características dos modelos de negócio das OPS.

6.2. Discussão Crítica dos Resultados

Os resultados apresentados nesta pesquisa oferecem uma leitura detalhada e crítica sobre a estrutura de capital das Operadoras de Planos de Saúde (OPS) no Brasil, situando-se em um contexto de regulação rigorosa e de características financeiras singulares do setor. Um dos principais achados foi a **relação positiva entre sinistralidade e endividamento**, que evidência como as despesas assistenciais, ao pressionarem a margem operacional, forçam as OPS a recorrer ao crédito como forma de sustentar suas operações. Esse comportamento reflete um desafio estrutural do setor: a necessidade de equilibrar a oferta de serviços de qualidade com a saúde financeira em um cenário de margens reduzidas e custos crescentes.

Esse resultado é especialmente relevante quando interpretado à luz do papel da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A regulação impõe exigências financeiras, como a constituição de reservas técnicas e limites prudenciais de endividamento, que servem para proteger os beneficiários e garantir a continuidade dos serviços. No entanto, como demonstrado, a **relação inversa entre reservas técnicas e endividamento em passivos operacionais** sugere que, embora tais reservas funcionem como garantias de estabilidade, sua manutenção pode aumentar a rigidez financeira das OPS em momentos de maior pressão econômica. Quanto maior a necessidade de reservas técnicas, maior o nível de caixa restrito, limitando a capacidade de repagamento de dívidas.

Outro ponto crítico observado foi a influência da **tangibilidade dos ativos** sobre o endividamento, que se mostrou positiva e significativa, especialmente em dívidas de longo prazo. Esse resultado confirma os pressupostos da **teoria de *trade-off***, segundo a qual empresas utilizam ativos tangíveis como garantia para atrair crédito, equilibrando os benefícios fiscais da dívida com os custos de falência. No entanto, essa dependência dos ativos físicos pode representar uma limitação para OPS menores ou com modelos de negócio baseados em serviços, como no caso das operadoras de planos odontológicos, que possuem menor necessidade de ativos tangíveis.

Adicionalmente, a **relação negativa entre o ROA e a alavancagem** corrobora a **teoria de *pecking order***, indicando que empresas com maior capacidade de gerar resultados operacionais tendem a priorizar recursos internos em detrimento do crédito. Esse comportamento, embora estratégico, reforça a importância de práticas eficientes de gestão financeira e de geração de caixa no setor. Vale destacar que o desempenho operacional das OPS é constantemente monitorado pela ANS, o que, por um lado, promove maior transparência, mas, por outro,

aumenta as pressões para resultados positivos em um mercado altamente competitivo e regulamentado.

Por fim, a análise do impacto dos modelos de negócio revelou que operadoras focadas em planos odontológicos apresentam níveis mais elevados de alavancagem em comparação às que operam planos médicos. Essa diferença pode ser explicada pela menor sinistralidade e pelas margens operacionais mais robustas do segmento odontológico, o que confere maior segurança ao crédito. Esse achado é particularmente interessante, pois sugere que as operadoras de menor risco têm maior capacidade de acessar financiamento externo, reforçando a importância da avaliação do perfil de risco e do modelo de negócio na determinação da estrutura de capital.

Em síntese, os resultados desta pesquisa refletem a complexa relação entre variáveis financeiras, operacionais e regulatórias no setor de saúde suplementar. A coexistência das teorias de *trade-off* e *pecking order* demonstra que as decisões de endividamento das OPS são influenciadas tanto pela busca de benefícios fiscais quanto pela necessidade de gerenciar riscos e custos de agência. O papel da regulação, embora fundamental para garantir a solvência do setor, também impõe desafios adicionais, especialmente para empresas menores ou em situações de estresse financeiro.

6.3. Contribuições da Pesquisa

Esta pesquisa oferece uma contribuição significativa para a compreensão da **estrutura de capital** das Operadoras de Planos de Saúde (OPS) no Brasil, abordando um setor que apresenta características únicas e enfrenta desafios financeiros e regulatórios. Primeiramente, o estudo amplia as evidências empíricas sobre os fatores que determinam os níveis de alavancagem das OPS, considerando variáveis setoriais específicas, como **sinistralidade, reserva técnica, tangibilidade e desempenho operacional (ROA)**. Ao adotar as teorias de *trade-off* e *pecking order* como referências teóricas, a pesquisa demonstra como esses pressupostos se materializam de forma particular no contexto regulado e de alto risco do setor de saúde suplementar.

Uma contribuição essencial do trabalho é a **análise crítica do impacto da regulação da ANS** na estrutura de capital das OPS. As exigências de reservas técnicas e de governança impostas pela ANS, embora fundamentais para garantir a solvência e a continuidade dos serviços, acabam moldando as decisões de financiamento dessas empresas. O estudo evidencia como a regulação pode criar ***trade-off*** importantes, ao mesmo tempo que oferece estabilidade

financeira para os beneficiários e impõe restrições que desafiam a flexibilidade das operadoras diante de cenários adversos.

Além disso, a pesquisa destaca a **dualidade dos modelos de negócio no setor**. Enquanto as operadoras de planos médicos enfrentam maior pressão em função da alta sinistralidade e das exigências de liquidez, as OPS focadas em planos odontológicos exibem níveis de endividamento mais elevados, beneficiando-se de margens operacionais mais favoráveis e menor risco assistencial. Essa diferenciação contribui para o entendimento das **estratégias financeiras e dos riscos específicos** enfrentados por diferentes tipos de operadoras.

Do ponto de vista teórico, o trabalho enriquece o debate sobre as **teorias de estrutura de capital**, fornecendo evidências empíricas que confirmam a coexistência das abordagens de *trade-off* e *pecking order*. A influência positiva da tangibilidade dos ativos sobre o endividamento confirma os pressupostos de *trade-off*, enquanto a relação negativa entre o ROA e a alavancagem reflete o comportamento previsto pela *pecking order*. Esse achado é particularmente relevante, pois mostra que as OPS adotam estratégias de financiamento mistas, ajustadas às suas realidades financeiras e operacionais.

Por fim, a pesquisa oferece **insights valiosos para gestores, reguladores e investidores**. Para os gestores das OPS, os resultados fornecem subsídios para otimizar a estrutura de capital, equilibrando as demandas regulatórias com a busca por eficiência financeira. Para a ANS, o estudo pode servir como base para o aprimoramento das normas que buscam garantir a solvência sem comprometer a competitividade das operadoras. Já para investidores e acionistas, a análise ajuda a identificar os fatores críticos que influenciam o risco e a rentabilidade das OPS, orientando decisões estratégicas no mercado de saúde suplementar.

6.4. Limitações do Estudo

Como em qualquer investigação acadêmica, esta pesquisa apresenta algumas limitações que devem ser reconhecidas para que os resultados sejam interpretados dentro de suas devidas condições e contextos. A primeira limitação está relacionada à **natureza dos dados utilizados**. A análise foi conduzida a partir de bases secundárias, especialmente informações disponibilizadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Embora essas fontes sejam robustas e confiáveis, elas restringem o estudo a variáveis quantitativas, deixando de lado aspectos qualitativos, como percepções de gestores ou estratégias não explicitadas nos relatórios financeiros. Isso pode resultar em lacunas sobre o processo decisório interno das

operadoras de planos de saúde (OPS) e suas motivações não capturáveis estatisticamente.

Outra limitação diz respeito ao **recorte temporal da amostra**, compreendido entre os anos de 2018 e 2023. Embora o período analisado contemple o impacto da pandemia de Covid-19, o qual foi relevante para o desempenho financeiro das OPS, ele pode ser insuficiente para capturar os efeitos de longo prazo em um setor tão dinâmico e sujeito a mudanças econômicas e regulatórias. Um horizonte temporal mais extenso poderia fornecer uma compreensão mais robusta das relações entre variáveis e suas flutuações ao longo de diferentes cenários econômicos.

Além disso, a **homogeneidade da amostra** pode limitar a generalização dos resultados. Foram excluídas empresas com ativos inferiores a um milhão de reais e com patrimônio líquido negativo, o que resulta em uma amostra de aproximadamente 200 empresas. Embora essa seleção tenha buscado garantir a confiabilidade dos dados, ela pode ter excluído OPS menores ou em dificuldades financeiras, que representam uma parcela importante do mercado e que, possivelmente, apresentam dinâmicas distintas em relação ao endividamento e à estrutura de capital.

A **falta de integração entre variáveis qualitativas e quantitativas** também constitui uma limitação. Uma abordagem combinada, como entrevistas com gestores e análise de relatórios de governança, poderia aprofundar a compreensão das decisões financeiras, especialmente em contextos regulatórios e em resposta a crises econômicas.

Por fim, deve-se considerar que o **modelo econométrico utilizado** para dados em painel, embora adequado e tecnicamente consistente, está sujeito a limitações inerentes ao método, como a suposição de linearidade entre as variáveis. Fatores não observáveis ou dinâmicos podem influenciar a relação entre sinistralidade, tangibilidade, desempenho operacional e alavancagem, mas não foram capturados no presente estudo.

6.5. Perspectivas para Pesquisas Futuras

Os resultados e limitações desta pesquisa abrem caminhos promissores para investigações futuras que possam aprofundar a compreensão sobre a estrutura de capital das Operadoras de Planos de Saúde (OPS) no Brasil. Primeiramente, destaca-se a **necessidade de integração entre abordagens quantitativas e qualitativas**. Enquanto este estudo se concentrou em variáveis financeiras e operacionais capturadas em bases secundárias, futuras pesquisas poderiam combinar análises estatísticas com entrevistas aprofundadas com gestores e

reguladores. Essa abordagem permitiria explorar as motivações subjetivas e estratégicas que guiam as decisões de endividamento, além de avaliar a percepção sobre a regulação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e seu impacto no setor.

Outra perspectiva relevante está na **ampliação do horizonte temporal** das análises. O recorte adotado nesta pesquisa (2018–2023) foi essencial para capturar os efeitos imediatos da pandemia de Covid-19, mas não permite observar mudanças estruturais de longo prazo no comportamento das OPS. Estudos futuros poderiam incorporar períodos mais extensos, investigando como a dinâmica econômica, as crises setoriais e as mudanças regulatórias influenciam a alavancagem e a sustentabilidade financeira das operadoras ao longo do tempo.

Além disso, há um vasto potencial para a **análise comparativa entre diferentes segmentos e portes de OPS**. Esta pesquisa identificou diferenças significativas no comportamento financeiro entre operadoras odontológicas e aquelas focadas em planos médicos. Estudos adicionais poderiam aprofundar essa diferenciação, considerando as peculiaridades de cada segmento e o papel do tamanho das empresas na estrutura de capital. Comparações entre operadoras de pequeno, médio e grande porte poderiam revelar como a escala de operação influencia a capacidade de acesso a crédito e o gerenciamento de riscos.

Outro caminho promissor consiste em **investigações sobre o impacto das políticas regulatórias e de governança**. Dada a influência significativa da ANS no setor, estudos futuros poderiam avaliar como mudanças na regulação – como exigências de reservas técnicas, limites prudenciais e índices de solvência – afetam as decisões financeiras das OPS. Modelos de simulação ou análises em cenários alternativos poderiam ser aplicados para propor ajustes nas políticas que equilibram a proteção dos beneficiários com a sustentabilidade das empresas.

Por fim, recomenda-se a **exploração do papel da inovação tecnológica e da digitalização** no desempenho financeiro das OPS. O avanço das tecnologias de saúde, como telemedicina e ferramentas de gestão digital, pode influenciar os custos operacionais, a sinistralidade e, consequentemente, as decisões de alavancagem. Pesquisas futuras poderiam investigar como a adoção de tecnologias impacta a estrutura de capital e a competitividade das operadoras no mercado de saúde suplementar.

6.6. Conclusão

Esta pesquisa analisou os determinantes da estrutura de capital das Operadoras de Planos de Saúde (OPS) no Brasil, um setor regulado, dinâmico e essencial para a oferta de serviços de saúde suplementar no país. A partir de um modelo estatístico aplicado a dados em painel e fundamentado nas teorias de *trade-off* e *pecking order*, foi possível identificar relações significativas entre variáveis setoriais e níveis de endividamento, oferecendo uma compreensão mais aprofundada sobre as decisões financeiras dessas empresas.

Os principais resultados demonstraram que a **sinistralidade** exerce influência positiva sobre a alavancagem, revelando a necessidade das OPS de recorrerem ao crédito em cenários de elevada pressão assistencial. Por outro lado, a **tangibilidade dos ativos** se confirmou como um fator facilitador para a obtenção de dívidas de longo prazo, o que valida a lógica da teoria de *trade-off*. Adicionalmente, a relação negativa entre o **ROA** (Retorno sobre Ativos) e o endividamento corrobora a teoria de *pecking order*, ao evidenciar a preferência das empresas por recursos internos em detrimento do financiamento externo. Esses achados destacam a complexidade das decisões financeiras no setor de saúde suplementar, marcado por características específicas como os riscos assistenciais, a volatilidade de caixa e a regulação rigorosa imposta pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A pesquisa também evidenciou as diferenças nos modelos de negócio, com operadoras odontológicas apresentando maior capacidade de alavancagem em função de margens operacionais mais robustas e menor sinistralidade.

Do ponto de vista teórico, este estudo contribui para o debate sobre as **teorias de estrutura de capital**, ao demonstrar a coexistência de elementos de *trade-off* e *pecking order* no contexto das OPS. Além disso, ele preenche uma lacuna na literatura ao explorar, de maneira específica e sistemática, as peculiaridades financeiras do setor de saúde suplementar no Brasil.

Em termos práticos, os resultados fornecem **subsídios importantes para gestores, reguladores e investidores**. Para os gestores, a pesquisa destaca a importância de uma gestão eficiente das variáveis setoriais, como sinistralidade e reservas técnicas, visando equilibrar a estrutura de capital com a sustentabilidade financeira. Para os reguladores, os achados sugerem a necessidade de políticas mais flexíveis que considerem as diferenças entre as operadoras, garantindo um equilíbrio entre proteção aos beneficiários e viabilidade econômica. Já para os investidores, a identificação dos principais determinantes do endividamento oferece informações valiosas para a avaliação de riscos e oportunidades no setor.

Por fim, a pesquisa reforça a relevância de estudos empíricos focados em setores regulados, especialmente aqueles com forte impacto econômico e social, como o de saúde suplementar.

7. REFERÊNCIAS

A HISTÓRIA das Santas Casas. **Santa Casa de Misericórdia dos Passos**, 02 fevereiro 2016. Disponível em: http://www.scmp.org.br/materia/61/a-historia-das-santas-casas. Acesso em: 13 mar. 2022.

A HISTÓRIA de misericórdia das Santas Casas. **CMB - Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas**, São Paulo, 23 abril 2020. Disponível em: https://www.cmb.org.br/cmb/index.php/institucional/quem-somos/historico. Acesso em: 13 mar. 2022.

ACHARYA, Viral V.; ALMEIDA, Heitor; CAMPELLO, Murillo. Is cash negative debt? A hedging perspective on corporate financial policies. **Journal of financial intermediation**, v. 16, n. 4, p. 515-554, 2007.

ADAMS, B. N.; SYDIE, R. A., 02 de dezembro de 2002. **Introduction to Social Theory**. U. O. Regina, (Ed.). Regina, Estados Unidos, 2002.

ANS inclui teste rápido de Covid-19 nas coberturas obrigatórias dos planos de saúde. **Agência Nacional de Saúde Suplementar**, 06 abril 2022. Disponível em: https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/sobre-ans/ans-aprova-inclusao-de-teste-rapido-para-diagnostico-da-covid-19-no-rol-de-coberturas-obrigatorias-7. Acesso em: 18 abr. 2022.

ANS publica RN no 443 que dispõe sobre a adoção de práticas mínimas de governança corporativa. **Associação Nacional das Administradoras de Benefícios**, 29 janeiro 2019. Disponível em: https://anab.com.br/ans-publica-rn-no-443-que-dispoe-sobre-a-adocao-de-praticas-minimas-de-governanca-corporativa/. Acesso em: 29 dez. 2021.

ANTONIOU, Antonios; GUNEY, Yilmaz; PAUDYAL, Krishna. The determinants of capital structure: capital market-oriented versus bank-oriented institutions. **Journal of Financial and Quantitative Analysis**, v. 43, n. 1, p. 59-92, 2008.

ARANOVICH, Tatiana de Campos; LEANDRO, Tainá. Covid-19 e a nova concentração do mercado de planos de saúde. **Revista do Ibrac**, n. 1, p. 171- 193, 2021. Disponível em: https://www.ibrac.org.br/UPLOADS/PDF/RevistadoIBRAC/Revista_do_IBRAC_n_1_2021.pdf#page=172. Acesso em: 23 mai. 2022.

ARAUJO, Angela Maria. **A regulação do mercado de saúde suplementar no Brasil**: barreiras à entrada e à saída de operadoras de planos privados de assistência à saúde. 2004. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) – Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2004. Disponível em: https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40242. Acesso em: 05 jul. 2022.

ARAUJO, Marcio Luiz Onida de; FRANÇA, Eduardo Cambiriba; SILVA, Fabiana Lopes da; GRECCO, Marta Cristina Pelucio. Impacto da Covid-19 na sustentabilidade financeira das operadoras de planos de saúde. In: EMPRAD - Encontro dos Programas de Pós-Graduação Profissionais em Administração. **Anais** [...]. São Paulo: Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, 2021. Disponível em: http://sistema.emprad.org.br/7/arquivos/46.pdf. Acesso em: 23 mai. 2022.

ARDALAN, Karvous. **On the Role of Paradigms**: alternative voices in contemporary economics. Londres: Routlege, 2008.

AVELAR, Ewerton Alex; SOUZA, Antônio Artur de. Gestão do capital de giro em operadoras de planos de saúde: uma análise sob a perspectiva do modelo dinâmico. **ForScience**, v. 6, n. 1, 2018. Disponível em: http://www.forscience.ifmg.edu.br/forscience/index.php/forscience/article/view/300. Acesso em: 31 jul. 2021.

BAKER, H. Kent; MARTIN, Gerald S. **Capital Structure and Corporate Financing Decisions**: Theory, Evidence, and Practice. Nova Jersey: John Wiley & Sons, 2011.

BAKER, Malcolm; WURGLER, Jeffrey. Market Timing and Capital Structure. **The Journal of Finance**, v. 57, n.1, p. 1-32, 2002.

BALBINOTTO NETO, Giacomo. A participação do setor saúde na economia brasileira: dados recentes. **Análise: conjuntura nacional e Coronavírus**. FCE/UFRGS. Porto Alegre, 13 abril 2020. Disponível em: https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/213866/001117424.pdf?sequence=1. Acesso em: 03 ago. 2022.

BARCLAY, Michael J.; SMITH JR., Clifford W. The maturity structure of corporate debt. **The Journal of Finance**, v. 50, n. 2, p. 609-631, 1995.

BARTH, Mary E.; LANDSMAN, Wayne R.; LANG, Mark H. International accounting standards and accounting quality. **Journal of Accounting Research**, v. 46, n. 3, p. 467-498, 2008.

BAUM, Christopher F; STEPHAN, Andreas; TALAVERA, Oleksandr. The effects of uncertainty on the leverage of nonfinancial firms. **Economic Inquiry**, v. 47, n. 2, p. 216-225, 2009.

BEKAERT, Geert; HARVEY, Campbell R. Emerging markets finance. **Journal of Empirical Finance**, v. 10, n. 1-2, p. 3-55, 2003.

BENDERSKY, Corinne; MCGINN, Kathleen L. Perspective - open to negotiation: Phenomenological assumptions and knowledge dissemination. **Organization Science**, v. 21, n. 3, p. 781-797, 2010. Disponível em: https://www.jstor.org/stable/40792444. Acesso em: 05 jul. 2022.

BEUNZA, Daniel Ibanez et al. Finance in Organization Theory: State of the Art and Future Research Agenda. In: **Academy of Management Proceedings**. Briarcliff Manor, Nova York 10510: Academy of Management, p. 12370, 2019. Disponível em: https://journals.aom.org/doi/abs/10.5465/AMBPP.2019.12370symposium. Acesso em: 05 jul. 2022.

BEUNZA, Daniel; FERRARO, Fabrizio. Performative work: Bridging performativity and institutional theory in the responsible investment field. **Organization Studies**, v. 40, n. 4, p. 515-543, 2019. Disponível em: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0170840617747917. Acesso em: 05 jul. 2022.

BITTENCOURT, Wanderson Rocha; ALBUQUERQUE, Pedro Henrique Melo. Estrutura de capital: uma revisão bibliográfica das publicações dos periódicos nacionais. **Revista Contemporânea de Contabilidade**, v. 15, n. 34, p. 94-114, 2018. Disponível em: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6678571. Acesso em: 05 jul. 2022.

BLACK, Fischer; SCHOLES, Myron. The pricing of options and corporate liabilities. **Journal of Political Economy**, v. 81, n. 3, p. 637-654, 1973.

BÖHM, Katharina et al. Classifying OECD healthcare systems: a deductive approach. **TranState Working Papers**, 2012. Disponível em: https://www.econstor.eu/handle/10419/64809. Acesso em: 05 jul. 2022.

BRADLEY, Michael; JARRELL, Gregg A.; KIM, E. Han. On the existence of an optimal capital structure: Theory and evidence. **The Journal of Finance**, v. 39, n. 3, p. 857-878, 1984.

BRAGA, André Sousa. **Estrutura de capital das operadoras de planos de assistência à saúde e as influências do órgão regulador**. 2017. p.87. Dissertação (Mestrado em Administração) – Universidade FUMEC, Faculdade de Ciências Empresariais, Belo Horizonte, 2017. Disponível em: https://repositorio.fumec.br/handle/123456789/241. Acesso em: 05 de julho de 2022.

BRAGANÇA, Ciro Gustavo. **Liquidação de operadoras de planos de assistência à saúde no Brasil**. 2017. Dissertação (Mestrado em Controladoria e Contabilidade) – Universidade Federal de Minas Gerais, Centro de Pós-Graduação e Pesquisas em Controladoria e Contabilidade, 2017. Disponível em: https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUOS-AS9GNM/1/dissertacao_ciro_gustavo_braganca.pdf. Acesso em: 05 jul. 2022.

BRASIL. Agência Nacional de Saúde Suplementar. **Sala de Situação**, 2021. Disponível em: https://www.ans.gov.br/images/stories/Materiais_para_pesquisa/Perfil_setor/sala-de-situacao.html.

Acesso em: 18 jan. 2022.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Resolução-RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002**. Brasília: Ministério da Saúde, 2002. Disponível em: https://sbim.org.br/images/legislacao/rdc-2002-50.pdf. Acesso em: 29 dez. 2021.

BRASIL. Agência Nacional de Saúde Suplementar. **Dados gerais**. Disponível em: https://www.ans.gov.br/perfil- do-setor/dados-gerais. Acesso em: 16 abr. 2020.

BRASIL. Agência Nacional de Saúde Suplementar. **Histórico**. Disponível em: http://www.ans.gov.br/aans/quem-somos/ historico. Acesso em: 16 abr. 2020.

BRASIL. ANS avança em mais uma etapa da implementação do Capital Baseado em Riscos. **Agência Nacional de Saúde Suplementar**, 16 junho 2021. Disponível em: https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/sobre-ans/ans-avanca-em-mais-uma-etapa-da-implementacao-do-capital-baseado-em-riscos. Acesso em: 03 ago. 2022.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.

BRASIL. **Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011**. Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7508.htm. Acesso em: 17 jan. 2022.

BRASIL. **Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966**. Dispõe Sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados, regula as operações de seguros e resseguros e dá outras providências Disponível em: http://www.susep.gov.br/textos/Decreto-Lei73-66-jul07.pdf. Acesso em: 14 mar. 2022.

BRASIL. **Lei nº 10.185, de 12 de fevereiro de 2001**. Dispõe sobre a especialização das sociedades seguradoras em planos privados de assistência à saúde e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10185.htm. Acesso em: 20 julho 2021.

BRASIL. **Portaria nº 414 de 18 de março de 2020**: autoriza a habilitação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva Adulto e Pediátrico, para atendimento exclusivo dos pacientes Covid-19. Diário Oficial da União nº 55, de 20 de março de 2020, Seção 1, p. 149. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-414-de-18-de-marco-de-2020-*-251908689. Acesso em: 23 abr. 2022.

BRASIL. **Proposta de Emenda Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016**. Disponível em: https://legis.senado.leg.br/norma/540698/publicacao/15655553. Acesso em: 06 jan. 2022.

BRASIL. Qualidade Econômico Financeira. **Agência Nacional de Saúde Suplementar**, 2004. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/qualificacao_saude_sup/f_materia_15275.htm. Acesso em: 28 abr. 2021.

BRASIL. **Qualificação da Saúde Suplementar**: nova perspectiva no processo de regulação. Rio de Janeiro: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, 2004. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/qualificacao_saude_sup/pdf/completo.pdf. Acesso em: 27 ago. 2021.

BRASIL. **Resolução de Diretoria Colegiada nº 39, de 27 de outubro de 2000**. Dispõe sobre a definição, a segmentação e a classificação das Operadoras de Planos de Assistência à Saúde. Disponível em: http://www.ans.gov.br/index2.php?option=com_legislacao&view=legislacao&task=TextoLei&format= raw&id=380. Acesso em: 20 jul. 2021.

BRASIL. **Resolução Normativa nº 386, de 9 de outubro de 2015**. Disponível em: https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=304526. Acesso em: 29 abr. 2021.

BRASIL. **Resolução Normativa nº 468, de 10 de junho de 2021**. Altera a resolução Normativa RN

nº 451, de 6 de março de 2020. Disponível em: http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=NDA1OA==. Acesso em: 30 jul. 2021.

BRASIL. **Resolução nº 1, de 29 de setembro de 2011**. Estabelece diretrizes para a instituição de Regiões de Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), nos termos do Decreto nº 7508, de 28 de junho de 2011. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cit/2011/res0001_29_09_2011.html. Acesso em: 30 jul. 2021.

BRENNAN, Michael J.; SCHWARTZ, Eduardo S. Corporate income taxes, valuation, and the problem of optimal capital structure. **Journal of Business**, p. 103-114, 1978.

BRITO, Giovani Antonio Silva; CORRAR, Luiz J.; BATISTELLA, Flávio Donizete. Fatores determinantes da estrutura de capital das maiores empresas que atuam no Brasil. **Revista Contabilidade & Finanças**, v. 18, p. 9-19, 2007. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rcf/a/6pqnK9kLtbxwtwnLgWBfxFg/?lang=pt&format=html. Acesso em: 05 jul. 2022.

BROCKMAN, Paul; MARTIN, Xiumin; UNLU, Emre. Executive compensation and the maturity structure of corporate debt. **The Journal of Finance**, v. 65, n. 3, p. 1123-1161, 2010.

BRUIN, B. et al. Philosophy of Money and Finance. **Stanford Encyclopedia of Philosophy**, 2018. Disponível em: https://plato.stanford.edu/archives/win2020/entries/money-finance/. Acesso em: 04 ago. 2022.

BRUNALDI, Eduardo Ottoboni. **Does the nature of large projects affect the financing decisions over the investment period?**. 2017. Tese de Doutorado – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.

BURRELL, Gibson; MORGAN, Garret. **Sociological Paradigms and Organizational Analysis**: Elements of the Sociology of Corporate Life. Londres: Routlege, 2019 [1979].

CAMARGO, Daniel Martin de Figueiredo; FONSECA, Simone Evangelista; SOUSA, Antônio Artur. O endividamento das operadoras de planos de saúde suplementar por modalidade e o contexto macroeconômico do mercado brasileiro. **XXVII Semead - Seminário em Administração**. São Paulo: FEAUSP, 2024.

CAMPOS, Claudio. **Confronto das teorias de Pecking Order e Trade-Off**: evidências com base nas companhias brasileiras abertas. 2008. Dissertação (Mestrado em Administração) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2008. Disponível em: https://dspace.mackenzie.br/handle/10899/23547. Acesso em: 06 jul. 2022.

CARMO, Eduardo do. **Desempenho organizacional de operadora de planos de saúde suplementar no Brasil**: estudo de caso de uma cooperativa médica. 2016. Dissertação (Mestrado em Administração) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2016. Disponível em: https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/17928. Acesso em: 06 jul. 2022.

CASSIANO, Thais de Sirqueira. **Análise financeira das operadoras de planos de saúde entre os anos de 2013 a 2016**. 2019. Monografia (Especialização em Gestão Estratégica de Negócios) – Centro de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2019. Disponível em: https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/36078. Acesso em: 06 jul. 2022.

CATRIB, João Pedro Bertani; BRITTO, Paulo Augusto P. de; SERRANO, André Luiz Marques. A estrutura de capital de empresas brasileiras de capital aberto: uma análise de seus determinantes. **Economics and Politics Working Paper**, n. 67, 04 maio 2016. Disponível em: https://econpolrg.files.wordpress.com/2016/05/eprg-wp-2016-671.pdf. Acesso em: 11 jul. 2022.

CHEN, Hui; WANG, Hao; ZHOU, Hao. Stock return volatility and capital structure decisions. PBCSF-NIFR **Research Paper**, n. 13-04, 2014.

COLLA, Paolo; IPPOLITO, Filippo; LI, Kai. Debt specialization. **The Journal of Finance**, v. 68, n. 5, p. 2117-2141, 2013.

COMBATE ao coronavírus: ANS define novas medidas para o setor de planos de saúde. **Agência Nacional de Saúde Suplementar**, 06 janeiro 2022. Disponível em: https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/covid-19/combate-ao-coronavirus-ans-define-novas-medidas-para-o-setor-de-planos-de-saude. Acesso em: 03 ago. 2022.

CONHEÇA as modalidades de operadoras de planos de saúde suplementar no Brasil. **Previva**, 01 julho 2021. Disponível em: https://previva.com.br/tipos-modalidades-operadoras-de-planos-de-saude/. Acesso em: 20 jul. 2021.

COOK, Thomas D.; CAMPBELL, Donald Thomas; SHADISH, William. **Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference**. Boston: Houghton Mifflin, 2002.

CORONAVÍRUS (Covid-19). **Agência Nacional de Saúde Suplementar**. Disponível em: https://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/coronavirus-covid-19. Acesso em: 18 abr. 2022.

CORREA, Carlos Alberto; BASSO, Leonardo Fernando Cruz; NAKAMURA, Wilson Toshiro. A estrutura de capital das maiores empresas brasileiras: análise empírica das teorias de pecking order e trade-off, usando panel data. **RAM - Revista de Administração Mackenzie**, v. 14, p. 106-133, 2013. Disponível em: https://www.scielo.br/j/ram/a/zvYnQf79jh4zDN79nC3vFZn/?format=html&lang=pt. Acesso em: 16 mar. 2022.

COSTA, Danielle Conte Alves Riani et al. Oferta pública e privada de leitos e acesso aos cuidados à saúde na pandemia de Covid-19 no Brasil. **Saúde em Debate**, v. 44, p. 232-247, 2021. Disponível em: https://www.scielosp.org/article/sdeb/2020.v44nspe4/232-247/pt/. Acesso em: 23 abr. 2022.

DAMODARAN, Aswath. **Finanças Corporativas**: Teoria e Prática. Porto Alegre: Bookman, 2004.

DAVIS, Gerald F. **Managed by Markets**: How finance re-shaped America. Oxford: Oxford University Press, 2009.

DAVIS, Gerald F. **The Vanishing American Corporation**: Navigating the hazards of a new economy. Oakland: Berret-Koehler Publishers, 2016.

DEANGELO, Harry; MASULIS, Ronald W. Optimal capital structure under corporate and personal taxation. **Journal of Financial Economics**, v. 8, n. 1, p. 3-29, 1980.

DIERKER, Martin et al. Do firms adjust capital structures to manage risk? **KAIST College of Business Working Paper Series**, n. 2013-031, 2013.

DIMAGGIO, Paul J. Comments on "What Theory is Not". **Administrative science quarterly**, v. 40, n. 3, p. 391-397, 1995. Disponível em: https://www.jstor.org/stable/2393790. Acesso em: 11 jul. 2022.

DURAND, David. Costs of debt and equity funds for business: trends and problems of measurement. In: **Conference on research in business finance**. Cambridge: NBER, janeiro de 1952, p. 215-262. Disponível em: https://www.nber.org/system/files/chapters/c4790/c4790.pdf. Acesso em: 04 ago. 2022.

DURAND, David. The cost of capital, corporation finance, and the theory of investment: comment. **The American Economic Review**, v. 49, n. 4, p. 639-655, setembro de 1959. Disponível em: https://www.jstor.org/stable/1812918. Acesso em: 04 ago. 2022.

EDMONDSON, A. C. Crossing boundaries to investigate problems in the field: An approach to useful research. In: MOHRMAN, Susan Albers; LAWLER III, Edward E. **Useful research**: Advancing theory and practice. California: Berrett-Koehler Publishers, 2011, p. 37-55.

ELSAS, Ralf; FLORYSIAK, David. Empirical capital structure research: New ideas, recent evidence, and methodological issues. **Zeitschrift für Betriebswirtschaft (Journal of Business Economics)**, n. 6, p. 39-71, 2008. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1634932. Acesso em: 11 jul. 2022.

EMPRESAS de saúde na bolsa: saiba por que elas estão entre as maiores do país. **Bloxs**, São Paulo, 16 junho 2021. Disponível em: https://conteudos.bloxs.com.br/empresas-de-saude-na-bolsa-saiba-por-que-elas-estao-entre-as-maiores-do-pais. Acesso em: 05 jul. 2022.

FÁVERO, Luiz Paulo.; BELFIORE, Patrícia. **Manual de análise de dados**: estatística e modelagem multivariada com Excel®, SPSS® e Stata®. Elsevier Brasil, 2017.

FIGUEIREDO, Juliana Oliveira et al. Gastos público e privado com saúde no Brasil e países selecionados. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 42, p. 37-47, outubro de 2018. Disponível em: https://www.scielo.br/j/sdeb/a/hbzwsvZnS7PbVJsXsfWJSfB/abstract/?lang=pt. Acesso em: 11 jul. 2022.

FLIGSTEIN, Neil. Organizations: Theoretical debates and the scope of organizational theory. In*:* ABRUTYN, Seth; LIZARDO, Omar. **Handbook of classical sociological theory**. Londres: Springer, 2021, p. 487-506.

FORTI, C. A. B.; PEIXOTO, F. M.; ALVES, D. L. Fatores determinantes do pagamento de dividendos no Brasil. **Revista Contabilidade & Finanças**, v. 26, p. 167-180, 2015

FRANK, Murray Z.; GOYAL, Vidhan K. Capital Structure Decisions: which factors are reliably important?. **Financial Management**, v. 38, n. 1, p. 1-37, 2009.

FRIEND, Irwin; LANG, Larry HP. An empirical test of the impact of managerial self-interest on corporate capital structure. **The Journal of Finance**, v. 43, n. 2, p. 271-281, 1988.

GAMARRA, Tatiana Pereira das Neves. A produção acadêmica sobre a Agência Nacional de Saúde Suplementar: um olhar a partir da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. **Saúde e Sociedade**, São Paulo, v. 26, p. 712-725, julho-setembro 2017. Disponível em: https://www.scielosp.org/article/sausoc/2017.v26n3/712-725/pt/. Acesso em: 11 jul. 2022.

GERVÁSIO, Luísa Raad; AVELAR, Ewerton Alex; VIEIRA, Carlos Maurício. Administração do capital de giro de operadoras de planos de saúde: uma análise sob a perspectiva do Modelo Fleuriet. **FACEF Pesquisa-Desenvolvimento e Gestão**, v. 22, n. 2, 2019. Disponível em: http://periodicos.unifacef.com.br/index.php/facefpesquisa/article/view/1644/1316. Acesso em: 31 jul. 2021.

GIL, Antonio C. **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social**, 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2019.

GOLDSTEIN, Harvey. **Multilevel statistical models**. Nova Jersey: John Wiley & Sons, 2011.

GUERRA, Mariana. **Análise de Desempenho de Organizações Hospitalares**. 2011. Dissertação (Mestrado em Contabilidade e Controladoria) – Faculdade de Ciências Econômicas (FACE) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, 2011. Disponível em: https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/BUOS-8KZNFA. Acesso em: 01 abr. 2021.

GUJARATI, D. N. **Econometria básica**, 4ª ed. Rio de Janeiro: Campus Elsevier, 2006.

GÜNBAYI, Ilhan; SORM, Sath. Social paradigms in guiding social research design: The functional, interpretive, radical humanist and radical structural paradigms. **International Journal on New Trends in Education and Their Implications**, v. 9, n. 2, p. 57-76, abril 2018. Disponível em: https://eric.ed.gov/?id=ED585253. Acesso em: 11 jul. 2022.

HADDAD, Kamal; LOTFALIEI, Babak. Trade-off theory and zero leverage. **Finance Research Letters**, v. 31, p. 165-170, 2019.

HAIR JR, Joseph F. et al. **Fundamentos de métodos de pesquisa em administração**. Porto Alegre: Bookman Companhia, 2005.

HALL, Bronwyn H.; LERNER, Josh. The financing of R&D and innovation. In: **Handbook of the Economics of Innovation**. North-Holland, 2010, p. 609-639.

HEATON, James B. Managerial optimism and corporate finance. **Financial Management**, p. 33-45, 2002.

HISTÓRIA das Santas Casas. **IBAO - Instituto Borges de Artes e Ofícios**, Itu. Disponível em: https://iscmitu.org.br/historia-das-santas-casas/. Acesso em: 13 mai. 2022.

HISTÓRICO da pandemia de Covid-19. **Organização Pan-Americana de Saúde**. Disponível em: https://www.paho.org/pt/covid19/historico-da-pandemia-covid-19. Acesso em: 18 abr. 2022.

HOSPITAL and Health Systems Face Unprecedented Financial Pressures Due to Covid-19. **American Hospital Association**, maio 2020. Disponível em: https://www.aha.org/guidesreports/2020-05-05-hospitals-and-health-systems-face-unprecedented-financial-pressures-due. Acesso em: 03 ago. 2022.

HOVAKIMIAN, Armen. Are observed capital structures determined by equity market timing? **Journal of Financial and Quantitative Analysis**, v. 41, n. 1, p. 221-243, 2006.

HSIAO, Cheng; YANAN, Wang. Panel Data Analysis - Advantages and Challenges. **Wise Working Paper Series - WISEW P0602**, Xiamen, p. 1-35, abril 2006. Disponível em: https://core.ac.uk/download/pdf/41362905.pdf. Acesso em: 13 mai. 2021.

INÁCIO, Raoni De Oliveira et al. Estudo da intenção de doar dinheiro para as Santas Casas de Misericórdia Brasileiras. **Journal of Globalization, Competitiveness and Governability**, Washington, v. 14, n. 3, setembro-dezembro 2020. Disponível em: https://gcgjournal.georgetown.edu/index.php/gcg/article/view/4140. Acesso em: 11 jul. 2022.

IPEA - INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. **Políticas Sociais: acompanhamento e análise**, n. 28, Brasília, 2021. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=37679&Itemid=9. Acesso em: 03 ago. 2022.

JARZABKOWSKI, Paula et al. Between State and Market: Protection gap entities and catastrophic risk. **Cass Business School**, City, University of London, London, UK. Disponível em: https://eprints.bbk.ac.uk/id/eprint/26795/1/PGE-Report-FINAL.pdf. Acesso em: 03 ago. 2022.

JARZABKOWSKI, Paula et al. Exploring inter-organizational paradoxes: Methodological lessons from a study of a grand challenge. **Strategic Organization**, v. 17, n. 1, p. 120-132, fevereiro 2019. Disponível em: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1476127018805345. Acesso em: 11 jul. 2022.

JARZABKOWSKI, Paula. Exploring the interplay between global financial systems, global development goals, and local economic contexts. **Academy of Management Annual Meeting Proceedings**. Academy of Management, 2019.

JENSEN, Michael C.; MECKLING, William H. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. **Journal of Financial Economics**, v. 3, n. 4, p. 305-360, 1976.

JUNIOR, F. H. F. C.; YOSHINAGA, C. E. Coassimetria, cocurtose e as taxas de retorno das ações: uma análise com dados em painel. **RAM - Revista de Administração Mackenzie**, v. 13, n. 1, p. 110-144, 2012.

KAMIEN, Morton I.; SCHWARTZ, Nancy L. Self-Financing of an R and D Project. **The American Economic Review**, v. 68, n. 3, p. 252-261, 1978.

KAVESKI, Itzhak D. S.; ZITTEI, Marcus V. M.; SCARPIN, Jorge E. Trade-off e Pecking order: Uma Análise das Empresas de Capital Aberto da América Latina. In: XIV CONGRESSO USP CONTROLADORIA E CONTABILIDADE, 2014, São Paulo. **Anais** [...]. São Paulo: USP, 2014. Disponível em: https://congressousp.fipecafi.org/anais/artigos142014/365.pdf. Acesso em: 17 mar. 2021.

KAYE, Alan D. et al. Economic impact of COVID-19 pandemic on healthcare facilities and systems: International perspectives. **Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology**, v. 35, n. 3, p. 293-306, 2021. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7670225/pdf/main.pdf. Acesso em: 12 mar. 2022.

KAYHAN, Ayla.; TITMAN, Sheridan. Firms' histories and their capital structures. **Journal of**

Financial Economics, v. 83, n. 1, p. 1-32, 2007.

KAYO, Eduardo K.; BRUNALDI, Eduardo Ottoboni; ALDRIGHI, Dante M. Capital Structure adjustment in Brazilian family firms. **Revista de Administração Contemporânea**, v. 22, n. 1, p. 92-114, 2018.

KEEFE, Michael O'Connor; YAGHOUBI, Mona. The influence of cash flow volatility on capital structure and the use of debt of different maturities. **Journal of Corporate Finance**, v. 38, p. 18-36, 2016.

KESTER, W. Carl. Capital and ownership structure: A comparison of United States and Japanese manufacturing corporations. **Financial Management**, p. 5-16, 1986.

KIM, Wi Saeng; SORENSEN, Eric H. Evidence on the impact of the agency costs of debt on corporate debt policy. **Journal of Financial and Quantitative Analysis**, p. 131-144, 1986.

KOVÁCS, Gyöngyi; SPENS, Karen M. Abductive reasoning in logistics research. **International journal of physical distribution & logistics management**, v. 35, n. 2, p. 132-144, fevereiro 2005. Disponível em: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/09600030510590318/full/html. Acesso em: 25 jul. 2022.

KRAUS, Alan.; LITZENBERGER, Robert H. A state-preference model of optimal financial leverage. **The Journal of Finance**, v. 28, n. 4, p. 911-922, 1973.

KUHN, Thomas S. **A estrutura das revoluções científicas**. São Paulo: Perspectiva, 2017 [1962].

LA ROCCA, Maurizio; LA ROCCA, Tiziana; CARIOLA, Alfio. Capital structure decisions during a firm's life cycle. **Small Business Economics**, v. 37, n. 1, p. 107-130, agosto de 2011. Disponível em: https://link.springer.com/article/10.1007/s11187-009-9229-z. Acesso em: 25 jul. 2022.

LAGOARDE-SEGOT, Thomas. Diversifying finance research: From financialization to sustainability. **International Review of Financial Analysis**, v. 39, p. 1-6, janeiro 2015. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1057521915000150?via%3Dihub. Acesso em: 25 jul. 2022.

LEARY, Mark T.; ROBERTS, Michael R. Do firms rebalance their capital structures? **The Journal of Finance**, v. 60, n. 6, p. 2575-2619, 2005.

LEARY, Mark T.; ROBERTS, Michael R. Do peer firms affect corporate financial policy? **The Journal of Finance**, v. 69, n. 1, p. 139-178, 2014.

LEHOUX, Pascale et al. Providing value to new health technology: the early contribution of entrepreneurs, investors, and regulatory agencies. **International Journal of Health Policy and Management**, v. 6, n. 9, p. 509, janeiro 2017. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5582437/. Acesso em: 25 jul. 2022.

LEI, Jin; QIU, Jiaping; WAN, Chi; YU, Fan. Credit risk spillovers and cash holdings. **Journal of Corporate Finance**, n. 68, v. 101965, 2021.

LELAND, Hayne E. Corporate debt value, bond covenants, and optimal capital structure. **The Journal of Finance**, v. 49, n. 4, p. 1213-1252, 1994.

LEVINE, Oliver; WU, Youchang. Asset volatility and capital structure: Evidence from corporate mergers. **Management Science**, v. 67, n. 5, p. 2773-2798, 2021.

LIMA, Jean Santos de; DE SOUZA, Paulo Cesar. Sinistralidade em contratos de plano de saúde médico hospitalar. **Revista de Gestão em Sistemas de Saúde**, São Paulo v. 8, n. 2, maio/agosto 2019. Disponível em: https://periodicos.uninove.br/revistargss/article/view/14975. Acesso em: 31 jul. 2021.

LINHA do tempo do Coronavírus no Brasil. **SANAR**, 19 março 2020. Disponível em: https://www.sanarmed.com/linha-do-tempo-do-coronavirus-no-brasil. Acesso em: 18 abr. 2022.

LOPES, Ruan Vítor. **Os impactos da Assimetria de Informação na Estrutura de Capital:** Modelagem de Regressão em Painel a partir da Teoria do Pecking Order. 2018. Trabalho de

Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Socioeconômico, Ciências Contábeis, Santa Catarina, 2018. Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/217550. Acesso em: 01 abr. 2021.

MACHADO, João Filipe Andrade. **Estrutura de capitais do sector da saúde em Portugal**. 2015. Dissertação (Mestrado em Auditoria e Fiscalidade) – Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Economia e Gestão, Lisboa, 2015. Disponível em: https://repositorio.ucp.pt/handle/10400.14/19268. Acesso em: 25 jul. 2022.

MACHADO, Luiz Kennedy Cruz et al. A relevância da estrutura de capital no desempenho das firmas: uma análise multivariada das empresas brasileiras de capital aberto. **Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade (REPeC)**, v. 9, n. 4, outubro/dezembro 2015. Disponível em: http://www.repec.org.br/repec/article/view/1313. Acesso em: 14 mar. 2021.

MAIA, Alexandre Gori. **Análise de Dados em Painel, notas de aulas**. Universidade Nacional Agraria La Molina, Peru, s.d. Disponível em: https://www4.eco.unicamp.br/docentes/gori/images/arquivos/EconometriaAplicadaII/EP8105Aulas4e5_DadosPainel.pdf. Acesso em: 25 jul. 2022.

MÂNICA, Fernando Borges. Parcerias no setor da saúde. In: CAMPILONGO, Celso Fernandes; GONZAGA, Alvaro de Azevedo; FREIRE, André Luiz (Coords.). **Enciclopédia Jurídica da PUC-SP**. Tomo: Direito Administrativo e Constitucional, 1ª ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/123/edicao-1/parcerias-no-setor-da-saude. Acesso em: 24 ago. 2021.

MANN, William. Creditor Rights and Innovation: Evidence from Patent Collateral. **Journal of Financial Economics**, v. 130, n. 1, p. 25-47, 2018.

MARTINS, Henrique Castro; SCHIEHLL, Eduardo; TERRA, Paulo Renato Soares. Country-level governance quality, ownership concentration, and debt maturity: A comparative study of Brazil and Chile. **Corporate Governance: An International Review**, v. 25, n. 4, p. 236-254, 2017.

MARTINS, Norberto Montani; OCKÉ-REIS, Carlos Octávio; DRACH, Daniel Chaves. **Financeirização dos planos de saúde**: o caso das operadoras líderes no Brasil (2007-2019). Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2021. Disponível em: https://www.ie.ufrj.br/images/IE/TDS/2021/TD_IE_001_2021_MARTINS_OCKE-REIS_DRACH.pdf. Acesso em: 25 jul. 2022.

MENDES, J. S.; NAKAMURA, W. T.; RABÊLO, O. S. Relação entre IFRS mandatório e criação de valor. **Contabilidade Vista & Revista**, v. 31, n. 1, p. 58-84, 2020.

MERTON, Robert C. On the pricing of corporate debt: The risk structure of interest rates. **The Journal of Finance**, v. 29, n. 2, p. 449-470, 1974.

MILLER, Merton H. Debt and taxes. **The Journal of Finance**, v. 32, n. 2, p. 261-275, 1977.

MINTON, Bernadette A.; SCHRAND, Catherine. The impact of cash flow volatility on discretionary investment and the costs of debt and equity financing. **Journal of Financial Economics**, v. 54, n. 3, p. 423-460, 1999.

MITUSHIMA, Alexandre H.; NAKAMURA, Wilson T.; ARAÚJO, Bruno H. Determinantes da estrutura de capital de companhias abertas brasileiras e a velocidade de ajuste ao nível meta: análise do período de 1996 a 2007. **Anais do XXXIV Encontro da ANPAD**, Rio de Janeiro, v. 25, 2010.

MODIGLIANI, Franco; MILLER, Merton H. The cost of capital, corporation finance and the theory of investment. **The American Economic Review**, v. 48, n. 3, p. 261-297, 1958. Disponível em: https://www.jstor.org/stable/1809766. Acesso em: 25 jul. 2022.

MYERS, Stewart C. Capital Structure Puzzle. **The Journal of Finance**, v. 39, n. 3, p. 575-592, julho 1984. Disponível em: https://www.nber.org/papers/w1393. Acesso em: 25 jul. 2022.

MYERS, Stewart C. Capital Structure. **Journal of Economic Perspectives**, v. 15, n. 2, p. 81-102, 2001. Disponível em: jstor.org/stable/2696593. Acesso em: 29 mai. 2021.

MYERS, Stewart C. The Capital Structure Puzzle. **The Journal of Finance**, v. 39, n. 3, p. 575-592, 1984.

MYERS, Stewart C.; MAJLUF, Nicholas S. Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. **Journal of Financial Economics**, v. 13, n. 2, p. 187-221, junho 1984. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0304405X84900230. Acesso em: 25 jul. 2022.

NAKAMURA, Wilson Toshiro et al. Determinantes de estrutura de capital no mercado brasileiro: análise de regressão com painel de dados no período 1999-2003. **Revista de Contabilidade e Finanças da USP**, n. 44, v. 18, p. 72-85, agosto 2007. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rcf/a/Qh9ddq7pZqj3qp3RQNZFDZv/abstract/?lang=pt. Acesso em: 25 jul. 2022.

NAKAMURA, Wilson Toshiro; MARTIN, Diogénes Manoel Leiva; KIMURA, Herbert. Novas Evidências sobre Estrutura de Capital no Brasil, **Anais do CLADEA**, 2004, realizado em Puerto Plata, República Dominicana.

NAKAMURA, Wilson Toshiro; MOTA, Almir da Silva. Decisões de estrutura de capital de empresas brasileiras: um estudo empírico. **CLADEA**, 2002.

NETO, Gonzalo Vecina; MALIK, Ana Maria. **Gestão em Saúde**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.

NETO, João Rodrigues. **Suficiência das operadoras de planos de saúde em relação à garantia de lastros das provisões**. 2019. Monografia (Graduação em Ciências Atuariais) – Universidade Federal da Paraíba, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, João Pessoa, 2019. Disponível em: http://www.ccsa.ufpb.br/atuariais/contents/documentos/joao.pdf. Acesso em: 25 jul. 2022.

OCKÉ-REIS, Carlos Octávio. Os desafios da ANS frente à concentração dos planos de saúde. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 12, p. 1041-1050, 2007. Disponível em: https://www.scielosp.org/article/ssm/content/raw/?resource_ssm_path=/media/assets/csc/v12n4/22.pdf. Acesso em: 25 jul. 2022.

OLIVEIRA, Jean Pierre David. **Avaliação da margem de solvência de uma operadora de plano de saúde**. 2016. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) – Universidade Federal do Espírito Santo, Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas, Vitória, 2016. Disponível em: http://repositorio.ufes.br/handle/10/8865. Acesso em: 21 jul. 2021.

PEREIRA, Carmem Campos. **Edifícios de saúde**: Construção Retrofit. 2020. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, São Paulo, 2020. Disponível em: https://dspace.mackenzie.br/handle/10899/26655. Acesso em: 01 abr. 2021.

PESQUISA ANAB de Planos de Saúde 2021. **Associação Nacional das Administradoras de Benefícios**, 08 novembro 2021. Disponível em: https://anab.com.br/pesquisa-anab-planos-de-saude-2021/. Acesso em: 29 dez. 2021.

PETERS, Gabriel. Anthony Giddens entre a hermenêutica e a crítica: o status do conhecimento de senso comum na teoria da estruturação. **Plural**, v. 21, n. 2, p. 168-194, 2014. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/plural/article/view/97218. Acesso em: 25 jul. 2022.

PINHEIRO, Isabel Cristina Barbosa et al. Efeitos da regulação econômico-financeira nas estratégias de financiamento das operadoras de planos de saúde. **Revista Universo Contábil**, v. 11, n. 2, p. 108-127, 2015. Disponível em: https://bu.furb.br/ojs/index.php/universocontabil/article/view/4396. Acesso em: 05 jul. 2022.

PINI, V.; SOARES, M.; UNGARETTI, M. **Hapvida (HAPV3) e GNDI (GNDI3)**: um olho no crescimento e o outro na fusão. Expert Pass XP. 30 março 2021. Disponível em: https://conteudos.xpi.com.br/acoes/relatorios/hapvida-hapv3-e-gndi-gndi3-um-olho-no-crescimento-e-o-outro-na-fusao-iniciando-com-compra/. Acesso em: 18 jan. 2022.

PINTO, Daniel de Sousa. **Visão dos gestores sobre o modelo de compartilhamento de riscos na saúde suplementar brasileira**. 2020. Dissertação (mestrado profissional MPGC) – Fundação Getulio Vargas, Escola de Administração de Empresas de São Paulo, São Paulo, 2020. Disponível em: https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/28989. Acesso em: 25 jul. 2022.

PIOVESAN, Márcia Franke. **A Construção política da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA**. 2002. 108 p. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) – Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2002. Disponível em: https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/5097. Acesso em: 25 jul. 2022.

PISTORIA, Michael Joseph. Membros da equipe de cuidados hospitalares. **Manual MSD Versão Saúde para a Família**, agosto 2021. Disponível em: https://www.msdmanuals.com/pt-br/casa/assuntos-especiais/cuidados-hospitalares/membros-da-equipe-de-cuidados-hospitalares. Acesso em: 29 dez. 2021.

PORTA, Rafael La et al. Law and Finance. **Journal of Political Economy**, v. 106, n. 6, p. 1113-1155, 1998.

PÓVOA, Angela Cristiane Santos; NAKAMURA, Wilson Toshiro. Homogeneidade versus heterogeneidade da estrutura de dívida: um estudo com dados em painel. **Revista Contabilidade & Finanças**, v. 25, n. 64, p. 19-32, 2014.

PRADO, Ana Raquel Mechlin; TEIXEIRA, Maria Luisa. O novo marco legal da ciência e da tecnologia no Brasil: uma análise à luz de Thomas Kuhn. In: **SEMEAD - Seminários em Administração**, novembro 2017. Disponível em: https://login.semead.com.br/20semead/anais/arquivos/737.pdf. Acesso em: 03 ago. 2022.

PSCHEIDT, Kristian Rodrigo. **Agência Nacional de Saúde Suplementar**: o Estado e a Saúde Privada no Brasil. Curitiba: Edição do Autor, 2014.

RAJAN, Raghuram G.; ZINGALES, Luigi. What do we know about capital structure? Some evidence from international data. **The Journal of Finance**, v. 50, n. 5, p. 1421-1460, 1995.

RAUH, Joshua D.; SUFI, Amir. Capital structure and debt structure. **The Review of Financial Studies**, v. 23, n. 12, p. 4242-4280, 2010.

REIGADA, Carolina Lopes de Lima; ROMANO, Valéria Ferreira. O uso do SUS como estigma: a visão de uma classe média. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 28, 2018. Disponível em: https://www.scielo.br/j/physis/a/6mk4Hsqvwf9kKcdfKFKMv6y/abstract/?lang=pt#. Acesso em: 25 jul. 2022.

REINDL, Johann; STOUGHTON, Neal; ZECHNER, Josef. Market implied costs of bankruptcy. **Available at SSRN 2324097**, 2017.

REIS, R.T.; GIL NETO, V. Análise das mudanças dos fatores determinantes da estrutura de capital em função do ciclo de vida de empresas brasileiras no período de 2008 a 2013. **Revista de Tecnologia Aplicada RTA**, v. 3, n. 1, p. 42-53, 2014.

RIBEIRO, José Mendes. Desenvolvimento do SUS e racionamento de serviços hospitalares. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 14, n. 3, p. 771-782, 2009. Disponível em: https://www.scielosp.org/pdf/csc/v14n3/13.pdf. Acesso em: 17 jan. 2022.

RIBEIRO, Wesllay Carlos; JULIO, Renata Siqueira. Direito e sistemas públicos de saúde nas constituições brasileiras. **Novos Estudos Jurídicos**, v. 15, n. 3, p. 447-460, setembro/dezembro 2010. Disponível em: https://periodicos.univali.br/index.php/nej/article/view/2768. Acesso em: 13 mar. 2022.

ROSS, Stephen A. et al. **Administração financeira**: versão brasileira de corporate finance. Porto Alegre: AMGH, 2015.

SACCOL, Amarolinda Zanela. Um retorno ao básico: compreendendo os paradigmas de pesquisa e sua aplicação na pesquisa em administração. **Revista de Administração da UFSM**, Santa Maria, v. 2, n. 2, p. 250-269, maio/agosto 2009. Disponível em:

https://periodicos.ufsm.br/reaufsm/article/view/1555. Acesso em: 25 jul. 2022.

SANTOS, Irailde Ferreira do; GABRIEL, Mariana; MELLO, Tatiana Ribeiro de Campos. Sistema único de saúde: marcos históricos e legais dessa política pública de saúde no brasil. **Humanidades & Inovação**, v. 7, n. 5, p. 381-391, março 2020. Disponível em: https://revista.unitins.br/index.php/humanidadeseinovacao/article/view/2964. Acesso em: 25 jul. 2022.

SKRONDAL, Anders.; RABE-HESKETH, Sophia. Multilevel and related models for longitudinal data. In: **Handbook of Multilevel Analysis**, primavera, Nova York, NY, 2008, p. 275-299.

STREBULAEV, Ilya A.; YANG, Baozhong. The mystery of zero-leverage firms. **Journal of Financial Economics**, v. 109, n. 1, p. 1-23, 2013.

TJDFT - Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. **Coronavírus**: Planos de Saúde devem prestar atendimento de urgência independentemente da carência. Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/abril/coronavirus-planos-de-saude-sao-obrigados-a-prestar-atendimento-de-urgencia-independentemente-de-carencia. Acesso em: 18 abr. 2022.

TREZEVANT, Robert. Debt financing and tax status: Tests of the substitution effect and the tax exhaustion hypothesis using firms' responses to the Economic Recovery Tax Act of 1981. **The Journal of Finance**, v. 47, n. 4, p. 1557-1568, 1992.

US Hospitals face liquidity crises as they treat the nation's Covid-19 patients. **PWC**. Disponível em: https://www.pwc.com/us/en/industries/health-industries/library/covid-hospital-liquidity-crisis.html. Acesso em: 18 abr. 2022.

VAN DE VEN, Andrew H. **Engaged Scholarship**: A guide for organizational and social research. Oxford: Oxford University Press on Demand, 2007.

WAITZBERG, Ruth et al. The structure and financing of health care systems affected how providers coped with Covid-19. **The Milbank Quarterly**, v. 99, n. 2, p. 542, 2021. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8241273/. Acesso em: 18 abril 2022.

WELCH, Ivo. Two common problems in capital structure research: The financial-debt-to-asset ratio and issuing activity versus leverage changes. **International Review of Finance**, v. 11, n. 1, p. 1-17, 2011.

WEST, Brady T.; WELCH, Kathleen B.; GALECKI, Andrzej T. **Linear mixed models: a practical guide using statistical software**. Flórida: CRC Press, 2014.